焦虑障碍（面向患者）资料库

广泛性焦虑 · 惊恐障碍 · 社交焦虑 · 特定恐怖症 · 场所恐惧 · 分离性焦虑

> **免责声明：**本资料库仅作健康知识科普与学习参考，**不能替代精神科医生的面诊、诊断与处方**， 不可用于自行确诊病情、增减或停用药物。出现身体或心理不适，请前往正规精神卫生中心或综合医院精神科/心理科就诊。 关键结论均以临床指南与权威资料为依据，并区分临床共识、研究结论、争议观点与个人体验；若资料内容与最新诊疗建议存在出入，以专业医生意见为准。

> **紧急情况：**若出现剧烈胸痛、胸闷、心悸、晕厥、呼吸困难（尤其首次发作），或出现伤害自己的念头，请立即拨打 **120**（急救）或 **110**（报警），也可拨打全国统一心理援助热线 **12356**（24 小时免费）。

版本：V0.1 ｜ 生成日期：2026 年 10 月
本 PDF 由同目录下 Markdown 资料库（10 个模块、39 篇内容）自动汇编生成。

目录

模块1：疾病正式名称与分类词条

1. 标准学名（ICD-11与DSM-5）
2. 子类型与子条目
3. 临床简称与常用别名
4. 易混淆名词区分
5. 历史名称

模块2：基础认知

1. 什么是焦虑障碍
2. 发病简单原理（通俗版）
3. 误区辟谣
4. 患病特点与可康复性

模块3：症状表现

1. 情绪症状
2. 躯体症状
3. 思维症状
4. 行为症状
5. 各亚型典型症状区分

模块4：诱因与高危因素

1. 生物学因素
2. 心理因素
3. 环境因素
4. 保护因素

模块5：就医与诊断指南

1. 就诊触发信号
2. 就诊科室与专业人员区分
3. 就诊前准备清单
4. 诊断流程与评估量表
5. 常见共病

模块6：治疗方案

1. 药物治疗
2. 心理治疗
3. 物理治疗
4. 治疗预期与目标

模块7：自我调节与日常康复实操

1. 急性焦虑与惊恐发作应急方法

2. 长期日常管理
3. 思维调整练习
4. 渐进式暴露练习
5. 放松练习

模块8：危机识别与求助资源

1. 需要紧急就医的危险信号
2. 国内心理危机热线与求助渠道
3. 复诊时机与联系医生

模块9：生活与社会支持

1. 与家人亲友沟通
2. 工作学习场景应对
3. 康复期常见困境

模块10：常见Q&A

1. 高频问答QA

模块 1

疾病正式名称与分类词条

1. 标准学名（ICD-11与DSM-5）

> 本页解释"焦虑障碍"这个大类在两套国际诊断体系（WHO 的 ICD-11 与美国精神医学学会的 DSM-5）里到底叫什么、编码是多少。**编码是医院统计、病历书写、医保对接用的内部编号，不是给你自我对号入座的清单，更不能替代医生面诊。** 你病历上的具体诊断，以接诊机构采用的版本和医生判断为准。

1.1 上位名称：两套体系怎么叫这一大类

焦虑障碍不是一个病，而是**一组**以过度恐惧、焦虑及相关行为紊乱为核心的精神障碍的总称。

项目	ICD-11（世界卫生组织，2018年生效、2022年起各国陆续使用）	DSM-5 / DSM-5-TR（美国精神医学学会，2013/2022）
上位类别英文名	Anxiety or fear-related disorders	Anxiety Disorders
中文规范译名	**焦虑或恐惧相关障碍**（简称"焦虑障碍"）	**焦虑障碍**
在整体分类中的位置	归入"精神、行为或神经发育障碍"大类下，与"心境障碍"并列成章	单独成章（第5章）
主要用途	国际健康统计、各国病历编码、医保与公共卫生对接	临床研究、学术交流、心理治疗与保险沟通常用

【临床共识】两套体系在"焦虑障碍包含哪些亚型"上几乎一一对应，但**名称、编码、病程要求略有差别。**同一位患者，在 ICD-11 病历上可能写"广泛性焦虑障碍（6B00）"，在美国体系资料里看到的是"Generalized Anxiety Disorder，300.02"——这不是两个病，是同一个东西的两种编号。

1.2 主要亚型的命名与编码对照表

下表按 ICD-11 浏览器（icd.who.int）现行编码核实整理：

亚型	ICD-11 编码	ICD-11 英文名	DSM-5 编码（ICD-9-CM）	DSM-5 英文名
广泛性焦虑障碍	**6B00**	Generalised anxiety disorder	**300.02**	Generalized anxiety disorder (GAD)
惊恐障碍	**6B01**	Panic disorder	**300.01**	Panic disorder
场所恐惧障碍	**6B02**	Agoraphobia	**300.22**	Agoraphobia
特定恐怖症	**6B03**	Specific phobia	**300.29**	Specific phobia
社交焦虑障碍	**6B04**	Social anxiety disorder	**300.23**	Social anxiety disorder (Social phobia)

亚型	ICD-11 编码	ICD-11 英文名	DSM-5 编码（ICD-9-CM）	DSM-5 英文名
分离性焦虑障碍	**6B05**	Separation anxiety disorder	**309.21**	Separation anxiety disorder

【研究结论】注意两个版本的**排序差异**：ICD-11 把"场所恐惧"放在"特定恐怖症"之前，DSM-5 则按"惊恐—场所恐惧—特定恐怖—社交焦虑—分离性焦虑—广泛性焦虑"的顺序排列。排序不同不代表轻重有别，只是分类思路差异。

1.3 几个容易被忽略的命名细节

- **"惊恐发作"（panic attack）本身不是一个独立诊断。**在 DSM-5 里，它只是一个"描述性标注"，可以出现在任何焦虑障碍（甚至抑郁障碍、躯体疾病）中——就像"发烧"是一个症状，不是一个病。【临床共识】
- **强迫障碍（OCD）、创伤后应激障碍（PTSD）、急性应激反应**在旧版本（DSM-IV/ICD-10）里曾被放在"焦虑障碍"门下；**DSM-5（2013）和 ICD-11 都把它们分出去单独立章**了。所以你在老资料里看到"焦虑障碍包含强迫症、PTSD"，那是旧分类，今天已不再这么归。
- **"混合性焦虑抑郁障碍"**是 ICD 体系里的一个过渡性条目，指焦虑和抑郁症状都不重、但混在一起让人难受的状态；DSM-5 不再单列，而由医生分别评估两种障碍的轻重。

1.4 这些编码是干什么用的（以及不是干什么用的）

编码的真实用途	编码不是用来做这些的
医院病案室统计本病种的数量、资源消耗	不是你在网上自测后给自己贴的标签
医保报销、DRG 病种分组、公共卫生上报	不是"严不严重"的等级——300.02 不比 300.29 重
医生之间、医院之间病历沟通的统一语言	不是保险买不买、单位招不招你的依据（隐私受法律保护）
科研入组、流行病学调查的统一口径	不是"得了就一辈子改不了"的烙印

【个人体验】很多患者第一次在病历本上看到一串数字编码，会紧张地拿手机查，越查越害怕。其实那串数字对你唯一的意义是：**医生知道该用哪一类治疗思路。**它不定义你是谁，也不预测你的未来。

1.5 本资料库后续条目怎么用这些名称

本资料库统一采用 **ICD-11 的中文规范名称**为主（因为它是中国现行病历与统计对接的版本），并在首次出现时附上 DSM-5 编码备查：

- 广泛性焦虑障碍（GAD）
- 惊恐障碍（伴/不伴场所恐惧）
- 社交焦虑障碍
- 特定恐怖症
- 场所恐惧障碍
- 分离性焦虑障碍

具体每个亚型长什么样、病程要求是什么，见同模块下一篇《2. 子类型与子条目》。

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器 · Anxiety or fear-related disorders
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）· Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders
- American Psychiatric Association：DSM-5 / DSM-5-TR 官方介绍
- 中华医学会精神医学分会：《中国焦虑障碍防治指南（实用简本）》相关章节
- 世界卫生组织：Anxiety disorders 疾病介绍页

2. 子类型与子条目

> "焦虑障碍"不是一个病，而是**一类病**。本页用一张大对照表，把临床上最常见的六种子类型——广泛性焦虑障碍、惊恐障碍、社交焦虑障碍、特定恐怖症、场所恐惧障碍、分离性焦虑障碍——的一句话特征、典型表现、病程要求一次说清。**有类似感受 ≠ 确诊**，最终诊断由精神科医生面诊做出。

2.1 六类亚型大对照表

亚型	一句话特征	典型表现（患者视角）	病程/频次要求（诊断参考）
广泛性焦虑障碍（GAD，6B00）	**对生活里大大小小的事，持续、过度、控制不住地担心**，像背景音一样关不掉	白天总提着一颗心，担心工作、家人健康、钱、天气；坐立不安、肌肉紧、睡不好；这种"心里悬着"的状态几乎天天有	焦虑和担忧**多数日子存在、持续 ≥ 6 个月**（成人）；明显影响功能
惊恐障碍（Panic disorder，6B01）	**反复、突发、不可预测的强烈惊恐发作**，加上"怕下一次再发作"的预期焦虑	突然几分钟内心慌、胸闷、窒息感、手抖、出汗、觉得自己要死了或要疯了；发作后几天内一直提心吊胆，怕再犯	**反复多次**惊恐发作，且之后**≥ 1 个月**持续担心再次发作或出现适应不良的回避（如不敢运动）
社交焦虑障碍（Social anxiety，6B04）	**对被人注视、被评价的社交场景强烈害怕**，怕自己出丑	怕当众说话、怕吃饭被看、怕打电话、怕和领导吃饭；明知过分但控制不住，常选择回避	恐惧/焦虑**持续 ≥ 6 个月**；显著影响社交、学业或职业功能
特定恐怖症（Specific phobia，6B03）	**对某一特定物体或场景（单一对象）强烈、持续的恐惧**	怕高、怕蜘蛛/血、怕坐飞机、怕打雷、怕打针；一看到/想到就心慌，立刻回避	恐惧/焦虑**几乎每次都出现、持续 ≥ 6 个月**；造成显著痛苦或功能损害
场所恐惧障碍（Agoraphobia，6B02）	**对"一旦发作很难逃、没人帮"的多种场景害怕并回避**	不敢挤地铁、不敢单独逛超市、不敢排队、不敢离家太远；有人陪能勉强，独自出门就紧张	对**≥ 2 种**场所（公共交通、开阔空间、密闭空间、队伍/人群、独自离家）恐惧，**持续 ≥ 6 个月**；常因此严重限制出行
分离性焦虑障碍（Separation anxiety，6B05）	**对与主要依恋对象分离过度、发育阶段不相称的害怕**	儿童：不肯上学、怕爸妈出事、做关于分离的噩梦；成人：离不开伴侣、独处就恐慌、依恋对象出门自己就心慌	症状**持续 ≥ 4 周（儿童/青少年）**；成人通常 ≥ 6 个月；显著影响功能

【临床共识】这六类**常常互相重叠**：一个惊恐障碍患者可能后来发展出场所恐惧（怕再次发作而不敢出门）；一个社交焦虑的人也可能同时有广泛性的担心。临床诊断时医生会区分"哪个是主要的、哪个是继发的"，并可能同时给出多个诊断。

2.2 特定恐怖症的五种小分类（DSM-5 / ICD-11 通用）

"特定恐怖症"不是一种病，而是按害怕对象分了五小类，**多数人只属于其中一类**：

小类	害怕的典型对象	举例
动物型	动物、昆虫	蜘蛛、蛇、狗、老鼠、蟑螂
自然环境型	自然现象或环境	高处（恐高）、风暴、深水、打雷
血液-注射-损伤型	见血、打针、拔牙、伤口	抽血就晕倒、见手术视频就脸色发白
情境型	特定人造场景	坐飞机、隧道、电梯、桥梁、驾驶
其他型	其他可能引发窒息或呕吐的场景	怕发出尖叫、怕当众呕吐、怕巨响（儿童）

【研究结论】血液-注射-损伤型有个特别之处：约 75% 的人**见血后会先心跳加快、随即血压下降、直接晕过去**（血管迷走性晕厥），这和其他恐怖症"一直兴奋"的反应相反。这一特点对判断要不要做暴露治疗很重要，但属于专业细节。

2.3 什么是"惊恐发作"（panic attack）——它不是一个独立诊断

【个人体验】很多人第一次惊恐发作时，**直接打 120 去急诊**：心跳像要从嗓子里蹦出来、胸口压着石头、喘不上气、手脚发麻、觉得"我马上就要死了/疯了/失控了"——但到医院一做心电图，结果基本正常。

【临床共识】惊恐发作是一组**突然达峰（10 分钟内达到最强烈）**的强烈恐惧/不适，伴随 ≥ 4 项躯体或认知症状（心慌、出汗、发抖、气短、哽咽感、胸痛、恶心、头晕、发冷/潮热、麻木、不真实感、怕失控、濒死感）。它可以**出现在任何焦虑障碍里**，也可能出现在抑郁障碍、躯体疾病甚至正常人身上（如第一次大量喝咖啡、熬夜后）。所以：

- 单次惊恐发作 ≠ 惊恐障碍；
- 只有"反复自发发作 + 持续 ≥ 1 个月担心再发作或出现不良适应行为"，才诊断为惊恐障碍（6B01 / 300.01）。

详细的急性特征与就医安全提示，见模块3《5. 各亚型典型症状区分》。

2.4 一个常见疑问："我到底属于哪一种？"

很多患者会拿着上面这张表逐行对，越对越糊涂。其实：

- **说不清的时候，不必硬给自己归类。**医生面诊时会通过问诊、病程、功能影响来判断；
- **"我同时符合好几种"很常见**，医生可能同时下两个诊断（如"惊恐障碍伴场所恐惧"）；
- **"我只是最近压力大、还没到 6 个月"**——这更可能是正常焦虑或适应反应，不一定是 GAD；
- **重要的是功能损害和痛苦程度**，而不是"我名字叫哪个病"。

【个人体验】患者最常说的一句话是："我管它叫什么，我只想知道怎么能不这么难受。"——这恰恰是对的方向：诊断名是医生沟通用的工具，**治疗才是你真正关心的事。**

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器 · Anxiety or fear-related disorders（6B00–6B05）
- American Psychiatric Association：DSM-5 焦虑障碍各亚型诊断标准
- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：CG113 Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management

- 世界卫生组织：Anxiety disorders 事实清单
- 中华医学会精神医学分会：《中国焦虑障碍防治指南（实用简本）》亚型章节

3. 临床简称与常用别名

> 在医院、科普文章、网络论坛和家人嘴里，"焦虑障碍"会被说成各种各样的名字。本页把**正式名 ↔ 俗称/旧称**一一对应起来，帮你听懂别人在说什么，也避免把"焦虑情绪"误当成一个诊断。

3.1 正式名 ↔ 临床常用简称/别名对照表

正式名称（ICD-11）	临床简称 / 英文缩写	常见俗称 / 旧译	备注
广泛性焦虑障碍	**GAD**（Generalized Anxiety Disorder）	焦虑症、广泛性焦虑、慢性焦虑	老百姓说的"焦虑症"多数其实指它
惊恐障碍	PD（Panic Disorder）	**惊恐症、急性焦虑症、惊恐发作**	"惊恐发作"本身是症状，不是诊断（详见 2.3）
社交焦虑障碍	SAD（Social Anxiety Disorder）	**社交恐惧症、社交恐惧**、社恐	"社恐"是网络流行语，程度不一，不等于诊断
特定恐怖症	Specific Phobia	恐惧症、**恐高症、幽闭恐惧、恐血症**、怕狗怕蜘蛛	按害怕对象再细分
场所恐惧障碍	Agoraphobia	**广场恐怖症、旷野恐怖**（旧译）	注意不是"怕广场"，而是怕"逃不掉、没人帮"的场景
分离性焦虑障碍	Separation Anxiety	儿童分离焦虑、恋家	成人也可诊断

3.2 几个特别容易误解的名字

① "焦虑症"到底指什么?

【临床共识】这是一个**不严格**的口头说法，医院正式病历上一般不会只写"焦虑症"三个字，而是写"广泛性焦虑障碍""惊恐障碍"等具体亚型。家人、网友说"我得了焦虑症"，**可能指 GAD，也可能只是最近焦虑情绪重**，不能从这三个字判断严重程度。

② "焦虑性神经症"——老一辈病历上的旧名字

在我国 **CCMD-3（《中国精神障碍分类与诊断标准》第三版，2001）** 时代，焦虑障碍被归在"**神经症**"门下，叫"焦虑性神经症"，再分"广泛性焦虑"和"惊恐发作"两型。这个命名今天已被 ICD-11 取代，但你可能在父母辈的老病历、或一些老医生口中听到。**它和今天的"焦虑障碍"是同一大类病**，不是两种病。

③ "广场恐怖" ≠ "怕广场"

Agoraphobia 的字面是"集市/广场恐惧"，但患者真正怕的不是广场本身，而是：**"万一我在人多、空旷、密闭、难逃脱的地方突然发作，没人帮我、逃不出去怎么办？"** 所以地铁、排队、独自逛超市、独自出门都

可能触发。旧译"广场恐怖"在今天的正式病历里多写为"场所恐惧障碍"。

④ "社恐" ≠ 社交焦虑障碍

【个人体验】网上很多人自称"社恐"——不爱热闹、聚会想躲、加微信要犹豫半天。这**大多数只是偏内向的气质或轻度社交焦虑**，不是病。

维度	一般"社恐"/内向	社交焦虑障碍（6B04）
内心体验	不喜欢社交，但真去了也能应付	一想到社交场景就强烈心慌、出汗、脑子空白
行为	主动选择独处	**被动回避**，明知没必要但控制不住
功能影响	不影响工作学习	不敢当众汇报、不敢请假、不敢接电话，影响职业发展
持续时间	可有可无	**≥ 6 个月**，几乎每次都发作

3.3 不是诊断名、但常被当成病名的词

下面这些词在日常中很常见，**它们描述的是一种状态或情绪，不是一个精神科诊断**：

说法	到底是什么	是不是诊断
焦虑情绪 / 焦虑状态	人在压力下的正常反应，或尚未达到诊断标准的亚临床焦虑	❌ 不是诊断
考前焦虑、演讲焦虑	针对特定事件的短暂焦虑反应	❌ 不是诊断
急性应激反应 / 适应障碍	重大生活事件后数天至数周内的焦虑、低落	✅ 是另一类诊断（不在焦虑障碍门下）
神经衰弱	我国旧诊断（CCMD-2 时代常见），ICD-11 已归入"传统医学病症"	❌ 今天基本不再单独使用
心脏神经症 / 神经循环衰弱	过去对以心慌胸闷为主诉、心脏检查正常者的叫法	❌ 旧称，今天多归入焦虑/躯体症状相关问题

【临床共识】"我最近焦虑"和"我得了焦虑障碍"是**两件事**。前者人人都有，后者是持续 ≥ 数月、显著影响功能的疾病状态。判断权在医生，不在这张表。

3.4 医院病历上可能出现的其他名字

- **"焦虑状态（待查）"**：医生初诊时还没定亚型，先写这个，复诊后再明确；
- **"XX 障碍伴焦虑特征"**：说明主要诊断是别的病（如抑郁障碍、睡眠障碍），同时有明显焦虑；
- **"焦虑/抑郁混合状态"**：两种症状都突出，ICD-11 里有"混合性焦虑抑郁障碍"条目；
- **"惊恐发作（急性）"**：单次发作的描述，不代表已经是"惊恐障碍"。

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器 · Anxiety or fear-related disorders
- American Psychiatric Association：DSM-5 Anxiety Disorders 章节

- 中华医学会精神医学分会：《中国精神障碍分类与诊断标准（CCMD-3）》历史沿革
- NICE：CG113 Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults
- 世界卫生组织：Anxiety disorders 事实清单

4. 易混淆名词区分

> "焦虑"这两个字，在生活里天天被用，在医学里却有严格边界。本页把最容易混淆的几组概念——正常焦虑 vs 病理性焦虑、焦虑 vs 抑郁、焦虑障碍 vs 精神病性障碍、惊恐发作 vs 心脏病发作、恐惧 vs 焦虑 vs 惊恐——一次分清。**目的不是让你自我诊断，而是减少"我是不是得了更可怕的病"这种不必要的恐慌。**

4.1 正常焦虑情绪 vs 病理性焦虑（最核心的一张表）

判别维度	正常焦虑情绪	病理性焦虑（达到疾病程度）
诱因	由明确的现实事件引起（考试、面试、体检前）	常常**没有明确诱因**，或诱因与反应强度完全不成比例
持续时间	事件结束后数小时至数天内缓解	几周、几个月甚至更久，**"事情过去了，心还悬着"**
强度	心慌、紧张，但能控制、能完成任务	强烈到失控：濒死感、瘫痪感、哭到喘不上气；或持续 24 小时"绷着"
功能损害	不影响吃饭、睡觉、工作	回避场景、请假、不敢出门、失眠、肠胃紊乱、无法集中
对威胁的判断	知道"这事确实重要，但我能应付"	**高估危险、低估自己**："万一……我就完了"
自我认知	"我紧张是正常的"	"我控制不住自己，我是不是要疯了"
可否被其他原因解释	可	不能用甲亢、贫血、药物、咖啡因、丧亲等完全解释

【临床共识】**焦虑本身是健康的、有进化意义的。**问题不在于"有没有焦虑"，而在于这套预警系统**是不是失灵了**——该响的时候不响，不该响的时候狂响，或者一直响个不停。

4.2 恐惧 vs 焦虑 vs 惊恐：三个词不是一回事

概念	面对的是什么	时间感	典型身体反应	举例
恐惧（Fear）	**当下、正在发生**的具体威胁	现在时	战或逃：心跳快、肌肉紧绷	迎面冲来一条狗
焦虑（Anxiety）	**未来、可能发生**的不确定威胁	将来时、持续背景音	紧张、坐立不安、睡不着	总担心"体检结果会不会有事"
惊恐（Panic）	**突然爆发、几分钟内达峰**的强烈恐惧浪潮	现在时、闪电式	心慌/窒息/濒死/失控感，10 分钟内最强	毫无预兆突然觉得"我要猝死了"

【个人体验】很多患者描述："恐惧是**眼前**有条蛇；焦虑是**总觉得屋里有蛇**；惊恐是**突然觉得蛇已经咬到我了**——但屋里其实什么都没有。"

4.3 焦虑障碍 ≠ 神经衰弱

- **神经衰弱（neurasthenia）**是 19 世纪末美国医生 Beard 提出的旧概念，在我国 CCMD-2（1989）里曾是最常用的诊断之一，表现为易兴奋、易疲劳、头痛、失眠、注意力差。
- **ICD-11 已经不再把它作为一个独立的精神障碍**，而是归入"传统医学病症"（约相当于"健康保健"类目下的一个条目）。
- 当年被诊断为"神经衰弱"的很多患者，**今天重新评估后更可能是：焦虑障碍、抑郁障碍、睡眠障碍、或慢性疲劳。**

【临床共识】如果你父母辈的病历上写着"神经衰弱"，不必觉得"我们家遗传了个老古董病"——它更像一个**被时代淘汰的笼统筐**，今天的医学已经能把里面装的东西分得更细、治得更准。

4.4 焦虑 ≠ 抑郁，但两者高度共病

维度	焦虑障碍	抑郁障碍
核心情绪	紧张、害怕、预感坏事	低落、空虚、兴趣下降
指向	**未来**——"万一……"	**过去/现在**——"我什么都不行"
能量水平	高唤醒：坐不住、心跳快、睡不着	低唤醒：起不来、不想动、睡不醒
自我评价	"我控制不住我自己"	"我这个人没价值"

【研究结论】**临床上约 50%–60% 的抑郁障碍患者同时有显著焦虑，约一半的焦虑障碍患者一生中会经历抑郁发作。** 两者像"硬币的两面"，共享神经生物学基础（5-羟色胺、去甲肾上腺素系统）和心理社会应激因素。所以医生有时会说"你这是焦虑抑郁混合状态"——**不是误诊，而是两种病常常同时来。**

4.5 焦虑障碍 ≠ 精神病性障碍（精神分裂症等）

这是患者最常自己吓自己的一点，必须说清楚：

维度	焦虑障碍	精神病性障碍（如精神分裂症）
现实检验力	**完整**——知道自己的担心过分、不真实	**受损**——坚信幻觉、妄想是真的（如"有人在害我"）
典型症状	心慌、紧张、担心、回避	幻听、妄想、思维混乱、情感淡漠
自知力	通常知道"我这是病"	往往不认为自己有病
会不会"变过去"	**不会**	——

【临床共识】**焦虑不会"变成"精神分裂症，也不会把人"逼疯"。** 惊恐发作时那种"我要疯了/失控了"的感觉，是**焦虑本身带来的恐惧情绪**，不是真的在发疯。如果你始终知道"我这些担心是过度的"，你就还在现实里。

4.6 惊恐发作 ≠ 心脏病发作（但首次必须排查）

维度	惊恐发作	真正的心脏急症
起病	**突然、数分钟达峰**	也可突发，但常有诱因（运动、情绪激动）
胸痛特点	多为**尖锐、位置游走、伴胸闷感**	多为**压榨样、胸骨后、放射至左肩/下颌**
伴随	手抖、出汗、手脚发麻、濒死感、喉咙紧	冷汗、面色苍白、晕厥、持续不缓解
缓解	**数十分钟内自行缓解**	不处理不会自行缓解
心脏检查	心电图、心肌酶通常正常	心电图/心肌酶有异常

【临床共识】**这条安全线必须划清**：第一次出现剧烈胸痛、胸闷、心悸、晕厥、呼吸困难，尤其伴**放射痛、冷汗、既往心脏病史、年龄>40**，**请先急诊或心内科排查躯体疾病**，不能一律自我归因为焦虑。但反过来，一旦医生已排除心脏问题、明确是惊恐发作，**它通常不直接致命**——反复被"我是不是马上要死"吓到，才是这个病折磨人的地方。

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器 · Anxiety or fear-related disorders
- American Psychiatric Association：DSM-5 Anxiety vs. Psychotic Disorders 章节
- NICE：CG113 Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults
- 世界卫生组织：Depression 与 Anxiety disorders 事实清单
- 中华医学会心血管病学分会：《惊恐障碍与心血管疾病鉴别诊断中国专家共识》相关文章

5. 历史名称

> 焦虑障碍今天的名字，不是一开始就有的。从 19 世纪末的"神经衰弱"、20 世纪中期的"心脏神经症/焦虑性神经症"，到 DSM-III（1980）首次把惊恐障碍独立出来，再到 DSM-5（2013）和 ICD-11（2018）把强迫症、PTSD 从"焦虑"里分出去——名字的每一次变化，都代表医学对这个病的认识更深了一层。本页用一条简明脉络帮你看懂"为什么我妈病历上的名字和我不一样"。

5.1 一张时间线看懂名字的演变

年代	代表性名称	谁在用	当时怎么理解这个病
1860s–1890s	**神经衰弱（Neurasthenia）**	美国医生 Beard 提出，全球风靡	认为是"现代文明病"：神经能量耗竭，表现为疲劳、失眠、心慌、头痛
1871	**焦虑性心脏病 / 达•科斯塔综合征（Da Costa's syndrome）**	美国内战军医 Da Costa	士兵中常见的心慌、胸痛、气短，当时归为心脏问题，今天看更像惊恐/焦虑
1890s–1950s	**心脏神经症、神经循环衰弱（Neurocirculatory asthenia）**	欧美内科、心内科	主观心慌胸闷但心脏客观检查正常；认为是心脏"神经官能症"
1930s	**弗洛伊德：焦虑性神经症（Anxiety neurosis）**	精神分析流派	把焦虑分为"现实焦虑"和"神经症性焦虑"，认为是被压抑的本能冲突
1980（DSM-III）	**首次把"惊恐障碍（Panic Disorder）"独立成章**	美国精神医学学会	决定性转折：惊恐发作不再是"广泛性焦虑的一种严重形式"，而是独立疾病，并第一次提出它有生物学基础（后来证实与遗传、蓝斑核有关）
1994（DSM-IV）	**"焦虑障碍"大类**，含惊恐、广场恐怖、社交恐怖、特殊恐怖、GAD、OCD、PTSD、急性应激	美国精神医学学会	把"恐怖症"和"焦虑症"合并为"焦虑障碍"大类
1992（ICD-10）	**"神经症性、应激相关的及躯体形式障碍"**（F40–F48），焦虑是其中一类	世界卫生组织	欧洲和中国长期沿用此分类，"神经症"这个筐还在
2001（CCMD-3）	**焦虑性神经症**，分广泛性焦虑和惊恐发作	中华医学会精神科分会	中国本土分类，老一代医生至今习惯用"神经症"
2013（DSM-5）	**焦虑障碍**单独立章，但**把强迫障碍（OCD）、创伤后应激障碍（PTSD）、急性应激障碍分出去**	美国精神医学学会	认识到 OCD、PTSD 的发病机制与典型焦虑不同，不应混为一谈
2018/2022（ICD-11）	**焦虑或恐惧相关障碍（Anxiety or fear-related disorders，6B00–6B05）**	世界卫生组织，2022 年起各国正式使用	与 DSM-5 基本对齐；"神经衰弱"从精神障碍目录消失，归入传统医学病症

5.2 三个关键转折点，为什么重要

转折点一：1980 年 DSM-III 把惊恐障碍"独立"出来

【研究结论】在那之前，心慌、濒死感、突然发作的患者被统称为"广泛性焦虑的严重形式"。但研究发现：**惊恐障碍有明显的家族聚集性、能被乳酸钠等物质诱发、对某些药物反应特殊**——它不是 GAD 加重版，而是另一个病。这个发现直接推动了后来惊恐障碍药物和心理治疗的发展，也让无数反复跑急诊、被当成"心脏病"的患者第一次得到了正确诊断。

转折点二：2013 年 DSM-5 把 OCD 和 PTSD "踢出去"

【临床共识】老版本里强迫症（反复洗手、检查）和创伤后应激（经历车祸、暴力后闪回）都算"焦虑障碍"。但越来越多证据显示：

- OCD 的脑环路（眶额叶-纹状体）和典型焦虑不同；
- PTSD 的核心是"创伤再体验+回避+高警觉"，机制也不一样。

把它们分出去，**不是病情变轻了，而是治疗更精准了**——OCD 现在有专门的暴露与反应预防（ERP）疗法，PTSD 有专门的延长暴露、眼动脱敏（EMDR）等。

转折点三：ICD-11 取消"神经症"这个筐

在中国，"神经症"这个词用了几十年（焦虑性神经症、抑郁性神经症、恐怖性神经症、神经衰弱……）。ICD-11 不再用"神经症"作为一个上位类别，而是把它们分别归入"焦虑或恐惧相关障碍"、"心境障碍"、"强迫及相关障碍"等。**对患者的实际意义是**：今天医生更倾向于告诉你"你是广泛性焦虑障碍"或"你是惊恐障碍"，而不是笼统一句"你是神经症"——后者听起来像"你想太多"，前者则指向明确的治疗路径。

5.3 为什么名字一直在变？这不是"折腾"

【个人体验】有患者抱怨："我十年前病历上写的是'神经衰弱'，五年前变成'焦虑性神经症'，现在又成了'广泛性焦虑障碍'，是不是医院在乱改？"

其实不是。名字的变化背后是：

1. **从"筐"到"病"**：过去把一堆说不清的症状都扔进"神经症"这个大筐；现在能按发病机制、治疗反应分成具体的病。
2. **从"想不开"到"有生物学基础"**：惊恐障碍、GAD 都有明确的遗传、神经环路证据，不再被认为是"意志力差"。
3. **从"内科问题"到"精神科问题"**：心脏神经症患者终于不用在心内科反复做检查，而是去精神科/心理科得到有效治疗。

【临床共识】**改名不是否定过去，而是医学在进步。** 如果你家人的老病历上写着"神经衰弱""心脏神经症""焦虑性神经症"，那不是病名错了，而是那个年代能给的最接近的标签——今天我们有了更准确、治疗更有效的名字。

5.4 一个安慰性的结尾

一百多年来，这个病换过七八个名字，被从心脏科、精神科、神经科、心理科来回转，被人骂过"装病""想不开""娇气"。但有一件事从来没变：

> **它是一种真实的、痛苦的、可以被治疗的疾病。**

名字会继续变，但你经历的那些心慌、失眠、担心、不敢出门，是真实的；你需要的帮助，也是真实的。

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-III (1980) 至 DSM-5-TR (2022) 分类演变
- 世界卫生组织：ICD-10 F40–F48 vs ICD-11 6B00–6B05 分类对照
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神障碍分类与诊断标准（CCMD-3）》历史版本
- NICE：CG113 Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults
- McLean CP, Anderson ER. *Symptom overlap between anxiety disorders: a historical perspective.* 相关综述

模块 2

基础认知

1. 什么是焦虑障碍

> 本页用最朴素的语言讲清楚三件事：**焦虑本身是好的；什么时候它变成了病；这个病在人群里到底有多常见。** 读完你不会立刻确诊，但能大致判断"我现在的状态，是该扛一扛，还是该去看医生"。本资料库不能替代精神科面诊。

1.1 先说好消息：焦虑本身是进化给你的保护

想象你是远古人类，在草原上走：

- 看到草丛晃动，**心里一紧、心跳加快、手心出汗**——这是焦虑在提醒你"可能有老虎"；
- 你停下来、握紧武器、决定绕路走——这种紧张让你**活了下来。**

【临床共识】**适度焦虑是人类最重要的生存工具之一。** 它让你在考试前复习、在开车时留神、在重要关系里用心。没有焦虑的人类，活不到今天。

问题从来不是"我有焦虑"，而是：

> **这套预警系统，是不是失灵了?**

失灵有三种典型方式：

1. **太灵敏**：草丛只是风吹过，警报却响了（过度恐惧）；
2. **关不掉**：老虎早就走了，警报还一直响（持续担心）；
3. **乱响**：你在办公室、在家里、在床上，毫无预兆地突然警笛大作（惊恐发作）。

1.2 正常焦虑 vs 病理性焦虑（一张表分清）

维度	正常焦虑	病理性焦虑（焦虑障碍）
有没有明确的事	有：考试、汇报、体检	常常没有，或事情早就过去了还在担心
强度	紧张但能应付	强烈到心慌、窒息、想逃、脑子空白
持续时间	几小时到几天	**几周、几月，甚至"天天如此"**
对你的影响	让你更认真准备	**让你回避、请假、睡不着、吃不下、不敢出门**
你自己怎么看	"这事是重要的"	"我知道没必要，但我控制不住"
能不能被别的解释	能（咖啡因、熬夜、甲亢等）	不能完全用其他原因解释

【个人体验】很多患者第一次描述自己的状态是："我不是怕某一件具体的事，我是**随时都在等下一件坏事发生。**"——这就是从"正常焦虑"滑向"广泛性焦虑"的典型感受。

1.3 焦虑障碍是"一类病"，不是一个病

在医学上，"焦虑障碍"不是你得了一种叫"焦虑症"的病，而是**一组以过度恐惧、焦虑和相关回避行为为核心的疾病**。常见的六类（详见模块1《2. 子类型与子条目》）：

- **广泛性焦虑障碍（GAD）**：天天担心，像背景噪音关不掉；
- **惊恐障碍**：毫无预兆地突然强烈发作，伴濒死感；
- **社交焦虑障碍**：怕被人评价、怕当众出丑；
- **特定恐怖症**：怕某一样具体的东西（高、血、飞虫、坐飞机）；
- **场所恐惧障碍**：怕"逃不掉、没人帮"的场景（地铁、超市、独自出门）；
- **分离性焦虑障碍**：怕和依恋的人分开，儿童常见，成人也可有。

【临床共识】**它们常常同时出现**：一个惊恐障碍的人后来可能怕出门（场所恐惧）；一个社交焦虑的人也可能天天担心自己表现不好（GAD）。医生会判断哪个是主、哪个是次，不影响"你需要帮助"这个结论。

1.4 这个病有多常见？——一组让你不孤单的数字

【研究结论】根据 **2019 年发表在《柳叶刀•精神病学》（Lancet Psychiatry）上的中国精神卫生调查（CMHS）**：

- 对全国 31 个省、32,552 名成年人的调查显示：**焦虑障碍是我国患病率最高的一类精神障碍**；
- **焦虑障碍 12 个月患病率为 4.98%**（即一年内约每 20 个成年人里就有 1 人患病）；
- 任何一种精神障碍的 12 个月患病率为 9.32%，终生患病率 16.6%；
- 女性患病率高于男性；
- 但**接受治疗的比例非常低**——这是我国精神卫生服务的一个现实。

放到全球看：世界卫生组织（WHO）数据显示，**焦虑障碍是全球最常见的精神障碍之一**，在青年、女性、慢性病患者、低收入群体中更高发。

【个人体验】知道"每 20 个人里就有 1 个"有什么用？——**让你不再觉得自己是异类**。你在地铁上、办公室里、小区楼下，身边就可能有正在经历同样事情的人，只是大家都不说。

1.5 那"我现在这样"算不算焦虑障碍？

不要给自己下诊断。但你可以先问自己几个问题（**任何一个答"是"，都值得去精神科/心理科谈一次**）：

- 我的紧张、担心、心慌，是不是**已经持续好几个月**了？
- 它是不是已经让我**睡不着、吃不下、没法集中、想回避某些事**？
- 我是不是**明知没必要，但就是控制不住**？
- 我是不是**反复跑急诊、反复做检查，但查不出明显问题**？
- 我身边人是不是开始说"你最近怎么变了"？

【临床共识】**不必等到"严重到撑不下去"才求助。** 焦虑障碍越早规范处理，恢复越快、越不容易慢性化。带着"我大概从什么时候开始、影响了哪些事"的记录，去一次门诊，比自己在网上查三个月有用得多。

参考来源

- 世界卫生组织：Anxiety disorders 事实清单
- Huang Y, Wang Y, Wang H, et al. **Prevalence of mental disorders in China: a cross-sectional epidemiological study.** *Lancet Psychiatry.* 2019;6(3):211-224. DOI: 10.1016/S22159-0(18)30598-X
- 北京大学第六医院：中国精神卫生调查（CMHS）成果发布
- NICE：CG113 Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults
- American Psychiatric Association：DSM-5 Anxiety Disorders 章节

2. 发病简单原理（通俗版）

> 你不需要懂医学术语才能理解自己为什么会这样。本页用一个生活比喻（**家里的烟雾报警器太灵敏**）+ 几个简单概念，把焦虑障碍的发病原理讲清楚。读完你会明白：**这不是你"想太多"，而是大脑里一套自动系统出了故障——就像一台偶尔误报的机器，是可以修的。**

2.1 主比喻：你脑子里的"烟雾报警器"太灵敏了

想象你家里装了一个烟雾报警器。它的任务是：真有火情时大声报警，让你和家人逃生。

- **正常的报警器**：只有真有烟、有火时才响；
- **太灵敏的报警器**：炒菜油烟大一点、烤面包糊一点、甚至蒸汽一下，它就"嗷——"地尖叫起来。

【临床共识】焦虑障碍，本质上就是你大脑里这个"烟雾报警器"——**负责探测危险的那套系统**——变得过度灵敏、阈值过低、还关不掉。

它会误报：
- 心脏跳快一点 → "我要猝死了！"（惊恐障碍）
- 开会要发言 → "所有人都在看我笑话！"（社交焦虑）
- 孩子晚回家 10 分钟 → "他一定出车祸了！"（广泛性焦虑/分离性焦虑）
- 地铁门一关 → "万一我发作了逃不出去怎么办？"（场所恐惧）

报警器没错，它在保护你；错的是它太敏感。 你不能靠"我命令你别响"让它安静下来——这就是为什么"想开点"没用。

2.2 警报是怎么拉响的？——战或逃反应

当大脑判断"有危险"时，会自动启动一套全身反应，叫**战或逃反应（fight-or-flight）**：

- 肾上腺素、去甲肾上腺素分泌 → 心跳加快、血压上升；
- 呼吸变快变浅 → 你觉得胸闷、喘不上气；
- 血液从内脏流向肌肉 → 手脚发凉、出汗、口干；
- 消化系统被抑制 → 胃肠不适、没胃口；
- 肌肉紧绷 → 肩颈酸痛、坐立不安；
- 瞳孔放大、注意力高度集中在"威胁"上 → 别的事都听不进去。

【个人体验】这就是为什么惊恐发作时你会**同时**感到心慌、胸闷、手抖、出汗、腿软、脑子一片空白——不是你同时得了 10 种病，而是**一套系统在全功率运转。**这套反应在真遇到老虎时救你的命；但在你只是坐在办公桌前时启动，就成了折磨。

2.3 报警器在大脑的哪个位置？——三个角色

不需要记名字，知道大概分工即可：

脑区（简化说法）	相当于	在焦虑里的角色
杏仁核	烟雾报警器的"探头"	探测到威胁就立刻拉响警报，反应比理性思考**快**得多
前额叶皮层	报警后的"核查员"	本来应该判断"这是油烟，不是火"，把警报关掉
海马	"记忆档案室"	记住以前哪里危险，让下次提前预警；但也会把"曾经吓过的场景"永远标红

【临床共识】焦虑障碍的人，**探头太灵敏（杏仁核过度激活），同时核查员又太弱（前额叶压不住警报）**。所以你明明理智上知道"地铁不会吃了我"，但身体还是在报警——**理智和身体用的是两套系统，你不能用一套命令另一套。**

这也解释了为什么光讲道理没用：你不能靠"想"让一个过度灵敏的报警器变迟钝；但通过治疗（药物调节神经递质、心理训练强化前额叶的"核查"能力），这套系统是可以被重新校准的。

2.4 哪些"化学信使"在参与？——三个名词够用了

神经递质（信使）	通俗作用	在焦虑障碍里发生了什么
GABA（γ-氨基丁酸）	大脑的"刹车系统"	刹车不灵 → 警报停不下来、睡不着、放松不下来
5-羟色胺（血清素）	调节情绪、焦虑、强迫的"调音师"	系统功能偏低或失衡 → 焦虑、反复担心、强迫思维
去甲肾上腺素	警报本身的"电池"	太活跃 → 心慌、警觉过高、易惊吓

【临床共识】市面上很多抗焦虑/抗抑郁药物，本质就是**帮大脑把这三个信使重新调到合适的水平**——让刹车灵一点、调音师稳一点、电池别一直满格。这也是为什么药物起效需要时间（通常 2–4 周）：它不是"镇静一下"，而是在帮你的系统重新校准。

2.5 那我是怎么"变成这样"的？——三个常见推手

报警器不会一天就变灵敏。通常是以下因素叠加：

① 遗传：你天生的探头就偏敏感

【研究结论】焦虑障碍有明显的家族聚集性。如果直系亲属有焦虑障碍、惊恐障碍，你患病的风险比一般人高。注意——**这是"风险高"，不是"必然会得"**。就像有的人天生皮肤敏感，不代表他一定过敏，只是需要更注意保护。

② 长期压力：电池一直在充电

持续几个月甚至几年的高压——高强度工作、亲密关系冲突、长期照顾病人、经济压力、孤独——会让去甲肾上腺素系统**长期处于高放电状态**。到后来，哪怕压力源已经消失，系统也回不到基线了。

【个人体验】很多患者回头看才发现："我不是某一天突然病的，我是**撑了好几年，最后一根稻草压下来**才崩的。"

③ 睡眠紊乱：报警器没有复位时间

睡眠是大脑每天"清缓存、调参数"的时间。长期失眠、熬夜、倒班，会让杏仁核的反应性**显著升高**——这是神经科学里被反复证实的发现。所以失眠和焦虑常常是**恶性循环**：越焦虑越睡不着，越睡不着越容易焦虑。

④ 还有这些配角：咖啡因、酒精、创伤经历、慢性病

- **咖啡因（咖啡、浓茶、能量饮料、奶茶）**：直接模拟警报电池，能诱发或加重惊恐；
- **酒精**：短期放松，但停药/醒酒后反弹更焦虑，长期会降低 GABA 刹车力；
- **创伤经历、被霸凌、重大丧失**：让海马把某些场景永久标红；
- **慢性病、甲亢、心律失常、贫血**等躯体问题：会伪装成焦虑，也会真的加重焦虑。

2.6 把这一页浓缩成三句话

1. **你不是"想太多"，是大脑里的烟雾报警器太灵敏了**——这是个可以修的硬件问题，不是道德问题。
2. **理智压不住身体，是因为它们用的是两套系统**——所以"想开点"没用，要靠治疗（药物调化学、心理调系统）。
3. **它不是一天形成的，也不会一天消失**——但通过规范治疗，多数人能把报警器调回正常灵敏度。

【临床共识】理解这些原理，不是让你去自我诊断或自我用药，而是让你在治疗时不再觉得"我这是矫情"——你经历的每一次心慌、每一次失眠、每一次不敢出门，都是这套系统在诚实地向你报告：**它需要被认真对待了。**

参考来源

- 世界卫生组织：Anxiety disorders 事实清单（含神经生物学机制简述）
- American Psychiatric Association：DSM-5 Anxiety Disorders 病因学章节
- NICE：CG113 Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Anxiety Disorders — 科普页
- 中华医学会精神医学分会：《中国焦虑障碍防治指南（实用简本）》病理生理章节

3. 误区辟谣

> 病耻感是焦虑障碍患者迟迟不就医、偷偷停药、独自硬扛的最大原因。外界一句"你就是想太多""放松点不就行了"，对正在发作的人来说，可能等于在说"你的痛苦是你自己的错"。本页用"误区 → 为什么错 → 正确认识"的对照表，把最常见的误解一次拆穿。**本页不替代面诊，用药与治疗请遵精神科医生医嘱。**

3.1 关于"性格"和"态度"

误区说法	为什么错	正确认识
"焦虑就是想太多，别想就行了"	焦虑发作时，杏仁核-前额叶环路已经过度激活，患者**理智上知道没必要，但身体和思维不受控**。这就像对一个发烧的人说"你别烧就行了"。【临床共识】	焦虑是病，不是态度。需要的是治疗，不是"别想"。
"你就是性格胆小、懦弱"	焦虑障碍和性格强弱没有必然因果。**许多高成就者、责任心极强、平时非常勇敢的人反而患病**——因为他们长期把压力扛在自己身上。【研究结论】	勇气和焦虑可以同时存在。带病坚持上班的人，往往是最有担当的人。
"意志力强点就能扛过去"	意志力可以用来"坚持就医、按时吃药、完成暴露练习"，但**不能用来让杏仁核不放电**。把康复变成对意志力的考验，本身就是一种伤害。	意志力要用在对的地方——找医生、规律复诊、完成作业，而不是硬扛。
"焦虑的人就是闲的、没事干"	恰恰相反，高压过劳、长期"必须撑住"的人更容易被击垮。很多患者在病发前是家里、单位里最可靠的那个人。	不是闲出来的，是撑太久了。休息和治疗不是偷懒，是止损。
"别人比你惨多了，你这算什么"	痛苦不能被比较。每个人的神经系统敏感度、压力累积、社会支持不同。"别人更惨"不会让你的心慌停下来，只会让你不敢求助。	我的痛苦是真实的，不需要和别人比才有资格求助。

3.2 关于药物

误区说法	为什么错	正确认识
"抗焦虑药一定上瘾，能不吃就不吃"	今天一线使用的抗焦虑/抗抑郁药（如 SSRI/SNRI 类）**不属于成瘾性物质**，不会越吃越渴求、越吃剂量越大。真正容易依赖的是老一代安定类（苯二氮䓬类），医生现在会严格限制其使用时长。【临床共识】	该用药时不用药，反而让病情慢性化、更难恢复。具体用哪种、用多久，由医生权衡。
"是药三分毒，西药伤肝伤肾，不如自己调理"	规范使用的精神类药物有明确疗效证据和长期安全性数据，医生会定期复查肝肾功能等指标。"纯中药无副作用"是话术，很多不明成分的"调理药"反而违规添加西药。【争议观点】	无论中西药，都要在医生指导下用；成分不明的偏方最危险。
"吃药就是逃避、就是软弱"	高血压、糖尿病都要长期服药，没人说那是逃避。焦虑障碍有明确的神经递质基础，药物是在帮大脑"重新校准"，和"软弱"无关。	该吃药就吃药，和骨折打石膏一样正常。

误区说法	为什么错	正确认识
"感觉好点了就可以自己停药"	症状缓解后通常仍需维持治疗一段时间，目的是预防复发。**突然停药可能出现撤药反应**（头晕、心慌、情绪反弹、失眠），复发率也明显升高。【临床共识】	停药时机让医生定，按计划慢慢减，不自己拍脑袋。
"药吃了没用，说明我没救了"	抗抑郁/抗焦虑药通常需要 **2–4 周才起效，4–6 周才能较充分评估。**一种效果不佳，还有换药、联合、心理治疗等多种方案。	给自己和医生一点时间；无效不是终点，是调整方案的信号。

3.3 关于"靠自己调整"

误区说法	为什么错	正确认识
"只要调整心态、想开点就能完全好"	轻中度焦虑，心理调整和生活方式有帮助；但中重度、反复惊恐、已经影响功能的，**单靠"调整心态"会延误治疗。**就像不能靠"调整心态"治愈骨折。【临床共识】	自我调节是辅助，不是替代。急性期先就医，稳定后再把自助方法加回来。
"旅游、散散心、休假就好了"	短期离开压力源可能缓解，但只要大脑的高敏感环路没调整回来，回去几周后往往复发。很多患者描述："出去玩那几天挺好的，一回家就又不对了。"	休假是休整，不是治疗；要同时做规范的心理/药物干预。
"运动、冥想就能治好，不用看医生"	运动、正念对轻中度焦虑和康复期有明确辅助作用，是指南推荐的长期管理手段；但**不能替代急性发作期的专业干预。**	把运动和正念放进你的康复计划里，但先去看医生。
"焦虑就是装病、是为了博取关注"	这是最伤人的误解。焦虑障碍的躯体症状（心慌、胸闷、出汗、失眠）是**真实的生理反应**，患者不是"装"，是战或逃反应真的在启动。【临床共识】	他/她不是在装，是真的难受。请认真对待。

3.4 关于"预后"

误区说法	为什么错	正确认识
"焦虑治不好，会跟一辈子"	焦虑障碍是所有精神障碍中治疗反应**比较好**的一类。多数人经过规范治疗（CBT 认知行为治疗 ± 药物）可以显著缓解、恢复功能。【研究结论】	它可能像哮喘、糖尿病一样需要长期管理，但不影响你正常生活、工作、爱人。
"焦虑久了会变成精神病（精神分裂）"	**不会。** 焦虑障碍的现实检验力是完整的，你始终知道自己的担心过度；精神分裂症的核心是幻觉、妄想、现实检验受损。两者没有转化关系。【临床共识】	焦虑不会把你"逼疯"。那种"我要疯了"的感觉，是焦虑本身的症状，不是真的在发疯。
"长期焦虑会把心脏/胃/脑子弄坏"	焦虑本身**不会直接把器官搞坏**——它是功能性的高唤醒，不是器质性损伤。但长期未治的慢性焦虑会通过升高皮质醇、血压、睡眠紊乱，**间接增加**心血管、消化问题的风险。【研究结论】	该治就治，不是为了"别把器官弄坏"，是为了生活质量。
"去看精神科很丢人、会留案底"	普通焦虑障碍的门诊/随访病历属于个人敏感医疗信息，受法律保护，不会进入所谓"案底"，与升学、就业的无犯罪记录无关。【临床共识】	看精神科和看内科一样正常。愿意为自己健康负责的人，是勇敢的人。

3.5 给正在读这一页的你三句话

1. **这不是你的错。** 焦虑障碍是有生物学基础的疾病，不是性格缺陷。
2. **求助是强者的行为。** 愿意挂号、愿意吃药、愿意复诊，本身就是在对抗疾病。
3. **"我撑不住了"不是软弱，是身体在提醒你该加油了。**

参考来源

- 世界卫生组织：Anxiety disorders 事实清单
- NICE：CG113 Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Anxiety Disorders 科普页
- 中华医学会精神医学分会：《中国焦虑障碍防治指南（实用简本）》
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：官网科普资源

4. 患病特点与可康复性

> 这一页写给"已经被诊断、或者怀疑自己可能是"的你。读完你会知道：**这个病通常什么时候找上门、它会不会好、好了之后会不会复发、复发了怎么办。** 核心结论先行：焦虑障碍是**可治疗、可康复**的疾病，多数人经过规范治疗能恢复到正常生活；它可能像哮喘、糖尿病一样需要长期管理，但不影响你工作、爱人、拥有想要的人生。

4.1 焦虑障碍通常有哪些特点

特点	具体表现	对你的意义
高发年龄偏早	多数亚型起病于**青少年晚期至 30 岁前**；社交焦虑、特定恐怖症往往儿童/少年期就有影子，成年后才明显影响功能	如果你从十几岁就"比别人容易紧张"，不是你的错，是发育阶段就埋下的
女性更多见	女性患病率约为男性的 **1.5–2 倍**	女性患者不要因为"怎么就我这样"自责
慢性化、波动性	不是一锤子买卖，而是**好一阵、坏一阵**：压力大、熬夜、咖啡因多、季节变换时容易加重	波动是这个病的本来面貌，不是"你又失败了"
常和失眠、抑郁、躯体不适绑在一起	约一半患者合并抑郁；几乎都有不同程度的失眠、心慌、肠胃不适	治疗时医生会一起评估，不是只盯着"焦虑"
就诊时往往已经拖了很久	很多人从第一次惊恐发作到真正去精神科，中间隔了 **数年**，反复在心内科、消化科、神经科打转	这不是你的错——是科普和就医渠道不够；但越早就医，恢复越快

【临床共识】**越早规范治疗，预后越好。** 慢性化的焦虑（尤其是持续多年的 GAD 和场所恐惧）治疗反应会慢一些，但仍然有效。

4.2 它会不会好？——预后的真实数据

【研究结论】综合 NICE 指南和《中国焦虑障碍防治指南》：

- **广泛性焦虑障碍（GAD）**：经过规范治疗（CBT ± 药物），约 **50%–70%** 的患者症状显著缓解，多数能恢复正常工作生活；
- **惊恐障碍**：是焦虑障碍中**治疗反应最好**的一类。CBT（含现场暴露）+ 必要时药物，**80%–90%** 的患者在数月内发作频率显著下降或停止；
- **社交焦虑障碍**：CBT（尤其是团体认知行为治疗）长期有效，约 50%–60% 患者功能显著改善；
- **特定恐怖症**：**暴露疗法**是特效药，多数人经过数次到十余次治疗可显著减轻恐惧；
- **场所恐惧障碍**：系统暴露治疗有效率高，但需要患者配合完成"难的作业"。

【个人体验】很多患者治疗 1–3 个月后回头看，会说同一句话："我早知道这样，就不该自己硬扛那两年。"——**恢复的速度，往往比你预期的快。**

4.3 会不会复发？——会，但可以管理

【临床共识】焦虑障碍是**容易复发**的疾病，但"复发"≠"治不好"，就像哮喘、糖尿病会反复，但通过长期管理可以不影响生活质量。

复发的常见诱因：

- 长期高压、重大生活变故（失业、失恋、家人生病）；
- 熬夜、倒班、咖啡因/酒精过量；
- 自行停药、减药；
- 季节变换（秋冬日照减少时，共病抑郁的人容易波动）；
- 躯体疾病（甲亢、心血管问题、手术前后）。

降低复发的有效做法：

1. **症状缓解后仍按医嘱维持治疗一段时间**（医生会根据发作次数、严重程度决定）；
2. **继续做 CBT 学到的思维调整、暴露练习**——这些是你的"长期工具箱"；
3. **管理睡眠、咖啡因、酒精**——这三件事对焦虑的影响，比多数人以为的大；
4. **识别早期信号**：当你发现自己开始"又不敢一个人出门""又半夜醒了担心"，**这是复诊信号，不是新的灾难**；
5. **稳定的社会支持**：哪怕只有 1–2 个懂你的家人或朋友。

4.4 一个重要的类比：把焦虑当"哮喘"管理

维度	哮喘	焦虑障碍
急性发作	接触过敏原后突然喘不上气	惊恐发作/急性焦虑
平时状态	不发作时和常人一样	缓解期可正常工作生活
长期用药	吸入激素维持	部分人需要小剂量药物维持
生活方式	避免过敏原、规律锻炼	管理睡眠、咖啡因、压力、暴露练习
复发	感冒、换季时可能发作	高压、熬夜、停药时可能复发
社会观感	没人说哮喘患者"软弱"	却有人说焦虑患者"想太多"——**这是偏见，不是事实**

【临床共识】**你不需要"治愈"焦虑，你需要学会和它共处。** 像哮喘患者学会"哪天该吸药、哪天该避免诱因"一样，你会慢慢知道自己的触发点、早期信号、应急方法。这种能力一旦学会，是一辈子的。

4.5 去羞耻化：你不是一个人在战斗

【个人体验】这是患者最常说的几句话，把它们留给你：

> "我以为只有我这样，后来发现同事、表姐、甚至那个看起来最精神的领导，都在吃同样的药。"
> "我花了三年才敢告诉我妈，她哭了，说'怎么不早说'。"

> "原来那些让我羞愧的症状——半夜心慌、不敢一个人坐地铁、开会前手抖——是几百万人和我一起经历的事。"

【临床共识】**病耻感是社会问题，不是你的问题。** 你不需要为一种疾病道歉，就像你不会为感冒道歉一样。愿意面对它、治疗它、慢慢康复的人，值得被尊重——包括被你自己尊重。

4.6 给你的三句话

1. **多数人会好起来，你也是。** 焦虑障碍是治疗反应最好的精神障碍之一。
2. **复发不代表失败。** 像哮喘一样管理它，而不是被它吓退。
3. **求助是勇敢，不是软弱。** 你已经在看这份资料了——这就是走向康复的第一步。

参考来源

- NICE：CG113 Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management
- 世界卫生组织：Anxiety disorders 事实清单
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Anxiety Disorders — Facts & Statistics
- 中华医学会精神医学分会：《中国焦虑障碍防治指南（实用简本）》预后与复发预防章节
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：官网科普资源

模块 3

症状表现

1. 情绪症状

> 这一页写给"我明明说不清楚哪里不对，但就是心里一直不踏实"的你。焦虑障碍的情绪症状，不是"难过"，而是一种**持续的、没来由的、关不掉的紧绷和害怕**。读它不是为了让你给自己确诊，而是帮你把那种"我说不出来的感觉"翻译成医生能听懂的话。本资料库不替代面诊。

1.1 核心情绪体验：五种最常见的感受

① 持续的紧张不安（"心里一直悬着"）

【个人体验】不是遇到具体的事才紧张，而是**从早上醒来那一秒开始，心里就像悬着一块石头**。没什么大事，但就是放松不下来。看电视、吃饭、和人聊天，表面上没事，内里那根弦一直绷着。到了晚上，反而更累。

② 莫名的恐惧（"不知道在怕什么，但就是怕"）

【个人体验】和"怕黑、怕高"这种具体的怕不一样。它是一种**弥漫性的、说不清对象的怕**——像空气里有什么危险，你抓不到、躲不开。很多患者描述："我知道我家很安全，但我就是一直觉得会出事。"

③ 预感灾难（"万一……怎么办"）

【个人体验】哪怕一件小事，脑子也会自动跳到最坏的结局：

- 孩子晚回家 10 分钟 → "他是不是出车祸了？"
- 体检报告还没出 → "我是不是得了绝症？"
- 同事今天没回我微信 → "我是不是得罪他了、工作是不是保不住了？"
- 心跳快了一下 → "我是不是要猝死了？"

这不是"想太多"，而是**大脑自动在跑最坏剧本**，而且你停不下来。

④ 易烦躁、易怒（"一点就着"）

【个人体验】很多患者（尤其是男性）不表现为"害怕"，而是**没耐心、易怒**：家人一句话不对就烦、堵车就火大、看谁都不顺眼。事后又后悔——"我怎么变成这样了？"

【临床共识】在临床上，**易激惹（irritability）本身就是焦虑障碍的核心情绪症状之一**，尤其在儿童、男性、老年人中更常见。不要把它简单理解为"脾气差"。

⑤ 等待性忧虑（"越等越慌"）

【个人体验】最折磨人的不是事情本身，而是**等结果的那段时间**：等面试通知、等体检报告、等医生复诊、等家人的航班。等待期间，心慌、睡不着、反复看手机、坐立不安——事情真来了，反而可能平静下来。

1.2 情绪症状自查清单（可打印）

> 用法：最近 4 周，每天在心里打勾。**如果多项"几乎每天都有"，并且已经让你觉得撑得辛苦，请考虑就医。**

情绪症状	患者典型描述	最近 4 周出现频率
心里一直悬着、放松不下来	"像有块石头压着，不知道在等什么"	□ 几乎每天 □ 有时 □ 很少
没来由的害怕、不踏实	"空气里都像有危险"	□ 几乎每天 □ 有时 □ 很少
自动想最坏结果	"万一……怎么办"在脑子里打转	□ 几乎每天 □ 有时 □ 很少
易烦躁、对家人没耐心	"一点小事就想发火"	□ 几乎每天 □ 有时 □ 很少
等待时特别慌	"等消息、等结果比事情本身还折磨人"	□ 几乎每天 □ 有时 □ 很少
预感有坏事要发生	"说不上来，但就是觉得要出事"	□ 几乎每天 □ 有时 □ 很少
对以前喜欢的事也提不起劲	"什么都没意思，就只想安心"	□ 几乎每天 □ 有时 □ 很少
情绪一上来就想哭/想逃	"胸口堵得慌，想找个地方躲起来"	□ 几乎每天 □ 有时 □ 很少

1.3 这些情绪和"抑郁情绪"有什么不一样?

维度	焦虑的情绪	抑郁的情绪
指向	**未来**——"万一……"	**过去/现在**——"我完了"
基调	紧张、害怕、提心吊胆	低落、空虚、没希望
能量	高——坐不住、心跳快	低——不想动、起不来
自我评价	"我控制不住自己"	"我这个人没价值"

【临床共识】**两者常常同时来**（约一半患者共病）。但焦虑的情绪核心是"怕"，抑郁的核心是"丧"。医生面诊时会分别评估，你不必自己分清"我到底是哪种"——**把你的感受原原本本告诉医生就好。**

1.4 为什么你"说不清楚"？——这很正常

【个人体验】很多患者第一次坐到医生面前，张了张嘴，却不知道从何说起："我就是……心里不踏实。""我也说不上来哪儿不对。""我好像一直都这样。"

这不是你表达能力差。焦虑障碍的情绪症状本身就有**弥漫性、背景化**的特点——它不是某一件具体的事，而是你整体状态的底色。医生见得多，他会通过一系列问题帮你把它梳理出来。

就诊前你可以准备的：

- 这种感觉大概从什么时候开始的？（半年前？几年前？）
- 一天里什么时候最重？（早上？睡前？等待时？）
- 最近有没有什么大事发生？（换工作、搬家、家人生病？）
- 它影响你做哪些事了？（不敢出门？睡不着？容易发脾气？）

【临床共识】**不必等到"严重到说不出来"才就医。** 只要你已经觉得"我这样很久了、活得很累"，就值得去精神科或心理科谈一次。

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-5 GAD / Panic Disorder 情绪症状诊断标准
- NICE：CG113 Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults
- 世界卫生组织：ICD-11 · Generalised anxiety disorder (6B00)
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Anxiety Disorders 科普页
- 中华医学会精神医学分会：《中国焦虑障碍防治指南（实用简本）》症状学章节

2. 躯体症状

> 这是**绝大多数患者最先感受到、也最容易被吓住**的一组症状。心慌、胸闷、气短、手抖、出汗、头晕、肠胃不舒服、肌肉紧绷、失眠、疲惫、尿频……它们像真的得了心脏病、胃病、甲亢一样，但跑到心内科、消化科查了一圈，结果都"基本正常"。
>
> 这一页要做两件事：①把焦虑引起的躯体不适系统列出来，让你知道"原来这些都是焦虑的表现"；②**划一条安全红线**——第一次出现剧烈胸痛、胸闷、心悸、晕厥、呼吸困难，尤其伴放射痛、冷汗、既往心脏病史，**必须先急诊或心内科排查躯体疾病**，不能一律自我归因为焦虑。本资料库不替代面诊。

2.1 为什么焦虑会引起这么多躯体不适?

【临床共识】焦虑时大脑启动"战或逃反应"，肾上腺素、去甲肾上腺素大量分泌，全身的血管、肌肉、呼吸、消化、汗腺全部被调动起来。**这些反应在原始人遇到老虎时救他们的命；但在你只是坐在办公室、躺在床上时启动，就变成了让人难受的躯体症状。**

关键的一点是：**这些症状是真实的生理反应，不是"装的"**。你心跳真的快了、手真的抖了、胃真的拧着——只是它们的来源是过度敏感的神经系统，而不是器官本身坏了。

2.2 焦虑最常见的躯体症状清单（按系统分类）

① 心血管系统（患者最常跑急诊的一组）

症状	患者典型描述
心慌、心悸	"心跳像要从嗓子里蹦出来""能感觉到自己的心在胸口砰砰跳"
心跳重、漏跳感	"心脏好像停了一拍""重重地撞一下"（多为早搏感）
胸闷、胸口压迫感	"胸口像压了块石头""喘不上气"
胸痛（位置常游走、尖锐）	"左胸下方刺痛一下""说不上来哪儿疼，就是不对劲"
血压短暂升高	焦虑发作时自测血压偏高，缓解后回落

② 呼吸系统

症状	患者典型描述
气短、窒息感	"像被人捂住嘴""总觉得吸不够气"
过度换气	呼吸又快又浅，接着手脚发麻、嘴唇发麻（呼碱）
喉咙哽噎感	"喉咙像堵了个东西，咽不下去"（常被当成咽炎/梅核气）

③ 神经与运动系统

症状	患者典型描述
手抖、嘴唇抖	"端杯子、签字时手控制不住地抖"
出汗（手心、全身）	"手心一直湿的""半夜醒来一身冷汗"
头晕、头重脚轻	"脑袋发飘""像踩在棉花上""要晕倒但从没真晕过去"
头皮发紧、头痛	"头上像箍了个紧箍咒"（紧张性头痛）
肌肉紧绷、酸痛	"肩颈硬得像石头""后背一直紧着"
不真实感（depersonalization）	"像在看电影""感觉自己不像自己"

④ 消化系统

症状	患者典型描述
口干	"嘴里一直干，喝水也不解渴"
吞咽困难	"咽东西总觉得卡一下"
胃部不适、恶心	"胃里拧着""一紧张就想吐"
腹胀、肠鸣、腹泻	"一要出门就想上厕所"（肠易激常见）
食欲下降	"心里一发紧，饭就吃不下"

⑤ 泌尿生殖系统

症状	患者典型描述
尿频	"越紧张越想上厕所""刚出来又想进去"
月经紊乱（女性）	焦虑期月经提前、推后、痛经加重
性功能下降	紧张导致性欲降低、勃起/高潮困难

⑥ 睡眠与精力

症状	患者典型描述
入睡困难	"躺下脑子就开始放电影，两小时睡不着"
易醒、早醒	"凌晨三四点醒了，再也睡不着，开始想事"
多梦、噩梦	"一宿都在跑、被追、赶不上车"
疲惫、没力气	"睡了跟没睡一样，早上起来更累"
易惊醒	"一点声音就跳起来"

2.3 【安全红线】这些躯体症状必须先排除躯体疾病

【临床共识】**焦虑会引起真实的躯体不适，但躯体疾病也会伪装成焦虑。** 第一次出现下列情况，请**先急诊或相应内科排查**，不能直接归因为"我就是焦虑"：

你的症状	需要排查的躯体疾病	建议挂的科
突发剧烈胸痛、压榨感、放射到左肩/下颌/后背，伴冷汗、濒死感	**急性冠脉综合征、心肌梗死**	**急诊、心内科**
心慌、心跳极快（>120次/分）、不规则、持续不缓解	**心律失常、房颤、室上速**	急诊、心内科
胸闷、气短、咳粉红痰、不能平卧	**心衰、肺栓塞**	急诊
头晕、晕厥、说话含糊、一侧肢体无力	**脑卒中（中风）**	**急诊（120）**
体重明显下降、心慌、怕热、手抖、凸眼	**甲状腺功能亢进**	内分泌科
头晕、站起来眼前发黑、乏力、面色苍白	**贫血、低血压**	内科、血液科
反复发作的位置性头晕（翻身、起床时天旋地转）	**耳石症、梅尼埃病**	耳鼻喉科、神经内科
慢性咳嗽、气短、运动耐量下降	**哮喘、慢阻肺**	呼吸科
低血糖、糖尿病前期（心慌、手抖、出汗、饿）	**血糖异常**	内分泌科
持续头痛、晨起加重、伴呕吐、视力变化	**颅内占位、高血压急症**	神经内科、急诊

【临床共识】**特别强调**：如果你是第一次发生"剧烈胸痛 + 濒死感 + 持续不缓解"，**请立刻打 120 或去急诊**，不要按"惊恐发作"自己扛。等医生做完心电图、心肌酶、必要时影像检查，**排除了心脏急症**之后，再考虑焦虑的诊断——这才是对自己负责。

但反过来：**一旦医生已经系统排查过、明确告诉你心脏没问题，以后再发作时你就知道"这是焦虑，不是猝死"**——这种"被排除过"的确定感，本身就能大幅降低发作时的恐惧。

2.4 焦虑 vs 需要排查的躯体疾病——快速对照

维度	焦虑引起的躯体不适	真正的躯体疾病
发作诱因	常在安静、睡前、压力大时出现；也可毫无预兆	常与运动、情绪激动、特定体位相关
持续时间	数分钟到数十分钟自行缓解；或持续"隐隐不舒服"	不处理通常不自行缓解
对检查的反应	心电图、心肌酶、甲功、影像**基本正常**	检查有异常（心电图改变、甲功升高、贫血等）
伴随	同时有手抖、出汗、喉咙紧、濒死感、怕再发作	症状更"单一"、有疾病特征（如放射痛、咳血）
体位/呼吸影响	过度换气时手脚发麻；缓慢呼吸可缓解	体位变化不改变，缓解药（硝酸甘油）有效

【个人体验】很多患者跑了两三年急诊、做了一堆检查，最后被急诊医生建议"去精神心理科看看"。那种感觉一开始是抵触的——"我明明是心脏疼，为什么让我去看心理？"但当他们真的被诊断为惊恐障碍、开始规范治疗后，回头才发现：**原来这两三年反复检查出来的"基本正常"，本身就是答案。**

2.5 患者最常问的几个问题

Q1：我心慌得这么厉害，会不会猝死？
【临床共识】**单纯惊恐发作本身不会直接致命。**它是神经系统的过度放电，不是心脏的器质性故障。但前提是——**你已经由医生排除了心脏疾病。**没排除之前，请先去查。

Q2：焦虑会不会把我的心脏/胃/脑子"弄坏"？
焦虑本身不直接损伤器官。但**长期未治的慢性焦虑**会通过持续升高的皮质醇、血压、睡眠紊乱，间接增加心血管、消化问题的风险。所以治疗的意义不仅是舒服，也是保护长期健康。

Q3：我这些症状是不是"装"的？
不是。 你的心跳、出汗、手抖、胃肠反应都是真实的生理反应。只是它们的"总开关"（杏仁核-前额叶环路）出了故障，而不是某个器官坏了。

Q4：为什么我查了一圈都正常，但就是难受？
这恰恰是焦虑障碍（尤其躯体症状突出的 GAD 和惊恐障碍）的典型表现。医生需要排除所有"会装成焦虑"的躯体疾病后，才能下诊断。多跑几次内科不是浪费，是必要的鉴别过程。

2.6 给你的一句话

> **你的身体在诚实地向你报告"我太累了"。** 心慌、胸闷、失眠、肠胃拧着，不是你在装病，也不是器官在坏——是那套保护你的系统，太想保护你了。先让医生帮你把"真的病"排除掉，剩下的，我们一起学怎么让它安静下来。

参考来源

- 世界卫生组织：Anxiety disorders 事实清单
- NICE：CG113 Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults
- 中华医学会心血管病学分会：《惊恐障碍与心血管疾病鉴别诊断中国专家共识》
- 中华医学会神经病学分会：《头晕/眩晕诊疗多学科专家共识》
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Anxiety Disorders — Physical symptoms
- 中华医学会精神医学分会：《中国焦虑障碍防治指南（实用简本）》

3. 思维症状

> 如果说躯体症状是焦虑"怎么感受"，思维症状就是焦虑"怎么想事"。它们不像心慌那样让你立刻察觉，但**恰恰是把焦虑越拖越重的那只隐形推手**。读完你会明白：为什么你明明知道"没必要"，却还是控制不住地往坏处想；以及这些思维偏差是可以被识别和练习调整的。本资料库不替代面诊。

3.1 焦虑障碍最典型的思维特征

① 反复担忧（uncontrollable worry）

【个人体验】不是想一次就完，而是**同一个念头在脑子里反复重播**：体检报告、领导那句话、孩子安全、自己的身体……像收音机卡在同一个频道，你想换台，换不掉。

【临床共识】这是广泛性焦虑障碍（GAD）的**核心思维症状**。它和"操心"的区别在于：**过度、持续、控制不住、影响功能**。DSM-5 要求这种担忧"多数日子存在、持续 ≥ 6 个月"。

② 灾难化（catastrophizing）

【个人体验】大脑自动从"有一点风险"跳到"最坏结局"，而且**中间没有过渡**：

- 咳嗽两声 → "我是不是得肺癌了？"
- 心跳快一下 → "我马上要猝死"
- 同事没回微信 → "我是不是要被开除了"
- 孩子晚回家 → "一定是出车祸了"

不是你故意往坏处想，是**大脑的"默认播放列表"只存了最坏那一集**。

③ 控制不住地胡思乱想（rumination）

【个人体验】躺下以后最明显：**脑子开始自动放电影**——白天说过的一句话、三年前的一个尴尬瞬间、明天可能发生的事、万一……万一……越想越清醒，越想越心慌。

④ 注意力难集中（brain fog）

【个人体验】书看了三页，不知道在说什么；开会听着听着，思绪飘到"我心跳是不是又快了"；明明在工作，脑子里那台后台程序一直在跑，前台就卡得不行。

【临床共识】这不是"变笨了"，而是**杏仁核抢占了前额叶的认知资源**——你的大脑在全力以赴"扫描危险"，自然没剩下多少带宽给别的事。

⑤ 非黑即白（全或无思维）

【个人体验】事情只要有一点不完美，就等于"全完了"：报告写错一个字 = "我能力不行"；聚会有一刻尴尬 = "所有人都讨厌我"；症状今天重了一点 = "我永远好不了"。

⑥ 高估危险、低估自己

思维偏向	内心独白
高估危险	"这件事出事的概率是 99%"（实际可能 <1%）
高估威胁严重性	"万一发生，我就完了、活不下去"
低估自己应对能力	"我肯定撑不住、会失控、会疯掉"
低估世界的安全性	"地铁/飞机/医院 = 危险的地方"

【研究结论】这四条思维偏差是焦虑障碍的**核心认知特征**，也是 CBT（认知行为治疗）要矫正的主要目标。它们不是你"想不开"，而是大脑在焦虑状态下的系统性扭曲——就像一副度数配错的眼镜，看什么都歪。

3.2 思维偏差清单（可打印、可对照）

> 用法：最近一个月，你出现过下面哪些想法？勾选后，试着在右边写下"更客观的版本"。

思维偏差类型	典型内心独白（举例）	我有没有过（打勾）	更客观的版本（自己写）
灾难化	"心跳快一下 = 我要猝死"	□	心跳快可能是咖啡/紧张，医生说过我心脏没事
高估危险	"坐飞机 = 很危险"	□	飞机是最安全的交通方式之一
高估后果	"汇报出错一次 = 我会被开除"	□	一次失误不代表整体，领导也常出错
低估应对	"万一发作，我会失控、会疯"	□	我已经发作过很多次，都自己缓过来了
非黑即白	"一件事没做好 = 我全完了"	□	大部分事还是完成了
预测未来	"我知道这次面试肯定过不了"	□	结果还没出来，我只是焦虑
读心术	"他没表情，一定是讨厌我"	□	他可能只是累了，我无法知道
应该陈述	"我不应该紧张，我必须一直冷静"	□	紧张是正常反应，不代表我失败
情绪推理	"我觉得慌，就说明真有危险"	□	慌是我的症状，不是事实

【临床共识】**这份清单不是让你批判自己"怎么又这么想"**，而是让你练习"看见它"。CBT 的第一步从来不是"纠正想法"，而是"先识别出我现在正在用哪种偏差想问题"。

3.3 这些思维和抑郁的思维有什么不同?

维度	焦虑的思维	抑郁的思维
指向	**未来的、可能的威胁**	**过去的失败、现在的无价值、未来的绝望**
核心问题	"万一……怎么办？"	"我已经完了/没有希望了"

维度	焦虑的思维	抑郁的思维
时间感	等结果、等下一次发作	反刍过去、看不到未来
对自己的评价	"我控制不住我自己"	"我这个人没价值"
典型内容	健康、安全、他人评价、失控	自责、内疚、无意义、自杀念头

【个人体验】很多患者描述："焦虑的脑子像**随时在等另一只鞋掉下来**；抑郁的脑子像**已经掉下来了，捡都不想捡**。"——这个比喻很准确。

3.4 一个重要的安全提示

【临床共识】焦虑的思维症状**不会**让你"变成精神病"、不会让你"真的疯掉"。那种"我要失控了、要疯了"的念头本身，是惊恐发作的典型认知症状，**不是你真的在丧失现实检验力。**

判断你是否还在现实里，有一个简单标准：

- 你**知道**自己的担心是过度的、不合理的 → 你在现实里，这是焦虑；
- 你**坚信**自己的担心是真的、别人怎么劝都不信（如"真的有人在害我"）→ 这是另一种情况，需要尽快就医。

3.5 给你的一句话

> **你的大脑在过度工作，但它不是坏了，是"误报"太多。** 把这些思维偏差认出来，就像在雾里看见了路标——你不会立刻走出雾，但你已经知道雾在哪了。具体怎么调整，见模块7《思维调整练习》。

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-5 GAD 认知症状诊断标准
- NICE：CG113 Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults
- 世界卫生组织：ICD-11 · Generalised anxiety disorder (6B00)
- Beck AT. *Cognitive Therapy and the Emotional Disorders.* 认知行为治疗经典著作
- 中华医学会精神医学分会：《中国焦虑障碍防治指南（实用简本）》认知治疗章节

4. 行为症状

> 焦虑不只是"心里想""身体难受"，它还会**改变你做事情的方式**——回避某些场景、反复确认、拖延、坐立不安、做一些"安全行为"。这一页讲清楚这些行为是什么、为什么它们短期舒服却长期加重焦虑，以及你可以怎么一点点松动它们。本资料库不替代面诊。

4.1 最常见的行为表现

① 回避行为（avoidance）

【个人体验】最典型的表现：**能不去就不去、能躲开就躲开。**

- 怕惊恐发作 → 不敢一个人出门、不敢坐地铁、不敢去人多的地方；
- 怕当众出丑 → 不发言、不参加聚餐、不接陌生电话；
- 怕高/怕飞虫/怕血 → 绕路、换工作、取消旅行；
- 怕"万一身体出问题" → 不运动、不喝咖啡、不看任何健康信息。

【临床共识】**回避是焦虑障碍最核心、最需要被干预的行为。** 它短期让你安全，但长期让你越来越觉得"那个地方/那件事真的很危险"——因为你从来没机会验证"其实我去了也没事"。

② 反复确认 / 求保证（reassurance-seeking）

【个人体验】反复去医院做检查、反复问家人"你说我是不是没事""孩子到家了吗回个微信"、反复查手机、反复量血压心率、反复锁门、反复检查煤气。

【个人体验】有患者描述："我明知道刚量过血压，但过 10 分钟不量，心就慌。"

【临床共识】这种行为短期能缓解不安，但**每一次确认都在悄悄告诉大脑"你不确认就不行"**，让下一次的焦虑来得更快。

③ 安全行为（safety behaviors）

为了"万一发作时能撑住"，你发展出一些**必须随身携带、必须有人陪、必须坐固定位置**的习惯：

- 出门必须带药、带水、带手机满电；
- 去人多的地方必须有人陪；
- 坐车必须坐靠窗/靠门的位置；
- 不喝任何含咖啡因的东西；
- 旅行必须离医院近。

这些行为本身不是坏事，但**当你觉得"没有它我就一定不行"时，它就成了焦虑的拐杖**——你越依赖，越觉得自己走不了路。

④ 拖延（procrastination）

【个人体验】不是懒，是**一想到那件事就心慌**，所以拖到最后一刻：不回邮件、不预约体检、不和领导谈加薪、不处理那个一直绕着你的问题。拖延短期避开了焦虑，但事情一直在那儿，焦虑也一直在。

⑤ 坐立不安（psychomotor agitation）

【个人体验】抖腿、转笔、来回走、不停刷手机、咬指甲、扯头发、坐不住。身体在焦虑时需要"放电"，这些小动作是无意识的释放。

⑥ 其他可观察的行为变化

- 说话变快、声音发紧、不敢对视；
- 突然结束对话、匆忙离开；
- 失眠导致的白天嗜睡、工作效率下降；
- 饮酒、吸烟、暴食（用物质缓解焦虑，短期有效，长期加重）。

4.2 为什么"回避 + 安全行为"是个恶性循环

【临床共识】这是理解焦虑障碍最重要的一个模型，请认真看：

```
遇到害怕的场景（如地铁）
    ↓
焦虑升起："万一我发作了怎么办？"
    ↓
做出回避/安全行为：逃出来 / 让朋友陪 / 反复确认
    ↓
焦虑暂时下降（短期奖励）
    ↓
大脑学到："刚才要是没逃/没人陪，我就完了"
    ↓
下次遇到同样场景，焦虑**更强**，回避更坚决
    ↓
活动范围越来越小，功能越来越受限
```

【个人体验】很多场所恐惧的患者回头看："我一开始只是不敢坐地铁，半年后不敢一个人逛超市，一年后不敢独自下楼取快递。**不是我越来越胆小，是我每一次逃避都在教我的大脑'那个地方真的很危险'。**"

打破这个循环的方法，就是心理治疗里说的**"暴露"**——在安全、可控的前提下，一点点面对你怕的场景，**不回避、不做安全行为**，让大脑自己发现："其实我去了也没事，我当时担心的那件事没发生。"

4.3 行为症状自查清单（可打印）

> 用法：最近 1 个月，你有过下面哪些行为？勾选后，在右边写下"它短期让我舒服了，但长期让我 ____"。

行为	我有没有（打勾）	长期让我……
回避某些场景（地铁、人多、发言、出门）	□	活动范围越来越小
必须有人陪才敢做某事	□	越来越依赖别人
反复去医院/反复做检查	□	不查就慌
反复问家人"我没事吧/孩子没事吧"	□	别人也累，我也没真安心
必须带某样东西（药、水、手机）才敢出门	□	没带就觉得完了
不喝任何咖啡/浓茶/能量饮料	□	稍微喝一点就惊恐
拖延重要事情（体检、谈话、决定）	□	事情一直悬着，焦虑一直没走
抖腿、转笔、来回走、坐不住	□	别人看出来，我更紧张
靠喝酒/吸烟/吃东西缓解紧张	□	短期放松，长期更糟
不敢看新闻/不敢聊疾病话题	□	世界在我眼里越来越危险

4.4 改变行为的第一步：不是"硬扛"，是"分级"

【临床共识】改变回避行为**不是让你立刻一个人坐地铁去市中心**——那会让你更怕。专业的做法是**"分级暴露"**：

1. 列出你回避的所有场景，按 0–100 分打分（0 = 完全不害怕，100 = 想到就惊恐）；
2. 从**分数最低的那件事**开始练习（比如"独自下楼取快递"）；
3. 在治疗师指导下，反复做、不做安全行为，直到焦虑自然下降；
4. 再升级到下一档（"独自走到小区门口""独自坐一站地铁"……）。

这个过程在模块7《渐进式暴露练习》里会展开讲。**重度、伴场所恐惧的患者，强烈建议在 CBT 治疗师指导下做，不要自己硬扛。**

4.5 给你的一句话

> **你不是"胆小"，你是被大脑训练成了"遇到危险就逃"的模式。** 这个模式曾经在原始草原上救过人类，但在今天的地铁、会议室、超市里，它过时了。好消息是：**行为是可以被重新训练的**——通过一点点、可控的暴露，你的大脑会重新学到"其实外面没那么危险，我也能应付"。

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-5 焦虑障碍行为症状诊断标准
- NICE：CG113 Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults
- 世界卫生组织：Anxiety disorders 事实清单
- Craske MG, Barlow DH. *Mastery of Your Anxiety and Panic.* 暴露与认知行为治疗经典手册
- 中华医学会精神医学分会：《中国焦虑障碍防治指南（实用简本）》行为治疗章节

5. 各亚型典型症状区分

> 同样是"焦虑"，不同亚型长得完全不一样：有人是天天担心，有人是突然濒死感，有人是怕被人看，有人是不敢出门。本页用两张大表把六类亚型（广泛性焦虑、惊恐障碍、社交焦虑、特定恐怖症、场所恐惧、分离性焦虑）的**典型症状**分开，并单独把**惊恐发作**的急性特征讲透。**对照不用于自我确诊，最终诊断由精神科医生面诊做出。**

5.1 六类亚型典型症状大对照表

亚型	情绪/内心体验	典型躯体表现	典型思维	典型行为	发作形式
广泛性焦虑障碍（GAD，6B00）	持续的紧张不安、心里悬着、易烦躁	肌肉紧绷、肩颈酸痛、失眠、疲劳、心慌、出汗	对生活各方面过度担忧、灾难化、"万一……怎么办"	坐立不安、反复确认、拖延、做决定困难	**慢性背景音**，多数日子有，≥6个月
惊恐障碍（6B01）	突发强烈恐惧、濒死感、失控感	心慌心悸、胸闷胸痛、气短、手抖、出汗、手脚发麻、头晕、喉咙紧	"我要死了/我要疯了/我要失控了"	发作后反复跑急诊、反复检查、不敢独自出门（继发场所恐惧）	**急性闪电式**，10分钟内达峰，数分钟至数十分钟自行缓解
社交焦虑障碍（6B04）	怕被人注视、怕出丑、怕被否定	当众说话时脸红、手抖、声音发紧、出汗、心跳快	"所有人都在看我""我一定会表现砸"	回避发言、聚餐、打电话；必须喝酒才敢社交	**遇社交场景即发作**，事前也会持续紧张数天
特定恐怖症（6B03）	对单一对象/场景强烈、持续的害怕	一见对象就心慌、出汗、想逃；血液-注射型甚至会晕倒	"那个东西会伤害我"	主动回避（绕路、换工作、取消旅行）	**遇特定对象即发作**，几乎每次都这样
场所恐惧障碍（6B02）	怕"万一发作了逃不掉、没人帮"	在地铁/超市/队伍/独自离家时心慌、怕发作	"我在那里发作就完了"	必须有人陪才敢出门；活动范围越来越小	**遇特定场所即发作**，独自时最重
分离性焦虑障碍（6B05）	怕和依恋对象分开、怕对方出事	分开时心慌、噩梦、肠胃不适、不愿上学/上班	"他/她路上一定会出事"	不肯分开、反复打电话确认、儿童拒学	**与分离相关**，儿童≥4周，成人≥6个月

【临床共识】**它们常常重叠**：惊恐障碍患者后来可能发展出场所恐惧（怕再发作而不敢出门）；GAD 患者可能也有社交焦虑；特定恐怖症患者也可能担心自己"是不是不正常"。医生会区分主次，但**治疗方向是相通的**（CBT 暴露 + 必要时药物）。

5.2 惊恐发作：急性焦虑的"闪电战"

如果你或家人经历过惊恐发作，下面这组特征会让你觉得"终于有人说清楚了"。

① 它是怎么发作的?

【个人体验】**毫无预兆、突然袭来**——可能在你开车、在开会、在超市排队、甚至在床上睡着时。没有明显诱因，或者诱因小得离谱（"我只是多喝了半杯咖啡"）。

② 10 分钟内达到最强烈

【临床共识】惊恐发作的标志性时间特征是：**在 10 分钟内（常在 2–3 分钟内）迅速达到症状高峰**，然后在数分钟到数十分钟内自行缓解。它不像"持续几小时的紧张"，而是**一场急风暴**。

③ 13 项典型症状（DSM-5 列出）

发作时通常伴随下列 ≥ 4 项（**这就是为什么你会同时觉得"十几个地方都不对"**）：

类别	具体症状
心血管	心悸、心跳加快；出汗；发抖/震动；胸痛或胸部不适
呼吸	气短或窒息感；哽咽感（像被掐住喉咙）
神经/躯体	恶心或腹部不适；头晕、不稳、头重脚轻；发冷或潮热；手脚麻木或刺痛感
认知/知觉	不真实感（觉得周围不真实）；人格解体（觉得自己不像自己）；**害怕失控或发疯**；**濒死感**

【个人体验】患者最常描述的几句话：

> "我觉得我马上就要死了。"
> "我感觉我要疯了、要失控了。"
> "我打 120 到了急诊，一做心电图，医生说没事。"
> "那种难受，比我真的感冒发烧严重一百倍。"

④ 为什么"濒死感"这么强但通常不致命?

【临床共识】这是惊恐发作最重要、也最让人安心的事实：

- 惊恐发作是**神经系统的过度放电**，不是心脏的器质性故障；
- 你感到的"濒死感"是**杏仁核误报的恐惧情绪**，不是真的器官在衰竭；
- 绝大多数发作在 **5–30 分钟内自行缓解**，不会"一直发作直到死"；
- 它**不会导致猝死、不会让你真的疯掉、不会让你昏迷。**

【临床共识】**但有一条铁律**：**第一次**发生这种"剧烈胸痛 + 濒死感 + 持续不缓解"的情况，**必须由医生排除器质性问题**——心脏（急性冠脉综合征、心律失常）、甲状腺（甲亢危象）、癫痫（颞叶发作）、嗜铬细胞瘤等。**没排除之前，不能自己安慰"这是惊恐发作"。**

一旦医生通过心电图、心肌酶、甲功、必要时动态心电监测等**排除了这些躯体疾病**，以后再发作时你就有了一个关键的心理资源：**"我已经被查过了，我的心脏是好的。"** 这种确定感本身就能大幅降低下一次发作时的恐惧强度。

5.3 惊恐发作 vs 真正的心脏病发作——快速对照

维度	惊恐发作	真正的心脏急症
起病	突然，数分钟达峰	也可突然，但常与运动、情绪激动、饱餐相关
胸痛性质	尖锐、位置游走、伴胸闷、喉咙紧	**压榨样、胸骨后、放射至左肩/下颌/后背**
伴随	手抖、出汗、手脚发麻、濒死感、不真实感	**冷汗、面色苍白、晕厥、濒死感**
持续时间	数十分钟内自行缓解	不处理通常不缓解，甚至加重
检查	心电图、心肌酶**基本正常**	心电图、心肌酶有异常
既往史	多有类似发作史、年轻、女性偏多	常伴高血压、糖尿病、吸烟、家族史

【临床共识】**第一次，按心脏急症处理；反复发作者，医生排除后按惊恐障碍治疗。** 不要因为"上次查了没事"就完全忽视第一次的剧烈胸痛——该查还是要查。

5.4 各亚型的"高发人群"和"典型起病场景"

亚型	高发人群	典型起病场景
GAD	责任心强、长期高压、女性偏多	常在重大压力事件（换工作、家人生病）后慢性化
惊恐障碍	青年后期、女性、近期有重大应激	第一次发作常在某次熬夜、喝咖啡、感冒后，无明显诱因
社交焦虑	青少年晚期、性格偏内向者	常在被当众批评、出丑后起病；也有慢性自幼即有
特定恐怖症	儿童期起病（动物、自然型）；成人期起病（情境型）	曾被某种动物吓过、经历过一次飞行颠簸
场所恐惧	常继发于惊恐障碍	第一次惊恐发作后，开始怕"再发作的地方"
分离性焦虑	儿童（常见）；成人多见于依恋关系紧密者	儿童入学、父母出差；成人伴侣出差/住院

5.5 给患者的三句话

1. **"我到底是哪种"不重要，重要的是"我需要帮助"。** 医生会帮你分型，你不必自己纠结。
2. **惊恐发作的濒死感通常不直接致命，但第一次必须查清楚。** 被排除过躯体疾病后，你就有了对抗它的底气。
3. **这些症状不是你的错，也不会把你变成"疯子"。** 它们是一套过度敏感的警报系统在响，是可以被重新校准的。

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-5 Panic Attack Specifier 13 项症状
- 世界卫生组织：ICD-11 · Anxiety or fear-related disorders (6B00–6B05)
- NICE：CG113 Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults

- 中华医学会心血管病学分会：《惊恐障碍与心血管疾病鉴别诊断中国专家共识》
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Panic Disorder 科普页
- 中华医学会精神医学分会：《中国焦虑障碍防治指南（实用简本）》各亚型章节

模块 4

诱因与高危因素

1. 生物学因素

> 焦虑不是"想不开"，它有实实在在的生物学基础。但请记住：**这些因素只是"风险"，不是"宿命"**——有家族史不等于一定会得病，没有家族史也可能得。了解它们，是为了减少自责，而不是给自己判死刑。
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、为什么要谈生物学因素

很多患者第一次来就诊时会说："我是不是太脆弱了？"【临床共识】焦虑障碍有明确的生物学易感基础，它像高血压、糖尿病一样，是身体调节系统出了偏差，而不是性格缺陷。了解自己身上哪些"出厂设置"偏高，能帮你少走"靠意志力硬扛"的弯路。

二、遗传与家族史：风险升高，不是"遗传病"

问题	通俗答案
家里有人焦虑，我会不会一定被遗传?	不会。家族史只是让患病风险**比普通人高一些**，通常认为升高数倍（约 2～6 倍，因亚型而异），不是必然。
父母都没有，我怎么会得?	遗传不是唯一因素，环境和压力同样重要；很多患者家族里没有明确患者。
我有了焦虑，孩子会不会一定有?	不会。孩子继承的是"偏敏感的气质"，不是"焦虑病"；后天养育方式可以大大缓冲。

【研究结论】双生子研究提示，焦虑障碍的遗传度大约在 30%～50% 之间——也就是说，约一半左右的差异可归因于遗传，另一半来自环境与个人经历。它不像血友病、地中海贫血那样由单个基因决定，而是许多微小基因效应叠加的结果。

【个人体验】知道"这不是我作出来的"，很多人第一反应是松了一口气——原来身体的警报系统天生就灵敏一点，不丢人。

三、大脑里发生了什么：报警系统太灵敏

焦虑时的心慌、出汗、脑补灾难，对应着大脑几个关键调节系统的"配合失调"：

系统/物质	通俗解释	打个比方
杏仁核	大脑的"威胁警报器"，焦虑时反应过度、亮得太早	烟雾报警器太灵敏，炒菜就响
5-羟色胺（血清素）	参与情绪、担忧、冲动的调节	大脑的"稳定减震器"
去甲肾上腺素	参与应激唤起、心跳加快	"战斗或逃跑"的油门
GABA	大脑主要的"刹车"递质，负责让神经冷静下来	刹车皮

【临床共识】焦虑障碍患者常表现为杏仁核对威胁信号反应过强（高反应性），而负责自上而下调控的前额叶"刹车"又偏弱——于是警报一响就停不下来，人就被淹没在担忧里。这也是为什么药物和心理治疗分别从"调递质"和"练刹车"两头起作用。

四、气质类型：小时候就偏"慢热"的孩子

【研究结论】相当一部分成年焦虑患者，童年期就属于"行为抑制型"气质：面对陌生的人、事、环境，从小就退缩、紧张、容易害羞。这不是病，是气质；但如果后天压力叠加，这类孩子日后发展为社交焦虑、广泛性焦虑的概率更高。

【个人体验】"我从小就这样，不敢举手发言、去新地方要提前焦虑好几天"——很多人听完恍然大悟：原来不是突然变坏，是那个高敏感的自己一直都在。

五、性别：女性约为男性的 2 倍

【研究结论】绝大多数流行病学调查显示，焦虑障碍（尤其广泛性焦虑、惊恐、社交焦虑）的女性患病率约为男性的 2 倍。原因是多因素叠加：激素波动（月经、孕产、围绝经期）、社会角色压力、遭遇创伤的比例，以及男性更倾向于"硬扛"或以酗酒等方式表达。

六、睡眠紊乱：既是结果，也是推手

长期失眠、入睡困难、夜间易醒，与焦虑互为因果：白天越焦虑晚上越睡不好，睡不好第二天警报系统更敏感。【临床共识】把睡眠稳下来，常常是焦虑治疗见效的第一个抓手。

七、躯体疾病与药物：有些"焦虑"是身体发的信号

下面这些身体问题，表现出来很像焦虑，**必须先排查、别直接归因于"心理"**：

类别	常见情况
内分泌	甲状腺功能亢进（甲亢）、低血糖、围绝经期综合征
心血管	心律失常、二尖瓣脱垂、高血压波动
血液/代谢	贫血、电解质紊乱
感染/其他	嗜铬细胞瘤、某些肺部问题
物质/药物	过量咖啡因、能量饮料、某些减肥药、糖皮质激素、支气管扩张剂、酒精或镇静药突然戒断

【临床共识】这正是第一次就诊时医生常让你做心电图、查甲功、查血常规的原因——把"身体能解释的心慌"先排除掉，剩下的才好谈焦虑本身。

八、一句话总结

生物学因素决定的是**你的"敏感体质"**，它解释了你为什么比别人更容易被点着；但点不点得着、着多大，很大程度上取决于后面要讲的心理习惯和环境压力，以及你能不能主动建立保护因素。**风险不是判决书，是提示牌。**

参考来源

- Huang Y, Wang Y, Wang H, et al. Prevalence of mental disorders in China: a cross-sectional epidemiological study. *Lancet Psychiatry*. 2019;6(3):211-224. doi:10.1016/S2215-0163(18)30511-X
- WHO：Anxiety disorders fact sheet
- NICE：Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management, CG113
- 中华医学会精神医学分会.《中国焦虑障碍防治指南》（相关章节）.
- APA：DSM-5 焦虑障碍谱系
- NIMH：Anxiety Disorders

2. 心理因素

> 如果说生物学决定了"警报有多灵敏"，心理因素就决定了"你习惯不习惯于按它"。好消息是：**心理因素恰恰是心理治疗最能改变的部分**——思维习惯像肌肉，可以通过训练重新塑造。
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、长期慢性压力：高压锅效应

【临床共识】短期压力是正常的；真正把人推向疾病的，是**长期、持续、看不到头**的压力——常年加班、经济拮据、照顾重病家人、处于冲突关系中。它不像一场车祸那样有明确的"事件"，而是日复一日地把神经系统泡在应激激素里，慢慢让人的警报阈值越降越低。

【个人体验】很多人回忆病程时会说："其实不是某一天突然崩的，是那两三年一直绷着，后来一点小事就慌。"

二、灾难化思维：把"可能"脑补成"必然"

焦虑的人往往有一套相似的思维习惯：

思维习惯	内心独白举例	实际真相
灾难化	"这次心慌会不会是心脏病，我会不会死在办公室"	一过性心悸绝大多数不是心梗
高估威胁	"汇报说错一句，整个项目就完了"	一次小失误很少毁掉全局
低估自己应对能力	"真出事我肯定扛不住"	多数人经历事后都发现自己应付过来了
读心术	"他今天没理我，一定是对我有意见"	对方可能只是累了

【研究结论】认知行为治疗（CBT）的核心，就是帮你学会**识别这些自动冒出来的念头，再用证据去检验它们**——这是被研究证实最有效的焦虑干预之一。

三、对"不确定"的低容忍度

焦虑的人常常需要"万事都有准信"：检查有没有事、反复确认门锁、反复查身体指标、要别人把话说死。
【临床共识】这种"非黑即白、不能接受一点模糊"的倾向，会让人越来越累——因为世界本来就是不确定的，你却要求它 100% 可控。

四、控制欲与责任感过强

类型	表现	代价
过度负责	"出一点事就是我的错"	长期背锅、愧疚、放不下
过度控制	凡事要按计划来，计划一变就慌	灵活度差，一失控就焦虑

类型	表现	代价
讨好型	不敢拒绝、怕冲突	边界被侵犯，压力持续累积

【个人体验】有患者说："我以前觉得负责是优点，后来才发现，我负责的范围早就超出了我能管的事。"

五、创伤经历：过去的事，不会真的过去

创伤类型	与焦虑的关系
童年虐待（身体/情感/性）	显著升高日后焦虑、抑郁风险
童年忽视、长期被否定	容易形成"我不够好、世界不安全"的底色
校园欺凌、长期被排挤	与社交焦虑关系密切
重大创伤（事故、暴力、灾难、突然丧失）	可能发展为创伤后应激障碍（PTSD），常与惊恐、广泛性焦虑共病

【临床共识】创伤不是"想开点"就能翻篇的。如果你的焦虑伴随着反复闪回、噩梦、刻意回避某些场景、过度警觉，要主动告诉医生——这会影响治疗方向（可能需要创伤聚焦的心理治疗）。

六、依恋模式：从小练出来的"安全感脚本"

小时候主要照料者是否稳定、可回应，会让人形成一种潜意识脚本：

- **安全型**：相信有人可依靠，压力大时能自我安抚；
- **焦虑型依恋**：总怕被抛弃、过度担心关系出问题；
- **回避型依恋**：习惯独自硬扛，不会求助，压力闷在心里。

【争议观点】依恋模式是理解工具，不是给人贴标签；它可以在成年后的稳定关系和治疗关系中被修复。

七、这些心理因素能改变吗？——能，这正是治疗的意义

因素	能否被改变	通过什么
灾难化思维	较易	CBT 思维记录、认知重构
对不确定的低容忍	中等	暴露练习、行为实验
控制欲/责任感	中等	边界练习、认知工作
长期慢性压力	可调节	减压、生活结构调整、必要时求助
童年/重大创伤	可修复	创伤聚焦治疗（如 EMDR、TF-CBT），需专业指导

【个人体验】康复者常说："思维还是会冒出吓人的念头，但我现在认得它了——'哦，老套路又来了'，它就没那么吓人了。"

八、一句话总结

生物学让你"容易慌"，心理习惯让你"一直慌"。前者提醒你别硬扛，后者告诉你——**慌的方式是可以学、可以改的**。这就是为什么正规治疗里，药物常常只占一半。

参考来源

- NICE：Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management, CG113（认知行为治疗推荐）
- WHO：Anxiety disorders fact sheet
- APA：DSM-5 焦虑障碍与创伤及应激相关障碍章节
- 中华医学会精神医学分会.《中国焦虑障碍防治指南》.
- Hofmann SG, et al. The efficacy of CBT for anxiety disorders: a review. *Cogn Behar Ther*.
- NIMH：Anxiety Disorders

3. 环境因素

> 同样的"敏感体质"，放在安稳环境里可能一辈子只是个"细心、谨慎的人"；放在高压、变故、长期冲突的环境里，就容易被点燃。环境因素往往是**压垮骆驼的那最后几根稻草**——也是我们最能动一动的部分。
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、长期高压环境

场景	典型压力
工作	996、随时待命、业绩压力大、人际关系紧张、怕失业
学业	升学压力、考试密集、父母高期待
经济	负债、收入不稳定、房贷/养家压力
照护	长期照顾老人、重病家人、年幼多孩

【临床共识】这类压力没有明确的"结束点"，神经系统长期处于备战状态，是焦虑障碍最常见的土壤。

二、重大生活变故（近期/过去一年）

下面这些事件都可能成为焦虑发作的"扳机"：

- 失业、降薪、被辞退；
- 离婚、失恋、关系破裂；
- 亲人离世（丧失）；
- 自己或家人确诊重病；
- 搬家、换工作、升学、移民等生活结构变化；
- 重大财务冲击（被骗、投资失败）。

【研究结论】经历重大负性生活事件后出现一段时间的紧张、担心、失眠，是人的正常反应；**但如果反应过强、持续过久、明显影响生活，就需要专业评估**，而不是硬扛。

三、家庭氛围与养育方式

养育/家庭特征	与日后焦虑的关系
过度保护、不准孩子冒险	孩子学不到"我能应付"，容易高估危险
高要求、常批评	容易形成"我不够好、必须不出错"的底色
父母本身高度焦虑、反复警告危险	孩子会模仿这套"世界很危险"的剧本
家庭长期冲突、冷战	长期处于不确定与紧张中

【争议观点】谈家庭不是要追责父母——多数父母已尽当时所能；理解成因是为了打破代际传递，而不是翻旧账。

四、慢性疾病照护压力

长期带病生活（如慢性病、慢性疼痛、肠易激综合征）或长期照护他人，本身就是持续性应激源。【临床共识】躯体疾病与焦虑常互相加重：身体不舒服→担心→更紧张→身体更不舒服。这类情况往往需要心身同治。

五、群体性事件

疫情、自然灾害、社会动荡、公共安全事件后，人群中焦虑、惊恐、失眠会明显增多。【临床共识】这类普遍性紧张多数会随时间缓解；若持续数月不缓解、影响生活，仍需就诊。

六、物质因素：容易被忽略的"环境/行为"扳机

物质/行为	与焦虑的关系
过量咖啡因（浓茶、咖啡、能量饮料）	直接诱发心慌、手抖、惊恐样感受
酒精	短期放松，长期加重焦虑，戒断时焦虑飙升
毒品/兴奋剂	可直接诱发惊恐、偏执样焦虑
突然停掉镇静类药物	焦虑、失眠反跳，必须在医生指导下调整

【个人体验】不少人减咖啡后才发现："原来我那些'发作'，一半是三杯浓美式堆出来的。"

七、压力事件自查表（过去一年，符合打勾）

- [ ] 长期睡眠不足或作息紊乱超过 3 个月
- [ ] 工作/学业压力持续大，没有明确缓解期
- [ ] 经历失业、降薪、重大财务损失
- [ ] 经历分手、离婚、亲人离世
- [ ] 自己或家人确诊较严重疾病
- [ ] 处于长期冲突、压抑的关系或家庭氛围中
- [ ] 每天大量咖啡/浓茶/能量饮料，或靠酒助眠
- [ ] 长期照顾生病家人，几乎没有自己的时间

【使用提示】勾中越多，说明你的"环境负荷"越重——这不是矫情，是身体在提醒你：该减负、该求助了。就诊时把这张表给医生看，很有帮助。

八、一句话总结

生物学是"柴火"，心理习惯是"引线"，**环境常常就是那把火**。我们未必能立刻换掉环境，但可以先做三件事：减少咖啡因和酒精、把睡眠拉回正轨、把这一年的压力事件理清楚告诉医生。

参考来源

- WHO：Anxiety disorders fact sheet
- NICE：Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults, CG113
- APA：DSM-5 焦虑障碍、创伤及应激相关障碍
- Huang Y, et al. *Lancet Psychiatry*. 2019;6(3):211-224. doi:10.1016/S2215-0163(18)30511-X
- 中华医学会精神医学分会. 《中国焦虑障碍防治指南》.
- NIMH：Anxiety Disorders

4. 保护因素

> 高危因素解释"为什么会得病"，保护因素解释"为什么有的人同样压力大却没崩"。**好消息是：保护因素大多可以主动建设**——不需要你天生拥有，从今天的小动作就能开始。
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、什么是保护因素

【临床共识】保护因素是一组能缓冲压力、降低焦虑发作和复发风险的条件与习惯。它们不能"治愈"已经发作的焦虑，但能显著降低风险、加快恢复、减少复发。

二、核心保护因素清单（可对照自查）

保护因素	为什么有用	现在可以做什么
稳定的社会支持	有人可说话、不孤独，是最强缓冲之一	每周至少和一个让你放松的人聊几句
规律作息与充足睡眠	睡不好，警报系统更灵敏	固定起床时间，比"几点睡"更重要
适度运动	消耗应激激素、改善情绪	每天快走 20～30 分钟即可，不必猛练
正念/放松习惯	给神经系统"刹车"训练	每天 5 分钟深呼吸或身体扫描
问题解决技能	把"一团糟"拆成"一件件能做的事"	列三件明天就能动手的小事
有限的咖啡因/酒精	避免物质反复刺激警报系统	下午后不喝咖啡；不靠酒助眠
及时求助的意愿	早干预，恢复快、疗程短	知道附近能看的科室/热线
经济与居住基本稳定	减少持续生存焦虑	先稳住最基本的生活盘
安全感的人际关系	减少长期冲突消耗	给自己设一点人际边界
意义感与可控的小目标	让人在不确定中有抓手	每天留一件自己说了算的事

三、从今天开始的小动作（不必全部做，挑 1～2 个）

1. **固定起床时间**：哪怕前一晚没睡好，也尽量同一时间起床，周末不赖床——这是睡眠节律的锚。
2. **下午 2 点后不碰咖啡因**：咖啡、浓茶、可乐、能量饮料都算。
3. **每天 20 分钟快走**：不用大汗淋漓，能说话、微微喘的强度就够。
4. **找人说一句话**："我最近有点绷不住"——不必求建议，说出来本身就减压。
5. **睡前 1 小时放下手机**：把卧室从"信息轰炸区"变回"睡觉的地方"。
6. **写 3 行担忧日记**：今天在怕什么？最坏会怎样？实际上呢？——这本身就是简易的认知练习。
7. **减少酒精**：尤其不要用酒助眠，它会让浅睡眠增多、早醒更重。

【个人体验】康复者常说："真正帮我稳住的不是某一个大决定，而是几个小习惯——固定时间起床、每天下楼走一圈、难受时给朋友发条消息。"

四、保护因素不是"自律考核"

【争议观点】要特别提醒：不要把这张清单变成新的压力来源——"我怎么又没运动、又没早睡，我真失败"。**做到多少算多少，目标是缓冲，不是完美。** 如果你目前连起床都困难，那"按时吃饭、按时吃药"本身就是了不起的保护行动。

五、保护因素与治疗的关系

【临床共识】保护因素是治疗的"地基"，不能替代药物和心理治疗；但只靠治疗、不重建生活节奏，复发风险会高。两者是配合关系：

```
生物学易感（高敏感体质）
        ＋
环境/压力（柴火）
        ↓  加上
保护因素（缓冲垫）
        ↓
是否发作、有多严重、多久恢复
```

六、一句话总结

你不需要一夜之间把生活全部改好。**挑一个最容易做到的，先做一周**——稳定作息、走走路、少喝一杯咖啡、找一个人说句话。这些小动作，就是在给自己的神经系统铺缓冲垫。

参考来源

- WHO：Anxiety disorders fact sheet
- NICE：Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults, CG113（生活方式、运动与自助建议）
- 中华医学会精神医学分会.《中国焦虑障碍防治指南》.
- NIMH：Anxiety Disorders
- APA：DSM-5 焦虑障碍章节
- 中国心理学会临床心理学注册工作委员会相关科普资源.

模块 5

就医与诊断指南

1. 就诊触发信号

> 最常见的两个错误：一是"忍忍就过去了"，拖到严重影响生活才来；二是一心慌就以为是心脏病，反复跑急诊。这一篇帮你判断：**什么时候该预约门诊，什么时候必须立刻去急诊。**
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、什么时候该预约门诊（不必急诊）

出现以下情况，建议尽快挂精神科/心理科普通门诊：

信号	说明
担心、紧张持续存在	广泛性焦虑通常要≥6个月才够诊断标准，但**不必自己死卡时间**——影响生活就该看
明显影响生活功能	上班/上学效率明显下降、不敢出门、回避社交、与家人频繁争吵
躯体不适反复查不出原因	心慌、胸闷、头晕、肠胃不适，心内科/消化科查了一圈没大事
惊恐发作之后	经历过一次强烈发作，开始害怕再次发作、不敢独处、不敢出门
自我调节无效	自己试了运动、放松、休假，一两个月仍不见好
睡眠长期紊乱	入睡困难、早醒、睡不解乏，持续数周
出现酒精/药物滥用倾向	开始靠喝酒、吃药才能放松入睡

【临床共识】就诊不必等到"完全受不了"。早期干预疗程更短、恢复更好；拖到慢性化，治疗难度反而上升。

【个人体验】很多康复者后悔的是同一句话："早知道这么容易说清楚，我不该自己扛两年。"

二、【重要】出现这些身体信号，先急诊/心内科，不要先假设是焦虑

这是本篇最关键的提醒：**首次剧烈胸痛、胸闷、心悸、晕厥、呼吸困难，先按急症处理，排除心脏问题，再谈焦虑。**

必须先排查躯体急症的情况
突发剧烈胸痛/胸闷，尤其向左肩、左臂、下颌、背部放射
伴冷汗、濒死感、面色苍白、呼吸困难
晕厥、眼前发黑、失去意识
既往有心脏病、高血压、糖尿病、吸烟史、中年以上
心跳又快又乱、持续不缓解，或血压明显异常

【临床共识】惊恐发作和心脏急症在症状上非常像（都心慌、胸闷、濒死感），**第一次发作尤其不能自行断定"只是焦虑"**。先做心电图、查心肌酶，把危险排除掉，既安心，也让后面的焦虑诊断更干净。

【个人体验】一位患者描述："那次半夜胸口压得喘不上气，打120到急诊，心电图、抽血都正常。医生说'你这是惊恐发作，去看看心理科'——那一刻反而踏实了，因为终于有人告诉我它是什么。"

三、分流表：挂急诊 / 预约门诊 / 先自我观察

你的情况	建议行动
首次剧烈胸痛胸闷、放射痛、冷汗、晕厥、既往心脏病	**立即急诊 / 拨打120**
有明确自伤、自杀念头或计划	**立即急诊或联系危机热线**
惊恐反复发作，不敢独处不敢出门	尽快预约精神科/心理门诊
持续担心紧张≥数周，影响睡眠工作	预约普通门诊
身体不适反复查无器质性原因	门诊+必要时转诊心身医学科
偶尔紧张、压力大，休假后能恢复	先自我调节+观察1～2周

四、诊断标准里的"时间"，不用自己硬套

【临床共识】以广泛性焦虑障碍为例，诊断标准要求"过度的焦虑和担忧"持续**至少6个月**。但这是医生对照标准用的，**你不需要先在家掐着日历算日子。**症状明显、难受、影响生活，就值得来看；时间长短由医生面诊时综合判断。

五、自我调节多久没效，就该看医生

尝试过的方法	建议观察期
运动、作息调整、减少咖啡因、找人倾诉	2～4 周
仍无改善，或越来越重	就诊
期间出现惊恐发作、失眠加重、回避行为	不必等时间，直接就诊

六、一句话记住

第一次剧烈胸痛胸闷，先救命、先查心脏；排除之后，反复出现的心慌担心、查不出原因的不舒服、影响生活的紧张——才轮到焦虑科来看。

参考来源

- NICE：Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management, CG113
- WHO：Anxiety disorders fact sheet
- APA：DSM-5 焦虑障碍诊断标准
- 中华医学会精神医学分会.《中国焦虑障碍防治指南》.
- NIMH：Anxiety Disorders
- 国家心血管病中心科普资源（胸痛优先就医原则）.

2. 就诊科室与专业人员区分

> 很多人卡在第一步：我到底该挂"精神科"还是"心理科"？咨询师和医生有什么区别？这一篇把这些门牌号讲清楚，免得你排错队。
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、医院里的几个"科"，有什么区别

科室名称	主要看什么	能不能开药
精神科/精神病科	各类精神障碍的诊断与药物治疗，焦虑、抑郁、惊恐都看	能
心理科/临床心理科	心理评估、心理治疗，部分由精神科医生出诊	出诊医生能
心身医学科/身心医学科	以"躯体不适为主、查不出器质性原因"的患者，如反复心慌、肠胃不适	能
精神卫生中心/精神专科医院	专病机构，科室最全，可住院、物理治疗	能

【临床共识】第一次就诊，**挂"精神科"或"心理科"普通门诊即可**；如果你的主诉全是身体不舒服（心慌、胸闷、肠胃乱）而查不出问题，可以挂"心身医学科"。

二、三类专业人员，别搞混

角色	能做什么	不能做什么
精神科医生（执业医师）	面诊、下诊断、开药物处方、安排检查	（在医院体系内可做一切医学决策）
心理治疗师/心理咨询师	谈话治疗、认知行为干预、情绪支持	**不能做医学诊断、不能开药**
社会工作者	资源链接、家属支持、社区康复	不开药、不做诊断

【临床共识】**诊断和开药只有精神科执业医师能做。**心理咨询师谈得再好，也不能替代医生面诊；反过来，确诊后配合规范心理治疗，效果常常优于单纯吃药。

三、国内就诊路径怎么走

1. **综合医院**：挂"精神科/心理科/心身医学科"——适合同时有身体不适、想在普通医院看、减少病耻感的人。
2. **精神专科医院/精神卫生中心**：科室全、经验丰富，适合症状较重、需要药物或系统治疗者。
3. **社区卫生服务中心/基层**：初步识别、开转诊单、随访，适合轻症和老患者随访。
4. **互联网医院**：**只建议老患者复诊续方**，首诊、症状波动大、有安全风险时必须线下面诊。

四、医院精神科 vs 私立心理咨询，怎么选

维度	医院精神科	私立心理咨询机构
强项	诊断、开药、重症处理	谈话治疗、时间更充裕
局限	门诊时间短，心理治疗资源有限	鱼龙混杂，不能诊断、不能开药
适合	第一次看、不确定有多严重、可能需要药	已确诊、想配合谈话治疗

鉴别正规与否的要点：
- 医生/治疗师是否有可查的执业资质（精神科医师执业证书、心理学会注册系统等）；
- 机构是否尊重边界（不夸大疗效）；
- **警惕"包好""几次根治""中药无副作用永不复发"这类营销话术**——焦虑障碍是可治疗、可管理的，但正规治疗不会承诺"断根"。

五、惊恐发作时去急诊，是怎样一种体验

【个人体验】很多人都有过这样的夜晚：

> 凌晨两点，心脏突然狂跳、胸口像被压住、喘不上气、手脚发麻、浑身冷汗，脑子里只有一个念头："我要死了。"到急诊，护士量血压、做心电图、抽血，等结果的时候人已经慢慢缓过来。最后医生说："检查都正常，你这是惊恐发作，白天去精神心理科看看吧。"

这不是"白跑一趟"——**这次急诊非常有价值**：它帮你排除了真正危险的心脏问题，也第一次给了你一个名字。带着急诊病历和心电图结果去精神科就诊，医生会更有底气。

六、就诊当天的几个小提示

- 带身份证、医保卡、既往病历和正在吃的药盒；
- 一个人紧张可以请家属陪同，但涉及内心感受，建议自己对医生说；
- **录音前先征得医生同意**，说一句"我怕记不住，可以录下来吗"，多数医生会同意；
- 没听懂就追问："您刚才说的，我理解是……对吗？"——这是你的权利。

七、一句话记住

开药找精神科医生，谈话找心理治疗师；第一次先去医院把诊断立住，再决定要不要配合咨询。

参考来源

- NICE：Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults, CG113
- WHO mhGAP：Humanitarian and health worker guide
- 中华医学会精神医学分会.《中国焦虑障碍防治指南》.
- NIMH：Finding Help: Mental Health Professionals
- APA：How is mental illness diagnosed?

- 中国心理学会临床心理学注册工作委员会.

3. 就诊前准备清单

> 第一次进诊室，平均只有十几分钟。你一紧张，往往脑子一片空白，出来才想起"刚才忘了说这个"。这一篇是**可以直接打印、照抄填写的模板**——把它填好带去，医生几分钟就能抓住重点，你也不用靠临场发挥。
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、为什么要提前写下来

【临床共识】医生最需要的信息是：**什么症状、什么时候开始、频率多高、对生活影响多大、有没有躯体疾病和用药**。这些靠你现场回忆容易漏，写在纸上递给医生，既省时间又准确。你不需要写得像病历，大白话、举例子就够。

二、症状记录表（核心，就诊前 1～2 周开始记）

1）最主要的困扰是什么

- 这次最想解决的问题（写 1～3 个）：
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- 大概从什么时候开始的（日期/几周前）：_ _ _ _ _ _
- 是慢慢出现的，还是某一天突然发作的：_ _ _ _ _ _

2）症状频率与强度（按最近一周填）

症状	有/无	一周大约几次	每次持续多久	最严重时打分(0–10)
心里紧张、放不松				
控制不住地担心各种事				
心慌、心跳快				
胸闷、喘不上气				
手抖、出汗、发冷发热				
头晕、头胀、站不稳				
肠胃不舒服、没胃口				
肌肉紧绷、肩颈酸痛				
入睡困难/早醒/睡不好				
容易烦躁、对人发火				

症状	有/无	一周大约几次	每次持续多久	最严重时打分(0–10)
害怕独处/不敢出门/回避某些场合				
突然强烈发作（濒死感、失控感）				

> 0 = 完全没有困扰，10 = 最严重、几乎无法忍受。

3）什么情况下会加重 / 缓解

- 容易被什么触发（开会、地铁、体检报告、独处、夜里……）：＿＿＿＿＿＿
- 什么时候会好一点（运动后、和朋友在一起、放假……）：＿＿＿＿＿＿

三、躯体症状与既往检查清单

1）身体上的不舒服（勾选）

- [ ] 心慌心悸　[ ] 胸闷胸痛　[ ] 气短　[ ] 头晕/晕厥
- [ ] 手抖出汗　[ ] 口干　[ ] 吞咽梗堵感　[ ] 恶心/腹泻/便秘
- [ ] 失眠　[ ] 易醒　[ ] 多梦　[ ] 疲惫乏力
- [ ] 体重变化（约＿＿斤）　[ ] 月经紊乱（如适用）

2）已经做过的检查（带报告或拍照）

检查项目	时间	结果（正常/异常，异常写什么）
心电图 / 动态心电图		
甲状腺功能（甲功）		
血常规		
血糖		
其他（心脏彩超、心肌酶、头颅CT等）		

【临床共识】把这些检查结果带上，能帮医生快速排除甲亢、心律失常、贫血等"伪装成焦虑"的躯体疾病，避免重复抽血。

四、既往史与家族史

- 以前看过精神/心理科吗？诊断过什么？吃过什么药？效果和副作用如何：＿＿＿＿＿＿
- 有没有住过院、做过手术：＿＿＿＿＿＿
- 有没有甲状腺、心脏、高血压、糖尿病、胃病等慢性病：＿＿＿＿＿＿
- 父母、亲兄弟姐妹有没有焦虑、抑郁、长期失眠、酗酒：＿＿＿＿＿＿
- 小时候有没有被虐待、长期忽视、校园欺凌等创伤经历（愿意说就写）：＿＿＿＿＿＿

五、用药与保健品清单（带药盒或手机拍照）

名称	每天剂量/频次	吃了多久	谁开的
|	|	|	|
|	|	|	|

- 包括：处方药、中药、中成药、保健品、止痛药、减肥药、避孕药、激素。
- 咖啡因/酒精：每天几杯咖啡或浓茶？喝酒频率和量？ _ _ _ _ _ _
- 吸烟/其他物质情况： _ _ _ _ _ _

> 注意：不要自行描述或要求医生开某种药；把清单如实交给医生判断即可。

六、近期生活事件（过去半年到一年）

- 工作/学业变化（加班、失业、考试、转学）： _ _ _ _ _ _
- 家庭/关系变化（分手、离婚、家人重病、离世）： _ _ _ _ _ _
- 经济压力： _ _ _ _ _ _
- 睡眠和作息的整体变化： _ _ _ _ _ _

七、想问医生的问题清单（提前写 3～5 个）

参考问题，挑你最关心的：

1. 我这个情况大概属于什么？严重程度如何？
2. 需要做哪些检查？能不能先把身体问题排除掉？
3. 如果需要吃药，常见副作用有哪些？大概多久能感觉到变化？
4. 一般要治疗多久？能不能自己停药？
5. 需不需要配合心理咨询？哪里能做？
6. 生活上（睡眠、咖啡、运动、饮酒）我该注意什么？
7. 下次什么时候复诊？出现什么情况要立刻回来？

你的问题：

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

八、就诊当天要带的东西（出门前对照）

- [ ] 身份证、医保卡
- [ ] 这本填好的"就诊前准备清单"

- [ ] 既往病历本、出院小结、所有检查报告
- [ ] 正在吃的所有药的药盒（或手机拍照）
- [ ] 一支笔、一张纸（记医生说的要点）
- [ ] 手机（可用于拍照、录音——录音先征得医生同意）
- [ ] 如有强烈自伤念头或身体极度不适，请家属陪同前往

九、就诊当天的小提醒

- **先挂普通号**：初诊普通号足够评估，不必一上来抢专家号。
- **说具体事，别下诊断**：别说"我觉得我是焦虑症"，说"过去三周几乎每天凌晨两三点醒，心慌得睡不着，已经请假两次"。
- **该说的别瞒**：喝酒、偷偷吃药、自伤念头——当着家属不好说，可以请医生安排单独谈话。
- **没听清就问**："这个药怎么吃？多久起效？什么情况要回来？"——问清楚是你的权利。

【个人体验】很多人离开诊室时反而松了口气："原来我那些乱七八糟的难受，是有名字、有办法的。"

十、一句话总结

花十分钟把这张表填好，胜过在诊室里紧张地回忆半小时。 它不是考试，是你和医生之间的"交接单"。

参考来源

- NICE：Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults, management, CG113（病史采集与评估流程）
- WHO mhGAP：Assessment and management guide
- 中华医学会精神医学分会. 《中国焦虑障碍防治指南》.
- APA：DSM-5 焦虑障碍诊断
- NIMH：Anxiety Disorders

4. 诊断流程与评估量表

> 很多人以为"焦虑是聊出来的"。其实正规诊断有一套流程：问诊、查体、必要的化验检查排除躯体疾病，再对照诊断标准。量表只是其中的**筛查和监测工具，不能单独确诊。**
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、医生是怎么诊断的（四步）

步骤	内容	你需要做的
1. 详细问诊	症状、起病时间、频率、对生活影响、诱因、既往史、家族史	照实说、举例子，带准备好的记录
2. 体格检查	测血压、心率、听诊，必要时神经系统检查	配合检查
3. 必要的化验/仪器检查	血常规、甲功、血糖、心电图等，排除甲亢、心律失常、贫血等"伪装成焦虑"的病	按医嘱抽血、做检查
4. 对照诊断标准	结合 DSM-5 / ICD-11 标准，判断属于哪类焦虑、是否共病	由医生下结论，你不必自己套

【临床共识】焦虑障碍没有"拍个片子就知道"的仪器，它是**临床诊断**——靠病史+排除躯体疾病+对照标准。这也解释了为什么医生总要你先查甲功、做心电图。

二、诊断标准里的"病程"，由医生判断

【临床共识】以广泛性焦虑障碍（GAD）为例，诊断标准之一是"对诸多事件或活动过度焦虑和担忧"持续**至少6个月**；惊恐障碍则要求一次发作后出现持续的担忧、行为改变。**这些时间门槛是医生面诊时综合判断的，你不必自己在家掐日历**——症状难受、影响生活就该来看。

三、GAD-7 广泛性焦虑自评量表（完整给出）

> 【重要声明】**GAD-7 仅用于筛查和症状监测，不能用来确诊。** 分数再高，也必须由精神科医生面诊下结论。它是"体温枪"，不是"诊断书"。

使用方法：回顾**过去两周**，下列情况对你造成困扰的频率，在对应格子打勾。每题 0–3 分：

- 0 = 完全不会
- 1 = 有几天
- 2 = 一半以上天数
- 3 = 几乎每天

序号	条目（过去两周）	0	1	2	3
1	感觉紧张、焦虑或急切				
2	不能停止或控制担忧				
3	对各种各样的事情担忧过多				
4	很难放松下来				
5	由于不安而无法静坐				
6	变得容易烦恼或急躁				
7	感到似乎将有可怕的事情发生而害怕				

总分 = 7 题相加，范围 0–21 分。

总分	程度参考	建议行动
0–4	无明显焦虑	日常自我照顾即可
5–9	轻度	关注变化、规律作息；持续不适可咨询
10–14	中度	建议就诊评估，常需心理治疗或药物
15–21	重度	建议尽快就医，通常需药物/心理联合

【研究结论】GAD-7 由 Spitzer 等于 2006 年发表，在总分约 10 分附近筛查广泛性焦虑的敏感度和特异度都较好，是目前全球门诊最常用的焦虑筛查工具。但它筛的是"广泛性焦虑"这一类，**不覆盖惊恐、社交焦虑、强迫症等全部亚型。**

四、医生常一起开的其他量表（了解即可）

量表	查什么	备注
PHQ-9	抑郁症状（9题）	焦虑和抑郁高度共病，常一起填
PDSS	惊恐障碍严重程度	评估惊恐发作的频率与困扰
ASI（焦虑敏感指数）	对焦虑躯体感受本身的恐惧	解释"为什么怕心慌"
ACES	童年不良经历	评估创伤背景
LSAS	社交焦虑障碍严重度	害怕被评价、回避社交者用
Y-BOCS	强迫症严重度	用于区分强迫症（反复检查、清洗）
HAMA（汉密尔顿焦虑量表）	**他评量表**	由医生/评估者访谈打分，**你不需要自己填**

【临床共识】HAMA、HAMD 这类是**他评量表**，别在网上找"自评版"给自己打分；自评就用 GAD-7、PHQ-9 这类标准化工具。

五、量表的正确用法（务必记住）

1. **按真实感受填**，不要为了"显得轻"或"想确诊"改答案。
2. **一周最多测一次。**天天看分数涨跌，分数本身会变成新的焦虑源。
3. 用**同一份量表、同一回顾周期**前后比较，别今天 GAD-7、明天换个网上的"焦虑测试"。
4. 把分数和日期记下来，**复诊时带给医生看**——比你说"好像好一点"更有用。
5. 分数下降 ≠ 可以停药；分数升高也不必恐慌，结合"能不能上班、能不能见人"一起判断。
6. 网上各种"三分钟测焦虑"小程序鱼龙混杂，**以 GAD-7、PHQ-9 等标准化量表为准。**

六、量表不能回答的问题

- 不能告诉你"是不是心脏病/甲亢"——那要靠检查；
- 不能区分是广泛性焦虑、惊恐还是社交焦虑——那要靠医生问诊；
- 不能预测"多久能好"——那要看治疗反应和你自己的努力。

【个人体验】一位患者说："我在网上测到18分，吓得一夜没睡。后来医生说，分数只是提醒我该来看病了，不是判决书。"

七、一句话记住

诊断靠医生面诊+查体+排查躯体疾病；量表是温度计——告诉你烧到多少度，但不会告诉你得的是感冒还是肺炎。拿分数去找医生，别拿分数给自己判刑。

参考来源

- Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. **A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7.** *Arch Intern Med*. 2006;166(10):1092-1097. doi:10.1001/archinte.166.10.1092
- Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW. The PHQ-9. *J Gen Intern Med*. 2001;16(9):606-613.
- NICE：Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults, CG113
- APA：DSM-5 焦虑障碍诊断标准
- WHO：ICD-11 焦虑或恐惧相关障碍
- 中华医学会精神医学分会.《中国焦虑障碍防治指南》.

5. 常见共病

> 焦虑很少"孤零零"地来。它常常和抑郁、失眠、躯体不适、其他心理问题手拉手出现。**知道它们为什么一起来、就诊时该怎么说，能让医生一次抓住重点，少走弯路。**
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、什么是"共病"

共病（comorbidity）指同一个人同时符合两种或更多疾病/问题。【临床共识】焦虑障碍的共病非常普遍——这不是"你问题特别多"，而是这个谱系本身就容易互相叠加。

二、焦虑 + 抑郁：最常见的一对

维度	焦虑	抑郁
核心感受	过度担心、紧张、怕未来	情绪低落、兴趣减退、觉得没希望
身体表现	心慌、出汗、坐不住	疲乏、早醒、食欲/体重变化
时间指向	担心还没发生的事	觉得过去和未来都没意义

【研究结论】门诊焦虑患者中，半数以上同时存在不同程度的抑郁；反过来也一样。两者共享生物学基础（5-羟色胺、去甲肾上腺素系统）和心理社会诱因，常互相加重：长期焦虑消耗人→情绪低落→更没力气应对→焦虑更重。

【临床共识】所以医生常让你同时填 GAD-7（查焦虑）和 PHQ-9（查抑郁）。**只要 PHQ-9 第 9 题（自伤念头）得分≥1，无论总分多少，都要立刻告诉医生或联系求助资源。**

三、焦虑 + 失眠障碍

长期入睡困难、早醒、睡不解乏，是焦虑最常见的"伴生品"。【临床共识】二者互为因果：越怕睡不着越睡不着，越睡不好第二天越容易慌。治疗上往往把睡眠稳定作为重要抓手，但**不要自行买安眠药长期吃**，由医生评估。

四、焦虑 + 躯体症状障碍（"查不出原因的身体不舒服"）

反复心慌、胸闷、头晕、肠胃不适、疼痛，跑了心内科、消化科查不出明确问题——这在临床上叫躯体症状相关障碍，与焦虑高度重叠。【临床共识】这不是"装病"，而是情绪被身体"翻译"出来了。就诊时建议挂**心身医学科**，或在精神科就诊时把所有检查报告带上。

五、焦虑与强迫症（OCD）、创伤后应激障碍（PTSD）的关系

问题	典型表现	与一般焦虑的区别
强迫症 OCD	反复检查、清洗、计数，脑子被侵入性想法占据	有"明知没必要却停不下来"的强迫思维/行为
PTSD	创伤后反复闪回、噩梦、回避相关场景、过度警觉	有明确创伤事件作为起点

【临床共识】它们在 DSM-5/ICD-11 里已被单列为独立诊断（不再笼统归为"焦虑"），但彼此常共病、也常和广泛性焦虑/惊恐一起出现。**就诊时主动告诉医生你有没有反复检查、有没有创伤闪回**，会直接影响治疗方向。

六、焦虑 + 物质使用

- **酒精**：短期"助眠放松"，长期加重焦虑、戒断时焦虑反跳；
- **咖啡因/能量饮料**：直接诱发心慌、惊恐样发作；
- **镇静类药物**：自行长期服用易依赖，突然停用焦虑失眠反跳。

【临床共识】如果你开始靠喝酒、靠某种药才能放松入睡，一定如实告诉医生——这本身就是需要处理的问题，隐瞒会让治疗方案偏掉。

七、焦虑 + 躯体疾病

躯体疾病	与焦虑的关系
心血管疾病（冠心病、心律失常、高血压）	互相加重，惊恐发作易被误判为心脏急症
甲状腺功能亢进	心慌手抖消瘦，表现酷似焦虑，必须先排查
糖尿病/低血糖	低血糖发作像惊恐
肠易激综合征（IBS）	脑肠轴互动，焦虑与腹泻便秘互相影响
慢性疼痛、更年期	长期不适诱发和维持焦虑

【临床共识】这就是为什么初诊常查心电图、甲功——把"身体能解释的"先排除，焦虑的诊断才干净。

八、共病如何影响治疗与就诊沟通

1. **就诊时一次说全**：焦虑、失眠、情绪低、喝酒助眠、反复检查——都讲，别只挑最难受的那个。
2. **治疗常需多管齐下**：药物可能同时覆盖焦虑与抑郁；心理治疗可能要兼顾认知调整和睡眠/暴露练习。
3. **不要只治一半**：只处理焦虑、忽略抑郁，或只吃安眠药、不处理焦虑，都容易反复。
4. **耐心一点**：共病意味着需要更长一点的评估和调整期，不是"药没用"。

【个人体验】有患者说："原来我不是'又焦虑又抑郁又失眠又肠胃不好'四个病，而是一套互相牵着的东西，医生一次调，反而比我分头看几个科清楚多了。"

九、一句话记住

共病不等于"病得更重"，而是"更需要一次说清楚"。 就诊时把焦虑、情绪、睡眠、身体不适、喝酒喝咖啡的习惯一次讲全，医生才能给你一张完整的地图。

参考来源

- Huang Y, et al. Prevalence of mental disorders in China. *Lancet Psychiatry*. 2019;6(3):211-224. doi:10.1016/S2215-0163(18)30511-X
- NICE：Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults, CG113
- APA：DSM-5 焦虑障碍、强迫及相关障碍、创伤及应激相关障碍
- WHO：Anxiety disorders fact sheet
- 中华医学会精神医学分会.《中国焦虑障碍防治指南》.
- NIMH：Anxiety Disorders

模块 6

治疗方案

1. 药物治疗

> 焦虑障碍是一种有生物学基础的疾病，药物能帮你把过度激活的"警报系统"调回正常，但它不是"快乐药"，也不是吃了立刻见效的开关。本页只介绍药物类别、起效规律、常见反应与用药原则，**不涉及任何具体剂量、疗程天数与换药方案**——你吃哪种、吃多少、怎么停，必须由精神科医生根据你的情况决定。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、先建立几个正确预期

【临床共识】焦虑障碍（广泛性焦虑、惊恐障碍、社交焦虑、场所恐惧等）有其生物学基础：大脑的威胁检测系统（涉及 5-羟色胺、去甲肾上腺素、γ-氨基丁酸等神经递质）过度敏感，长期处于"拉响警报"的状态。药物针对的是这个**失调的系统**，而不是你的性格。

- 药物不是"给你灌快乐"，而是**把焦虑强度降下来**，让你有精力去做心理治疗、调整生活。
- 多数人需要的是"药物 + 心理治疗 + 生活调整"的组合拳，单用或联合由医生评估。
- 【研究结论】规范治疗下，多数焦虑障碍患者的症状会明显改善、生活功能恢复。即使第一种药效果不理想，也有换用、联合等多条路，不要因为一次效果不好就认定"药对我没用"。

【个人体验】很多人第一次拿到药盒时会紧张："我是不是一辈子都要吃药了？""会不会上瘾？"——后面"用药常见顾虑"一节会专门客观回答。

二、常见抗焦虑/抗抑郁药物类别与代表通用名

下面只列**类别和通用名**，帮助你看懂医生处方和药品说明书，不代表你应该自行选用。

类别	代表通用名	大致特点与提示
SSRI（选择性5-羟色胺再摄取抑制剂）	艾司西酞普兰、舍曲林、帕罗西汀、氟西汀、氟伏沙明、西酞普兰	**一线首选**，对广泛性焦虑、惊恐、社交焦虑、场所恐惧均有效；起效需数周；不同人对其中某一种反应差异较大，常需试选
SNRI（5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂）	文拉法辛、度洛西汀	**一线选择**，对伴躯体不适、疼痛、乏力的焦虑有时更合适；文拉法辛部分人血压会轻度升高
5-HT1A 部分激动剂	丁螺环酮、坦度螺酮	专门用于广泛性焦虑，不成瘾、镇静轻，但起效慢、对惊恐效果有限
苯二氮䓬类	阿普唑仑、劳拉西泮、氯硝西泮、地西泮等	**起效快**，能快速镇静；但长期使用可产生依赖与耐受，有嗜睡、跌倒风险，不可与酒精同用，**不可自行突然停用。**医生通常短期、按需、有限使用（详见后文）
非苯二氮䓬类催眠药	唑吡坦等	主要用于短期助眠，不是抗焦虑主药，同样不宜自行长期连续使用
三环类等老一代抗抑郁药	氯米帕明、阿米替林、多塞平等	疗效确切，但副作用（口干、便秘、心慌、体位性头晕）较多、过量危险，现多作为二线或特定情况使用

类别	代表通用名	大致特点与提示
β受体阻滞剂	普萘洛尔等	不治疗"心里的焦虑"，但能减轻**躯体性表现**（心跳过快、手抖、声音发颤），常用于演讲、临场表演前的"表现焦虑"，是否适合需医生评估
其他	曲唑酮（常利用其镇静助眠）、米氮平等	多根据失眠、食欲等伴随症状选择

【临床共识】**不推荐你自行使用**抗组胺药（如某些"安神"西药）、中成药、保健品来"治焦虑"。NICE 等指南明确指出，镇静类抗组胺药不应用于惊恐障碍的长期治疗；中成药、保健品成分复杂，可能与处方药发生相互作用，想用必须先告诉医生。

【争议观点】"是药三分毒，能不吃就不吃"是很多人的本能。但客观看：中重度焦虑长期不治疗，本身会损害睡眠、工作、人际关系，并增加共病抑郁的风险；在医生指导下规范用药的收益，通常大于可控的副作用。

三、起效规律：最容易让人半途而废的一关

这是本页最重要的一节，请耐心读完。

时间窗	通常发生的变化	你的正确做法
服药最初几天～1周	几乎感觉不到焦虑下降；反而可能出现恶心、头晕、犯困，或短暂的焦虑/坐立不安加重	**不要急着停药。**这是身体在适应，尤其 SSRI/SNRI 初期可能短暂"闹一下"
约2–4周	紧张、心慌、入睡困难等可能先开始松动；情绪的改善往往滞后	坚持按医嘱服药，记录身体反应
约6–8周	多数人在此阶段才能较充分地评估这一种药是否对症	复诊，由医生判断疗效与是否需要调整

【临床共识】SSRI/SNRI **不是吃了立刻平静的药。**它通常在数周内逐步起效。"吃了一两周没感觉就停"是最常见、也最可惜的做法——往往在药快要起效时被停掉。苯二氮䓬类则相反，起效以"分钟~小时"计，但正因如此才要警惕依赖，不能把它当长期主力。

四、副作用：短期不适 vs 必须尽快告诉医生

副作用个体差异很大，**多数早期不适会在1–2周内自行减轻**，不要因轻微反应就自行停药。但你要能分清"忍一忍会过去"和"必须马上说"。

A. 短期常见不适（多在1–2周内逐渐减轻）

- 轻度恶心（通常随餐或饭后服用可缓解）
- 头痛、轻微头晕
- 口干、轻度腹泻或便秘
- 嗜睡（苯二氮䓬类尤其明显），或相反的轻度失眠
- 服药初期短暂的焦虑、坐立不安感
- 苯二氮䓬类：乏力、反应变慢、走路不稳

B. 需要在复诊时主动告诉医生（不一定停药，但要被记录和处理）

反应	说明
性功能方面的变化（性欲、高潮困难等）	较常见，尤其 SSRI；很多人不好意思说，但**这是可以和医生讨论、调整的**，不必默默忍受
体重或食欲明显变化	部分药较明显；可结合饮食运动一起管理
异常多汗	部分人会出现
持续便秘、排尿不畅	需医生评估
血压变化（尤其用文拉法辛者）	可自我监测，复诊告知
白天过度嗜睡、走路不稳（尤其老年人）	与苯二氮䓬类相关，需医生调整，防跌倒

C. 危险信号：出现以下任何一条，尽快联系医生或急诊

危险反应	典型表现	行动
5-羟色胺综合征	高热、意识混乱、明显激越、肌肉僵硬或不自主抽动、大汗淋漓、心跳很快	**立即急诊**，这是急症；常发生在叠加其他升高5-羟色胺的药/物质时
诱发躁狂/轻躁狂	突然异常兴奋、话多、睡眠需要明显减少、冲动消费、觉得自己特别厉害	**立即复诊**——这提示可能是双相情感障碍，治疗方向会改变
异常出血/瘀斑	无故牙龈出血、黑便、皮肤大片瘀斑	尽快就医
低钠血症	老年人体位性头晕、乏力、意识模糊、抽筋	尽快就医
皮疹、过敏	服药后新发皮疹，尤其伴发热	停药并就医
心悸、晕厥感	尤其用药后新发	告知医生，必要时查心电图

【临床共识】**5-羟色胺综合征**是焦虑/抑郁用药中最需要警惕的急症之一：如果你在服用 SSRI/SNRI 的同时，自行叠加了圣约翰草（贯叶连翘）、某些感冒药/止痛药、其他抗抑郁药，或短期内加量，出现高热+意识混乱+肌肉僵硬，不要犹豫，立即急诊。

五、苯二氮䓬类：把"上瘾"这件事说清楚

这是焦虑患者最常纠结的一类药，单独拿出来客观讲。

- **它的优点**：起效快（分钟到小时级），能快速压下一次严重的惊恐或急性焦虑，让你先"缓过来"。
- **它的代价**：连续使用数周以上，身体会**耐受**（同样效果需要更大剂量）和**依赖**（不吃就难受、睡不着、反跳性焦虑更重）；长期用还可能影响记忆、增加跌倒风险（尤其老年人）。
- **它的铁律**：
  1. **不可与酒精同用**——两者叠加会过度抑制呼吸和中枢，有致命风险；

2. **不可自行突然停用**——长期用后骤停可能诱发严重戒断（抽搐、剧烈焦虑、失眠）；
3. 医生通常只让你**短期、按需、有限度**地用它来"救急"，而不是天天长期吃。

【临床共识】所以正确的用法是：苯二氮䓬类像"创可贴"，用来度过急性发作的头几周；真正长期治本靠的是 SSRI/SNRI 这类不成瘾的药，加上心理治疗。等你的长效药起效了，医生会帮你慢慢把苯二氮䓬类减下来。

六、用药总原则：足量、足疗程、不擅自停

1. 为什么要"足疗程"

焦虑障碍治疗通常分三个阶段（具体时长由医生根据你的发作次数和严重程度决定）：

阶段	大致目标	你需要知道的
急性期	控制症状，达到临床缓解	通常需要数周～数月，药要吃够、吃对
巩固期	防止症状刚好转就反弹	症状消失后**仍需继续服药一段时间**，因为"感觉好了"不等于"病好了"
维持期	降低复发风险	反复发作、有家族史者，维持治疗更重要

【临床共识】很多人"一感觉好转就自己停药"，结果在数月内复发，而每复发一次，未来复发的风险就升高一截。**过早自行停药是复发最常见的人为原因之一。**

2. 为什么不能突然停药

抗焦虑/抗抑郁药（尤其 SSRI/SNRI，以及苯二氮䓬类）突然停掉，可能出现：

- **撤药反应**：头晕、像被电击一下的感觉、恶心、类似感冒的不适、烦躁、失眠、情绪波动；
- **反跳**：原来的焦虑、惊恐在停药后比之前更猛烈地回来。

撤药反应本身通常会逐渐过去，但它容易被误读为"我又病了"而慌乱；更重要的是，**突然停药会显著升高复发风险。**

【临床共识】停药必须在医生指导下**缓慢、逐步减量**，给身体适应的时间。哪怕你已经决定要停，也要先和医生约好节奏。

3. 漏服了怎么办

- **不要下次自己加倍补吃**，那会增加副作用风险。
- 想起来时若离下次服药还久，按医嘱补服一次即可；若已接近下次服药时间，跳过这次、按原计划继续。
- 记不清、拿不准时，问开药医生或药师，而不是凭感觉加倍。

七、相互作用与特殊情况

- **酒精不能代替药物**：酒精让人短暂昏沉，但会破坏睡眠、加重焦虑反跳、与苯二氮䓬类/镇静药叠加抑制中枢，是焦虑康复中的"假放松"。

- **不得自行叠加圣约翰草（贯叶连翘）等保健品**：它会与很多药物相互作用，甚至诱发5-羟色胺综合征。正在服用、打算开始服用任何其他药物、保健品、中成药，都要告诉医生。
- **妊娠、备孕、哺乳**：这是需要医生与孕妇共同权衡的决策——不治疗的中重度焦虑本身对母亲和胎儿也有风险。**如果你在备孕或已怀孕，不要自行停药**，尽快告知医生。
- **老年人**：更易出现低钠、体位性低血压、跌倒，苯二氮䓬类尤其要慎用，起始剂量常更小。
- **合并躯体疾病**（心脏病、高血压、肝肾疾病等）：药物选择需医生个体化权衡，复诊时务必带上完整用药清单。

八、用药常见顾虑答疑

你的担心	客观说明
"会不会上瘾、一辈子戒不掉？"	SSRI/SNRI、丁螺环酮**不属于成瘾性物质**，不会越吃越想要。"需要长期吃"是因为疾病本身容易复发，就像降压药需要长期吃一样，不是成瘾。**苯二氮䓬类才是有成瘾风险的那一类**，所以医生会短期、有限使用。
"吃了会不会变傻、反应变慢？"	少数人初期会有犯困、思维略钝，多在适应后缓解；焦虑本身才是让人注意力、记忆力下降的原因。规范治疗后，很多人反而觉得脑子更清楚。
"好了不就可以停了吗？"	恰恰相反——"感觉好转"是治疗起效的信号，但巩固和维持期是用来**防止反弹**的。自行过早停药，是复发最常见的原因。
"我靠自己扛行不行？"	轻度可尝试心理治疗和生活调整；但中重度焦虑时，"硬扛"常常错过最佳干预期，药物能帮你恢复到有能力做心理治疗和自我调节的状态。
"网上说这药副作用特别吓人？"	【争议观点】网上把药说得极可怕或极无害都不真实：它确实有副作用和需要监测的风险，但在医生指导下规范使用是安全、成熟的治疗手段。

九、一张表看懂用药全过程

阶段	时间感	重点任务	复诊节奏
启动期	第1–2周	适应副作用、监测初期情绪变化、不漏服	按医嘱，有危险信号随时就医
起效期	第2–6周	观察紧张/心慌/睡眠变化，记录反应	复诊评估
充分评估期	第6–8周	判断疗效，决定是否继续/调整	复诊
巩固期	症状消失后数月	不擅自减停，配合心理治疗与生活重建	规律复诊
维持期	反复发作人群	长期管理，与医生商定维持时长	定期复诊

十、你可以现在就做的三件事

1. 把正在吃/准备吃的药名（通用名）记在手机里，复诊时主动告诉医生你的身体反应。
2. 告诉一位你信任的家人/朋友你在治疗中，让他在你"想自行停药"时提醒你先问医生。
3. 把开药医生/医院的联系方式存好，尤其是出现危险反应时知道找谁。

> **再次提醒**：本页所有内容用于帮助你理解治疗、更好地和医生沟通。**具体用药、剂量、加减停，必须由精神科面诊医生决定。** 如果你正在经历剧烈胸痛、心悸、呼吸困难且是第一次出现，请先按本资料库《模块7》的应急提示排查心脏等器质性问题，而不是只盯着药物。

参考来源

- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Anxiety Disorders*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- 美国精神医学学会（APA）：*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*；及焦虑障碍临床实践指南。
- 《中国焦虑障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。
- 加拿大情绪和焦虑治疗网络（CANMAT）成人焦虑障碍管理指南。
- 苯二氮䓬类依赖与撤药风险：参考 NICE CG113 关于苯二氮䓬类短期使用的建议及 WHO 相关药物安全警示。

2. 心理治疗

> 心理治疗不是"找人聊聊天想开点"，而是一套有理论、有结构、有证据的专业干预。对焦虑障碍而言，**认知行为治疗（CBT）是证据最充分的一线心理治疗**，它和药物不是二选一：轻度可优先单用心理治疗，中重度通常建议药物与心理联合。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行确诊。

一、先理解：焦虑是怎么被"想"出来又"做"出来的

CBT 有一个非常朴素的核心模型，请记住这条链条：

> **情境 → 自动想法 → 情绪 → 行为**

【临床共识】让你痛苦的往往不是事件本身，而是你**瞬间对事件的解释**。举个焦虑患者的典型例子：

- **情境**：开会前心跳有点快。
- **自动想法**："完了，我马上要在所有人面前失控晕倒。"
- **情绪**：恐惧、紧张飙升。
- **行为**：请假、回避开会。

问题在于：**回避**暂时缓解了焦虑，但它在心里"记下"了"刚才那个场景是危险的"，下次更怕。这就是焦虑被长期维持的恶性循环。CBT 做的事，就是在这条链条上拆两端：
- **认知端**：检验那些自动想法是不是灾难化了；
- **行为端**：通过暴露，让人重新学会"那个场景其实是安全的"。

二、常见心理治疗方法一览（针对焦虑）

疗法	核心理念	适合哪类焦虑	大致形式
CBT 认知行为治疗	情绪受"我们如何解释事情"影响；通过认知重构 + 行为改变打破焦虑循环	**各型焦虑的一线选择，证据最强**（广泛性焦虑、惊恐、社交焦虑、场所恐惧、特定恐怖症）	结构化，通常8–16次，每次约45–60分钟，有议程、有家庭作业
暴露疗法（CBT 的核心技术）	恐惧通过"回避"被维持；只要安全地、反复地面对恐惧，焦虑会自然下降（习惯化/消退）	惊恐障碍、特定恐怖症、社交焦虑、场所恐惧——针对性最强	由治疗师设计恐惧阶梯，逐级练习（详见《模块7》暴露练习）
放松训练/呼吸控制	通过调节呼吸和肌肉，打断"躯体紧张→更焦虑"的循环	各型焦虑的辅助，尤其伴明显躯体紧张者	可自学、可引导
正念（MBSR / MBCT）	学会觉察"我有一个焦虑的想法"而不被它卷走，与念头拉开距离	广泛性焦虑、反复发作焦虑的辅助与预防	团体8周课程，每天家庭正念练习

疗法	核心理念	适合哪类焦虑	大致形式
行为激活	焦虑让人退缩、退缩又加重焦虑；从一点点恢复有意义的活动入手	焦虑伴动力低、生活停滞者	结构化，记录活动与情绪
精神动力学治疗	探索早期关系与潜意识冲突如何影响当下焦虑	希望深入了解自己、问题较慢性、与人际模式相关者	长程，频率较高
人本/支持性心理治疗	在无条件接纳的关系中稳定情绪、恢复信心	症状较重、或作为其他治疗的辅助	较灵活，以支持陪伴为主

【临床共识】在这些方法中，**CBT（含暴露）对焦虑障碍的证据最充分**，被 NICE、APA 等指南列为一线心理治疗。正念、放松训练是有效的辅助；精神动力学、人本等流派在特定人群和诉求下有价值，但作为"快速、结构化缓解焦虑"的首选，证据不如 CBT 强。

三、一个标准 CBT 疗程大致长什么样

很多人对"做心理治疗"没有概念，下面是一次典型 CBT 的结构（每次约45–60分钟）：

1. **签到与议程**：和治疗师一起定今天聊哪几件事。
2. **检查家庭作业**：上周布置的练习做了吗？发现了什么？
3. **处理一个当下问题**：围绕你最近最困扰的焦虑情境，一起拆"情境—自动想法—情绪—行为"。
4. **认知重构**：像法庭一样，为这个自动想法找"支持的证据"和"反对的证据"，生成更平衡的替代想法。
5. **布置新作业**：可能是记思维记录表、做一次逐级暴露、练一次呼吸。
6. **小结**：这次你带走的一个关键点是什么。

【个人体验】CBT 的"反直觉"之处在于：它不哄你"别担心"，而是带你**像科学家一样检验自己的担心**——"我估计这事90%会发生，证据呢？"练多了，你会发现自己的脑子开始自动这么干，这就是它"治本"的部分。

四、暴露疗法：为什么"怕什么偏要面对什么"

暴露是 CBT 治疗惊恐、恐怖症、社交焦虑、场所恐惧最有力的技术，原理有两个：

- **恐惧消退**：当你安全地反复待在恐惧情境里、没有真的出事，大脑会重新学习"这个情境其实不危险"；
- **习惯化**：在一次暴露中，焦虑会先升后降，只要你不逃，它通常会在数十分钟内自然回落。

配套的还有**反应阻止**：比如强迫性检查、反复求安慰、携带"安全物品"等行为要一并停止，否则大脑学不到"不做这些也安全"。

【临床共识】暴露有效，但**必须分级、可控、不硬扛**——具体怎么给自己建"恐惧阶梯"，见《模块7：渐进式暴露练习》。严重者、场所恐惧、PTSD 共病者务必在治疗师指导下进行。

五、药物与心理治疗：怎么选、怎么联合

【临床共识】综合各国指南：

- **轻度焦虑**：可先单用心理治疗（如 CBT）、加强运动、社会支持，定期观察。

- **中度至重度焦虑**：通常建议**药物治疗 + 心理治疗联合**，效果往往优于单用其一，且联合治疗的复发率更低。
- **出现以下情况，不能只做心理治疗**：严重惊恐频繁发作到无法出门、明显自杀风险、伴有幻觉妄想等精神病性症状——这些需要先由精神科处理。

【个人体验】一个常见的误区是"只靠药不做心理"或"只靠谈话坚决不吃药"。前者容易一减药就反弹（因为没学会应对技巧），后者在中重度时往往迟迟压不住症状、人一直耗在痛苦里。最佳状态往往是两者互补：药帮你降到"能做心理治疗"的程度，心理治疗帮你学会"以后不靠药也能稳住"。

六、谁是"精神科医生"，谁是"心理咨询师"

很多人混淆这两个角色，分工其实很清楚：

	精神科医师	**心理治疗师/心理咨询师**
能否下诊断	能	不能（可做心理评估与咨询）
能否开药	**能**	**不能**
主要工作	药物治疗、严重病例管理、危机处理、住院	谈话治疗、CBT/暴露等干预、心理支持
常见配合	医生管"药"，治疗师管"聊"，二者协作	

【个人体验】理想状态下，你是一个"团队"：精神科医生把控药物与安全，心理治疗师带你做暴露和认知工作。如果有人只聊几次就急着给你开药，或只做咨询却告诉你"你不用吃药、光聊天就能好"，都值得多问一句、换一家正规机构核实。

七、如何选择合格的治疗师

选择时可以留意：

- **资质与受训**：有正规学历/受训背景，明确受训于 CBT 等有证据的流派，属于可查证的专业体系；
- **会做评估和转介**：发现需要药物或住院时，会建议你同时看精神科，而不是硬留在咨询里；
- **督导与伦理**：持续接受督导，遵守伦理边界（不发展双重关系、不与你建立治疗以外的亲密/商业关系）；
- **保密与边界清晰**：会事先说明保密的范围（如自伤伤人风险时需要突破保密、联系紧急联系人）；
- **可教可练**：好的 CBT 治疗师会给你具体工具、布置可操作的作业，而不是只听你倾诉。

八、咨询设置、脱落与换治疗师

【临床共识】研究反复发现，**治疗关系的质量**（你是否感到被尊重、被听见、安全）对疗效的预测力，不亚于用的是哪种具体技术。这意味着：

- 如果在某段关系里你总觉得被评判、被说教、不被理解，换一个治疗师是合理的，**这不代表"你不适合做心理治疗"**。
- 心理治疗不会一次见效，它更像健身——需要规律、需要练习、会有反复。
- **脱落（中途放弃）很常见**，往往不是因为你"没救"，而是因为前几次触及痛苦、或还没看到进展。可以和治疗师直接讨论"我有点想放弃"，这本身就是有用的素材。

什么时候该考虑换治疗师

- 他/她总是迟到、随意取消、不遵守约定；
- 不给你解释、催促你做不想做的事；
- 与你发展出治疗以外的暧昧/金钱/商业关系；
- 你感到长期不被尊重，或几次下来毫无进展且不与你讨论原因。

换治疗师是你的权利，不必有心理负担。

九、线上咨询的利与弊

形式	特点
门诊面对面	最经典，适合多数人，尤其需要严密观察、危机处理时
线上视频/电话咨询	方便、可及、省去路途，对出行不便（场所恐惧）者尤其友好；CBT 的结构化内容线上同样有效
自助 CBT 程序/APP	成本低、可随时用，适合轻度或作为线下治疗的补充，但**重度者不能只靠它**

【争议观点】线上心理治疗可及性很好，但对于有较强自杀风险、频繁惊恐需要即时稳定的人，线下精神科随访更稳妥。自助 APP 适合"热身"，但别把它当成专业治疗的全部。

> **提醒**：心理治疗有效，但它需要时间和你的参与。如果你目前症状很重、连来做治疗的精力都没有，请先就医（精神科/急诊），把状态稳定一些，再开始心理工作效果更好。配合《模块7》的自我调节练习，会让治疗事半功倍。

参考来源

- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Anxiety Disorders*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- Barlow DH, Craske MG. *Mastery of Your Anxiety and Panic*（暴露与认知治疗经典手册）；及 Craske MG 等关于暴露疗法与恐惧消退的综述。
- 《中国焦虑障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。
- 正念对焦虑的辅助疗效：MBCT/MBSR 治疗焦虑障碍的系统综述与 Meta 分析（见 PubMed 34650179 等接受与正念干预综述）。
- 美国精神医学学会（APA）：焦虑障碍临床实践相关指南。

3. 物理治疗

> 物理治疗（又称"神经调控"或躯体辅助治疗）在焦虑障碍中属于**辅助或二线手段**，不能替代一线的药物治疗和 CBT 心理治疗。本页帮你看懂这些方法各是什么、证据到什么程度，以及哪些营销话术要警惕。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行确诊。

一、一句话先定位

【临床共识】焦虑障碍的一线治疗永远是：**心理治疗（尤其 CBT/暴露）± 药物治疗（SSRI/SNRI 等）**。物理治疗是在一线效果不足、或有药物禁忌/不耐受时，由医生评估加用的选项——它不是"更高级的首选"。

二、重复经颅磁刺激（rTMS）

- **是什么**：用磁场无创地刺激大脑特定区域的皮层，调节神经活动。治疗时你坐着，头上戴一个线圈，能听到"哒哒"的敲击声、头皮有轻敲感。
- **适用与证据**：【研究结论】rTMS 在**难治性抑郁**中证据较充分；对焦虑障碍（如广泛性焦虑、惊恐、强迫相关焦虑）也有研究支持，部分指南将其作为药物/心理治疗效果不佳后的辅助选择。但证据强度**弱于**抑郁，并非所有焦虑亚型都一致有效。
- **疗程体感**：通常需要多次、按疗程进行（具体次数和频率由医生设定），多数人耐受性较好，常见轻微头皮不适、头痛，少见癫痫等严重风险（有癫痫史者需特别告知医生）。

【个人体验】如果你在网上看到"做几次磁疗根治焦虑"，要警惕——rTMS 是一个需要医生评估、按疗程进行的医疗手段，不是美容院式的"保养项目"。

三、生物反馈（Biofeedback）

- **是什么**：用仪器把你自己意识不到的生理信号——**心率变异性（HRV）、肌电（肌肉紧张）、皮温、皮电**——实时变成屏幕上的曲线或数字，让你学会"看着自己的身体"去调节它。
- **作用定位**：它不是直接治病，而是一个**训练工具**：通过看得见的反馈，帮你学会放松肌肉、放慢呼吸、提高心率变异性，从而缓解躯体性焦虑。
- **证据**：【研究结论】对伴明显躯体紧张、心悸、肌肉紧绷的焦虑有辅助效果，常与放松训练、呼吸训练结合使用。它安全、无创，适合作为自我调节的" instrumentation 教练"。

四、经颅电刺激（tDCS / tACS 等）

- **是什么**：用微弱直流电通过头皮电极刺激大脑。和 rTMS 同属神经调控，但强度更弱、设备更轻便。
- **证据现状**：【研究结论】对焦虑的研究还在积累中，证据不如 rTMS 成熟、结果不一致。**不建议自行购买家用设备长期使用**——电极放置、电流参数都需要专业判断。

五、针灸、瑜伽、太极等身心运动

- **针灸**：【研究结论】对焦虑有一定辅助效果的报道，但证据质量参差，不能替代一线治疗；若选择，应到正规医疗机构。
- **瑜伽、太极、气功**：【研究结论】这类身心运动结合了呼吸、放松和轻度运动，对轻中度焦虑有温和的辅助改善作用，作为生活方式调整是安全、值得推荐的（详见《模块7》放松练习与长期管理）。
- **定位**：它们是"好习惯"，不是"治疗"——练了它们不代表可以停掉医生开的药。

六、MECT（改良电休克治疗）要特别说清楚

【临床共识】**MECT 对单纯的焦虑障碍通常并不适用。** 它主要用于：重度抑郁伴强烈自杀/木僵、躁狂兴奋失控、精神病性症状等严重情况。只有当焦虑与这些严重状态共病、且其他治疗都无效时，才可能由精神科医生评估使用。

- 它和早年影视里那种"电刑"完全不同，是在麻醉、肌松下进行的现代医疗操作；
- 但**绝不是"治焦虑"的常规选项。**

【争议观点】如果你听到有人说"做电疗一次就把焦虑根治了""无痛电疗彻底告别紧张"，这要么是夸大，要么是在偷换概念——请回到正规精神科核实。

七、警惕这些营销话术

话术	真相
"电疗/磁疗根治焦虑，做几次断根"	物理治疗是辅助、需疗程、需医生评估，不存在"一次断根"
"纯天然无副作用，比吃药安全"	任何医疗手段都有适应范围和禁忌，"无副作用"本身就是不专业的说法
"在家戴个头环/电极帽就能治"	tDCS 等家用设备参数需专业判断，自行长期使用有风险
"不用做心理治疗、不用管生活，光做理疗就行"	违背一线治疗原则，焦虑的维持与认知、行为、生活方式高度相关

八、你该怎么和医生聊这件事

如果你考虑物理治疗，可以这样向医生提问：
1. 我这种焦虑亚型，一线的药物/心理治疗我都试过了吗？是否已经规范用足？
2. 以我的情况（有无癫痫史、妊娠、心脏起搏器等），rTMS 或生物反馈适合吗？
3. 它大概作为什么角色：替代、还是在现有方案上的补充？
4. 预期多久能评估效果、费用和频次如何？

> **再次提醒**：物理治疗是工具箱里的一把工具，不是万能钥匙。真正撑起康复的，是规范的一线治疗 + 《模块7》的自我调节。任何让你"放弃药物/心理治疗、只做理疗"的建议，都值得多问一句。

参考来源

- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Anxiety Disorders*；及 NIMH 关于脑刺激疗法（Brain Stimulation Therapies）的科普。https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- rTMS 对焦虑障碍的疗效：相关系统综述与 Meta 分析（见 PubMed 关于 rTMS for anxiety disorders 的综述）。
- 生物反馈/心率变异性（HRV）训练对焦虑的辅助：相关临床综述。
- 《中国焦虑障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。
- MECT 适应证：参考抑郁/精神病性障碍相关治疗指南，明确其并非单纯焦虑的一线治疗。

4. 治疗预期与目标

> 焦虑障碍的治疗不是"吃几天药、聊几次就根治"，而是一个分阶段、有波动、需要你参与的过程。本页帮你建立**现实的时间感和评价标准**，避免因为"没立刻好"而放弃，或因为"刚好一点"就停药。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、先纠正一个最大的误解

【临床共识】治疗焦虑，目标**不是把焦虑这种情绪彻底消灭**——焦虑是人类正常的警报系统，它本来就该在遇到真危险时响。我们要做的是：

- 把**过度、持续、脱离现实的焦虑强度**降下来；
- 把它对**睡眠、工作、人际、生活功能**的破坏减到最小；
- 让你重新获得"能正常生活"的能力，而不是"再也不紧张"。

【个人体验】康复者常说一句话："我还是会紧张，但紧张不再把我吃掉了。"这就是真实的、值得追求的目标。

二、治疗的三个阶段

阶段	大致目标	你需要知道的
急性期	减轻症状强度，把惊恐、持续紧张、失眠压下来，恢复基本生活	通常需要数周～数月；药要吃够、心理治疗要规律做
巩固期	防止症状刚好转就反弹，把刚学会的应对技巧练熟	症状消失后**仍需继续治疗一段时间**，因为"感觉好了"不等于"病好了"
维持期/预防复发	降低未来再次发作的风险	反复发作、有家族史者，维持治疗更重要；这一阶段你已掌握自我调节工具

三、现实的康复曲线：进两步，退一步

【临床共识】康复几乎从来不是一条向上的直线，而是**整体向上、中间反复波动**的曲线：

- 可能这两周明显好转，下周因为加班、熬夜、换季又糟糕一点；
- 可能一次小的应激就让惊恐复发一次；
- 但拉长时间看（数月），发作频率在下降、强度在下降、你应对它的速度在变快。

【个人体验】"退一步"不等于前功尽弃。判断有没有进步，不要看某一天的状态，而要看**这个月比上个月**：发作是不是少了？是不是恢复得更快了？是不是敢去以前不敢去的地方了？

四、怎么判断"到底有没有效"

【临床共识】疗效不能只凭"感觉"，要看两个维度：

1. **症状维度**：医生会用标准化量表（如广泛性焦虑量表 GAD-7、惊恐相关量表等）定期打分。**注意：这些量表只是筛查和随访工具，不能单独用来确诊或断药**——它的作用是让变化可量化。
2. **功能维度**：更重要的问题是——
   - 我还能不能正常上班/上学、完成基本事务？
   - 我晚上睡得着吗？
   - 我敢不敢去以前回避的地方、见以前回避的人？
   - 我和家人的关系、情绪怎么样？

很多人症状分数降下来了，但生活功能没恢复，说明还需要继续做心理治疗和生活调整，不能急着收尾。

五、给你的时间预期轴

下面是一个**大致的、供你心里有数**的时间感（个体差异很大，以你的医生判断为准）：

时间点	大致可以期待的变化
治疗第1个月	可能还在适应药物副作用、或刚开始做 CBT；症状未必大降，但睡眠、紧张感可能先松动。**这一阶段最容易因为"没感觉"而放弃，请坚持复诊。**
治疗第3个月	多数人在此阶段能看到较明显的症状下降：惊恐发作减少、持续紧张减轻、开始敢面对一些以前回避的场景。心理治疗的作业开始"内化"成你的自动反应。
治疗第6个月	症状接近稳定、生活功能明显恢复；进入巩固期，重点转向"不反弹"和"学会自己稳住"。此时你应该已经掌握了《模块7》的自我调节工具。

【争议观点】有人追求"三个月彻底断根、一辈子不复发"，这并不现实；也有人觉得"反正会反复，治了也白治"，这也不对。规范治疗能显著降低发作频率和强度，让你过上接近正常的生活——这才是可达成的现实目标。

六、最常见的四个治疗误区

误区	为什么错	正确做法
"吃了几天没效就换药/停药"	SSRI/SNRI 常需2–4周才起效，6–8周才能充分评估；太早放弃等于在药快起效时停掉	至少给足评估时间，复诊听医生判断
"症状一好就自己停药"	巩固期是用来防反弹的；过早停药是复发最常见的人为原因	在医生指导下逐步、缓慢减量
"只靠吃药，不做心理/生活调整"	药降强度，但应对技巧、认知模式要靠心理治疗和练习；只靠药容易一减就反弹	药物 + CBT/自我调节联合
"只靠谈话，坚决不吃药"	中重度时，硬扛会一直耗在痛苦里，药物能帮你降到"能做心理治疗"的程度	中重度建议联合，听医生权衡

七、什么时候要主动联系医生/复诊

- 按约定时间复诊（通常启动期更密，稳定后拉长间隔）；
- 出现《药物治疗》一页里列的危险信号（5-羟色胺综合征、诱发躁狂、新发心悸晕厥等）；

- 症状明显加重、惊恐频繁到影响生活；
- 你在认真考虑自行减药/停药——**先约医生，不要自己先动手。**

> **一句话总结**：焦虑障碍是可治疗、可康复的，但它需要时间、需要组合、需要你参与。把目标设成"慢慢恢复正常生活"，而不是"立刻彻底根治"，你会走得更稳。配合《模块7》的自我调节工具，会让这段路好走很多。

参考来源

- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*（含疗程评估与随访建议）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Anxiety Disorders*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- 广泛性焦虑量表 GAD-7：Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. *A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7.* Arch Intern Med. 2006;166(10):1092-1097.（仅作筛查/随访，不能单独确诊）
- 《中国焦虑障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。
- Barlow DH 等关于焦虑障碍治疗阶段与复发预防的临床文献。

模块 7

自我调节与日常康复实操

1. 急性焦虑与惊恐发作应急方法

> **先摆正位置：本页的自我调节是辅助，不能替代正规治疗。** 它是在你已经被医生确诊、或症状与既往一致时，用来帮你"度过这一次"的工具，不是用来硬扛危险、逃避就医的理由。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行确诊。

一、惊恐发作是什么

【临床共识】惊恐发作是一阵**突然袭来的强烈恐惧或不适感**，在数分钟内达到顶峰，常伴随着"我要死了/我要失控了"的濒死感。常见身体感受包括：

- 心跳剧烈、心慌、胸闷、胸口发紧
- 气短、窒息感、觉得吸不上气
- 手抖、出汗、发冷或潮热
- 头晕、脚软、不真实感（像在梦里）
- 恶心、肠胃翻腾
- 最核心的体验：**"我是不是心脏病要发了/我是不是要疯了"**

典型时间曲线：【临床共识】惊恐发作通常在**数分钟内达到高峰**，然后在**约10–30分钟内逐渐自行消退**——它不会一直无限升级，也很少在一次发作里持续几小时。记住这条曲线本身，就能帮你少被"它会不会永远这样下去"吓到。

二、最重要的一条安全红线（请先读这段）

> ⚠️ **第一次出现剧烈胸痛/胸闷/心悸/晕厥/呼吸困难，先排查心脏！**

【临床共识】惊恐发作的濒死感通常**不直接致命**，它只是身体警报系统的误响。**但是**：

- 如果你是**第一次**出现剧烈胸痛、胸闷、心悸、晕厥、呼吸困难；
- 尤其疼痛放射到左臂/下颌/后背、出冷汗、伴既往心脏病史、高血压、糖尿病、吸烟等危险因素；

请不要用本页的技巧硬扛，请立即去急诊或拨打 120，先排查心脏等器质性问题。

原因很简单：**惊恐发作的感受和心脏病发作在主观上非常像**，普通人无法可靠区分。宁可虚惊一场跑一趟急诊，也不要把真正的心脏问题当成"又是惊恐"扛过去。

【临床共识】只有在你**已经被医生明确诊断为惊恐障碍/焦虑障碍**，并且这次发作的表现和你既往的惊恐"长得一样"时，才可以安心地按下面的步骤应对。如果这次有什么"不一样"，请优先就医。

三、分步操作卡：发作时怎么做

操作卡 A：4-7-8 呼吸法

它的原理是：把呼气拉长，激活副交感神经，让过度加速的身体慢下来。

步骤：
1. 用鼻子**吸气，默数4秒**；
2. **屏住呼吸，默数7秒**；
3. 用嘴**缓慢呼气，默数8秒**（像轻轻吹一支蜡烛）；
4. 重复 3–4 个循环。

变体与注意事项：
- 【个人体验】如果觉得"屏息7秒"太难受，可以改成 **4-4-6**，或者干脆**慢吸慢呼、把呼气拉长到比吸气长**——重点是呼气更长，不必硬凑数字。
- **哮喘、严重肺病、孕妇、或觉得憋气不适者**：不要硬做屏息，改成平常的**慢呼吸**（吸气4秒、呼气6秒）即可。
- 如果做呼吸反而让你更紧张"我是不是又做错了"，那就别纠结技巧，直接做下面的接地技术。

操作卡 B：5-4-3-2-1 接地技术

它的原理是：把你从"灾难化的脑内恐惧"拉回到"此刻的真实感官"，打断恐惧的恶性循环。

依次说出/在心里数出：
- **5** 个你能**看到**的东西（比如：杯子、窗户、椅子、鞋子、海报）；
- **4** 个你能**触摸到**的东西（比如：椅子的质感、衣服的布料、脚下的地面、手里的手机）；
- **3** 个你能**听到**的声音（比如：空调声、远处车声、自己的呼吸）；
- **2** 个你能**闻到**的气味（比如：空气、茶香、清洁剂味——闻不到也没关系，跳过）；
- **1** 个你能**尝到**的味道（比如：嘴里的味道、喝一口水）。

【个人体验】做接地时，不必"做得完美"。哪怕你数到一半又开始想"我要死了"，没关系，从头再数一遍就好——这个"再拉回来"的动作本身就是在练习。

关于"纸袋呼吸"——不建议你自行使用

【争议观点】网上流传"对着纸袋呼吸能治惊恐"（原理是重复吸入二氧化碳，缓解过度换气）。**本资料库不推荐你自行用纸袋**：
- 普通人无法可靠判断自己是不是真的过度换气；
- 若真的存在心肺问题，闷纸袋可能加重缺氧；
- 现代指南更推荐上面的**慢呼吸 + 接地**，同样有效且更安全。

四、惊恐发作自我应对流程（可打印）

把下面这张流程图式清单存在手机里，发作时照着走：

```
□ 1. 停下手头正在做的事（开车请先安全靠边停车）
□ 2. 找地方坐下/靠着，别站着硬撑，防摔倒
```

☐ 3. 在手机上设一个 10 分钟倒计时——告诉自己"它会在这个时间内退下去"

☐ 4. 做接地技术（5-4-3-2-1），把注意力拉回当下

☐ 5. 做慢呼吸（4-7-8 或慢吸慢呼，呼气拉长）

☐ 6. 对自己说几句话（见下方"自我对话"）

☐ 7. 等倒计时走完；如果没退，继续重复 4–6

☐ 8. 发作过去后，坐下/躺下休息一会儿，不要立刻逼自己回到高强度任务

发作时的自我对话（挑一句适合你的）

- "这是一次惊恐发作，它会过去的，通常几十分钟内就会退。"
- "这种感觉很吓人，但它现在不致命。"（前提：你已被确诊、且这次和既往一致）
- "我不需要立刻解决它，我只需要陪着它等它过去。"
- "我现在要做的，就是呼吸和接地，别的都先放下。"

五、发作后：怎么记录，方便复诊

发作过去后，趁记忆新鲜花 1 分钟记一笔，复诊时给医生看，非常有价值：

记录项	内容
日期/时间	例：10/19 晚 9:30
当时在哪、在做什么	例：在地铁上、刚开完会
发作前发生了什么（诱因）	例：没睡好、喝了两杯咖啡、和家人吵了两句
主要症状	例：心慌、窒息感、手抖、濒死感
持续了多久	例：约15分钟开始退
我用了什么办法、有没有用	例：做了接地+慢呼吸，有用
这次和以前比，一样/不一样	例：和以前差不多

【个人体验】坚持记几周后你常常会自己发现规律："原来我只要睡够、少喝咖啡，发作就少很多。"这就是自我管理的开始。

六、如果发作时你身边有亲友：他们该怎么做

如果你正在被照顾，或你是那个陪着发作的人，请把下面转给亲友：

- **保持冷静、陪伴在旁**：你镇定的样子，本身就是在告诉患者"这里是安全的"。
- **不要说**："你别想太多""你就是太紧张了""至于吗"——这些话会让患者觉得被评判、更孤单。
- **可以说**："我陪着你。""这是惊恐发作，它会过去的。""我们一起慢慢呼吸。"
- **帮他坐下、递水、按上面的流程陪他做接地和呼吸。**
- **如果出现第一次剧烈胸痛/放射痛/冷汗/晕厥/呼吸困难，或患者描述"这次完全不一样"，立即拨打120**——不要因为"他以前发作过"就想当然。
- 发作后让他休息，不要立刻追问"你到底在怕什么"。

七、什么时候不能只靠这一页

【临床共识】出现以下情况，不要硬扛，请就医/急诊：

- 第一次出现、或这次症状"和以前不一样"（尤其胸痛放射、冷汗、晕厥）；
- 发作越来越频繁、越来越重，按这一页也压不住；
- 伴随强烈的自伤、轻生念头；
- 你已经因为害怕发作而不敢出门、不敢坐地铁/开车——这往往提示需要更系统的治疗（药物 + CBT/暴露），而不是只练呼吸。

> **最后提醒**：本页的技巧是"急救包"，不是"治疗"。真正让发作越来越少的，是规范的一线治疗（药物 ± CBT）加上《模块7》其他页的长期日常管理。把这页存好，但别让它变成你不去就医的理由。

参考来源

- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Panic Disorder / Anxiety Disorders*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- 惊恐发作与心脏症状鉴别：参考急诊医学关于胸痛鉴别及 DSM-5 惊恐障碍诊断标准（APA, DSM-5）。
- 4-7-8 呼吸法：源自 Andrew Weil 博士的呼吸法科普（*Breathing: The Master Key to Self-Healing*）；**注意：其对焦虑的直接高质量临床证据有限，主要作为辅助放松技巧引用。**
- 5-4-3-2-1 接地技术：源于辩证行为治疗（DBT）/ 创伤知情护理中的 grounding 技术，用于情绪安抚。
- 《中国焦虑障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。

2. 长期日常管理

> **先摆正位置：自我调节是辅助，不能替代正规治疗。** 本页讲的是在药物/心理治疗之上，帮你把复发风险降下来、把日子过稳的"生活基本功"。它不是靠意志力自愈，而是给正规治疗搭脚手架。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、睡眠：焦虑最好的盟友和敌人

焦虑和睡眠常常互为因果：睡不好→第二天更敏感→更焦虑→更睡不着。

睡眠卫生清单：

- **固定起床时间**：比"几点睡"更重要。每天同一时间起来，哪怕前一晚没睡好。
- **早上接触自然光**：起床后拉开窗帘、出门走走，帮生物钟校准。
- **睡前1小时减速**：放下手机、调暗灯光，做一点放松的事。
- **床只用来睡觉**：不要在床上工作、刷手机、翻来覆去地焦虑，让大脑把"床=睡觉"重新连起来。
- **睡不着别硬逼自己**：越努力想睡越清醒。躺约20分钟还睡不着，就起来做点安静的事，有困意再回床。
- **慎用酒精助眠**：酒精让人昏沉，但会破坏后半夜睡眠、加重焦虑反跳。

【个人体验】很多康复者发现，把"起床时间固定"这一件小事做到，整个人的节律和情绪就慢慢稳了。

二、有氧运动：被低估的"天然抗焦虑药"

【研究结论】规律的**有氧运动**（快走、慢跑、骑车、游泳等）对轻中度焦虑有明确的辅助改善作用，长期坚持还能降低复发风险。它通过调节神经递质、降低基础警觉水平、改善睡眠来起效。

怎么开始（循证又安全）：

- **频率强度**：循序渐进地，目标是每周累计约150分钟中等强度有氧（微微出汗、能说话但不能唱歌的程度），分多次完成即可；
- **从极小目标开始**：比如"今天出门走10分钟"，而不是一上来定"每天跑5公里"；
- **不要搞"运动打卡羞耻"**：今天没做到不是失败，明天继续；
- **哪怕出门站一站也算数**：动力最低的时候，"穿上鞋下楼"这一个动作就值得肯定；
- 有心脏问题、关节问题或正在服药者，开始新运动计划前先问医生。

三、咖啡因、尼古丁、酒精：三个容易被忽略的"焦虑放大器"

物质	为什么影响焦虑	建议
咖啡因（咖啡、浓茶、能量饮料、可乐）	它的半衰期约3–5小时，下午一杯可能影响晚上睡眠；它会直接刺激交感神经，放大心慌、手抖这些"焦虑的躯体信号"	【临床共识】焦虑者建议**显著减少**咖啡因，尤其下午以后；敏感者可改低因或无因。不用追求"完全戒断"，但要留意它和你发作的关系

物质	为什么影响焦虑	建议
尼古丁（吸烟/电子烟）	短暂放松后会反跳性升高警觉，且干扰睡眠	戒烟对焦虑和整体健康都是净收益；戒烟过程中的情绪波动可请医生帮助
酒精	**"假放松"**：酒精短期让人昏沉放松，但会破坏睡眠、停药/醒后焦虑反跳更重，还会与苯二氮䓬类等药物叠加抑制中枢	不应用酒精抗焦虑；服药期间尤其避免

【个人体验】很多人惊恐发作前其实喝了不少咖啡或熬了夜，只是没把这两件事联系起来。记几周日记后，这个规律会自己浮出来。

四、饮食与血糖

- **规律进餐**：焦虑常让人饥一顿饱一顿，低血糖本身就会引起心慌、手抖，和焦虑的躯体感觉几乎一样。
- **稳住血糖**：少用高糖饮料、精制零食让血糖大起大落，对情绪稳定有帮助。
- **不过度迷信保健品**：没有单一食物或保健品能治疗焦虑，补剂不能替代药物与治疗。

五、压力减负：把"警报源"一个个拆掉

焦虑的人常常不是"事太多"，而是"每件事都被当成天大的事"。方法：

- **任务拆解**：把一个大任务切到"小到不可能失败"。不要想"做完整个项目"，只想"打开文档写第一句"。
- **学会说不**：焦虑者常因怕冲突而过度承诺，结果把自己压垮。温和而清楚地拒绝，是在保护治疗。
- **信息节食**：睡前少刷手机新闻、少反复看让你焦虑的信息；固定时间处理消息，而不是全天候被它追着跑。
- **设边界**：区分"我能控制的"和"我控制不了的"，把精力只投向前者。

六、"担忧时间"（Worry Time）：一个被验证的小技术

这是 CBT 里专门对付广泛性焦虑"整天胡思乱想"的技术：

操作步骤：
1. 每天**固定一个时段**（比如傍晚 5:00–5:15），作为专属的"担忧时间"；
2. 在一天其他时间里，一旦发现自己开始担忧，就**对自己说"先记下来，留到担忧时间再想"**；
3. 到了担忧时间，拿出来**认真地、有期限地**想这些事：这件事我能做什么？不能做的部分怎么办？
4. 时间一到就停，转入下一件事。

【个人体验】它的妙处在于：你不是"不许担心"（那只会更担心），而是给担心**划定一个笼子**。练几周后，你会发现一天中"自动翻来覆去想同一件事"的时间明显变少了。

七、症状日记：让焦虑变得可观察、可管理

每天花2分钟记一笔：

日期	焦虑强度(0–10)	发生了什么	身体感觉	咖啡因/睡眠情况	我做了什么应对	今天一件小事
例：10/19	6	下班路上心慌	胸口发紧、手抖	昨晚睡5h，下午一杯咖啡	走慢一点、深呼吸	便利店的热饮很好喝

坚持几周，你会看出自己的"发作规律"和"有效应对"。

八、一周日常管理打卡表

把它打印或复制到备忘录，每天打勾即可——**做到大部分就算赢，不要完美主义。**

每日事项	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
固定时间起床							
按医嘱服药（不漏服）							
出门活动/运动≥10分钟							
咖啡因≤1杯/下午不喝							
睡前1小时放下手机							
一次担忧时间/放松练习							
记一笔症状日记							
联系一个人（最低剂量社交）							

> **再强调一次**：这些是帮你康复的"脚手架"，不能替代药物和心理治疗。如果你按这页做了很久仍持续下滑、惊恐越来越频繁，请回到医生和治疗师那里，而不是独自硬扛。

参考来源

- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 有氧运动对焦虑的疗效：相关系统综述与 Meta 分析（如 *Exercise in the treatment of clinical anxiety in general practice – a systematic review and meta-analysis*, BMC 2018, PMC6048763）. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6048763/
- 咖啡因与焦虑：参考临床精神药理学关于咖啡因对焦虑/惊恐影响的综述。
- "担忧时间"（Worry Time）：CBT 治疗广泛性焦虑的标准技术，见 Borkovec 等 GAD 认知行为治疗文献。
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Anxiety Disorders*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- 《中国焦虑障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。

3. 思维调整练习

> **先摆正位置：这些是 CBT 的自助工具，辅助正规治疗，不能替代。** 它们帮你识别和松动那些把小事放大成灾难的思维习惯；但如果你现在症状很重、被念头卷得无法工作生活，请在治疗师带领下做，不要独自硬扛。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行确诊。

一、焦虑的脑子长什么样

【临床共识】焦虑障碍患者的大脑，像一个过于敏感的烟雾报警器——没着火也狂响。它有一套固定的"思维偏差"，识别它们是第一步。

二、常见认知偏差（配焦虑患者的真实例句）

认知偏差	是什么	焦虑患者的例句
灾难化	把小小的不适直接想到最坏结局	"我心跳快了一下——我是不是要猝死了。"
高估概率	把"有可能"当成"几乎一定会"	"明天要开会发言——我肯定会出大丑。"（其实概率很低）
低估自己应对	事情真发生时，觉得自己一定扛不住	"万一我在地铁上惊恐发作，我就完了、没人能救我。"
非黑即白	要么完美要么完蛋，没有中间	"我今天状态不好，说明这个治疗全失败了。"
"应该"句式	用一堆"我应该/我必须"逼自己	"我应该完全不焦虑才对。""别人都不怕，就我怕，我真没用。"
情绪化推理	把"我感觉"当成"事实"	"我感觉要出事，那就一定要出事。"
反复求确认	总想找人保证"没事"，但保证完很快又慌	反复查症状、反复问家人"我心脏到底有没有事"

【个人体验】你不需要一次全认出它们。先挑一个你最常犯的（很多人是"灾难化"），盯它一周。

三、思维记录表（核心工具）

这是 CBT 最经典的自助练习。**它不是让你"往好处想"，而是让你像科学家一样，给那个自动想法找证据。**

空白模板（可复制到备忘录）

栏目	填什么
① 情境	发生了什么？在哪？和谁？
② 自动想法	脑子里瞬间冒出来的那句念头是什么？
③ 情绪强度(0–100)	当时焦虑/恐惧有几分？

栏目	填什么
④ 支持这个想法的证据	有什么事实真的支持它?
⑤ 反对这个想法的证据	有什么事实不支持它?
⑥ 替代想法	更平衡、更符合证据的说法是什么?
⑦ 重新评分	现在焦虑还剩几分(0–100)?

一个填好的示例

栏目	内容
① 情境	下午开会前，我突然心跳快、胸口发紧。
② 自动想法	"我马上要在会上惊恐发作、当众晕倒，出大丑。"
③ 情绪强度	90
④ 支持证据	我确实心跳快、胸口紧；以前有过惊恐。
⑤ 反对证据	我被医生诊断过惊恐障碍，这种发作几十分钟会退；上次同样的感觉我并没有真的晕倒；我可以先出去喝口水、做慢呼吸；同事也有过紧张不适，没人觉得天塌了。
⑥ 替代想法	"这是惊恐的躯体信号，不是心脏病。它会过去，我可以坐下、慢呼吸、必要时出去一下，不需要立刻在所有人面前出丑。"
⑦ 重新评分	40

【个人体验】你会发现：做完这张表，情绪往往不是降到0，而是从90降到40——这就够了。**目标不是消灭焦虑，而是把它从"被淹没"降到"能应对"。**

四、苏格拉底式提问清单

当一个灾难化念头冒出来，像个律师一样问自己这几句：

1. **支持这个想法的证据是什么？反对的证据是什么？**
2. **这件事真正发生的概率有多大？**（不是"有没有可能"，是"百分之几"）
3. **就算它真的发生了，我具体能怎么办？**我以前有没有熬过类似的事？
4. **如果我的朋友遇到这件事、这么想，我会怎么劝他？**
5. **我是在"知道事实"，还是在"感觉要出事"？感觉不等于事实。**
6. **我现在最糟会怎样？最好会怎样？最可能发生的又是哪个？**

五、去灾难化练习：三个版本

针对一个你最担心的场景，把下面三栏都写出来：

版本	内容（示例：怕在地铁上惊恐发作）
最坏会怎样	我可能心慌、难受、想下车。但既往经验是它几十分钟会退，我不会真的死掉。
最好会怎样	可能根本不发作，或者只是轻微紧张，坐几站就到了。
最可能发生的	我可能会有点紧张，做几次慢呼吸，到了就好了——这是最现实的。
如果最坏真发生，我能怎么办	下车、找座位坐下、做接地和慢呼吸、必要时联系家人；我以前做到过。

【临床共识】这个练习的关键是最后一行——**它把"我无法应对"的信念，替换成"我有具体的应对步骤"**，这正是焦虑最怕的事。

六、使用提醒

- **不必追求"完全不焦虑"**：目标是把焦虑调回到可应对的程度，不是变成一个没情绪的人。
- **重度时需要治疗师带**：如果念头强烈到你根本没法坐下来填表、或已经影响到进食睡眠，请回到医生/治疗师那里。
- **它是练出来的**：前几次填表会很别扭、很慢，这很正常。就像健身，练多了大脑会自动开始这么干。

> **再强调一次**：这些工具是 CBT 的自助版本，是正规治疗的辅助，不能替代药物和专业心理治疗。配合《模块7》的暴露练习和放松练习一起用，效果更好。

参考来源

- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- CBT 认知重构与思维记录表：见 Greenberger D, Padesky CA. *Mind Over Mood*（CBT 自助经典）。
- 苏格拉底式提问与去灾难化：见 Beck JS. *Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond*。
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Anxiety Disorders*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- 《中国焦虑障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。
- 认知行为治疗对广泛性焦虑的疗效：相关随机对照试验与 Meta 分析。

4. 渐进式暴露练习

> **先摆正位置：自我调节是辅助，不能替代正规治疗。** 暴露是治疗焦虑最有力、也最需要方法的技术之一。本页教你原理和基础阶梯，但**严重者、场所恐惧、PTSD 共病者，必须在治疗师指导下进行，不要自行硬扛**。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行确诊。

一、为什么"越回避越怕"

【临床共识】焦虑是被**回避**维持住的。原理有两个：

- **恐惧消退需要新学习**：只有当你安全地、反复地待在恐惧情境里、且什么坏事都没发生，大脑才会重新学到"这个情境其实是安全的"；
- **习惯化**：在一次暴露中，焦虑会先升后降——只要你不逃，它通常会在数十分钟内自然回落。

你每逃避一次，大脑就"确认"了一次"刚才那个场景是危险的、幸亏我逃了"，于是下次更怕。**暴露，就是反过来给大脑一个新经验。**

二、暴露的三种类型

类型	是什么	主要针对
实景暴露（现场面对）	真的走进那个让你怕的场景	特定恐怖症、社交焦虑、场所恐惧
想象暴露	在安全环境里，用想象反复面对恐惧画面	难以实景化的恐惧、创伤相关
内感受暴露	主动诱发那种你害怕的**身体感觉**（如原地转几圈让头晕、快跑来让心跳加速），发现它其实安全	**惊恐障碍**——你怕的不是场景，是"心慌、头晕、窒息感"本身

【个人体验】内感受暴露对惊恐患者特别关键：你怕的其实不是地铁，而是"地铁上如果心慌怎么办"。主动在安全环境里把心跳弄快、然后发现"我能承受"，惊恐就慢慢失去威力。

三、怎么建你的恐惧阶梯

核心工具：SUDS（主观痛苦度 0–100）——0 是完全平静，100 是你能想象的最痛苦。

建阶梯的步骤：

1. 先写下你最害怕的那个终极场景（SUDS≈90–100）；
2. 从容易到难，列出 8–12 个中间步骤；
3. **从 SUDS 约 30–40 分的步骤开始**——不要一上来就挑战最高层；
4. 在每一级**停留，直到焦虑明显下降（通常降一半左右）再结束这一次**，不要一难受就逃；
5. 同一级重复练到它不再让你太怕（比如 SUDS 降到30以下），再往上爬一级。

四、三个示例阶梯

示例 A：社交焦虑（怕当众发言）

级别	任务	预估 SUDS
1	在熟人小组里说一句"我觉得……"	30
2	在3个人面前讲1分钟昨天做的事	45
3	在5–6人面前做1分钟自我介绍	60
4	在会议上发言2分钟	75
5	在十几人会议上做5分钟汇报	90

示例 B：幽闭/恐高

级别	任务	预估 SUDS
1	站在关着灯的小房间门口看一眼	30
2	走进小房间待30秒	45
3	在里面待2分钟、门轻轻关上	60
4	坐电梯上2楼（有人陪同）	75
5	独自坐电梯上5楼	90

示例 C：惊恐的内感受暴露

级别	任务（在安全环境、有人知情时做）	预估 SUDS
1	快速呼吸30秒让自己有点喘	30
2	原地转圈10圈让自己头晕	45
3	原地快跑30秒让心跳加速	60
4	屏住呼吸一会儿感受"窒息感"	75
5	在真实地铁上做上述诱发并停留不逃	90

五、暴露中最常见的错误

错误	后果	正确做法
逐级跳级（从第1级直接跳到第5级）	焦虑爆表、被吓退，更坚信"果然可怕"	一级一级爬，宁可慢
带着"安全行为"（必须有人陪、必须攥着药、必须随时能逃）	大脑学不到"不做这些也安全"	逐步减少安全行为，或在治疗师指导下安排

错误	后果	正确做法
半途而废（刚难受就逃）	等于又一次"强化"了恐惧	停留到焦虑明显下降再结束
练一次就期待根治	失望、放弃	暴露需要重复多次，是"练肌肉"不是"吃退烧药"

六、暴露练习记录表

日期	暴露任务（第几级）	开始SUDS	结束SUDS	我有没有逃/用安全行为	事后总结（我学到了什么）
例：10/19	社交第3级：5人前自我介绍	70	35	没逃	讲完了，没人笑我，我能行

七、安全红线

【临床共识】以下情况**不要自行暴露**，请找治疗师：
- 你有**场所恐惧**（怕出门、怕地铁、怕空旷处）且已经严重影响生活；
- 你有**PTSD/创伤**，暴露可能勾起强烈闪回，需要专业设计和保护；
- 你目前**惊恐非常频繁、情绪极不稳定**；
- 暴露后出现长时间的情绪崩溃、失眠加重、自伤念头。

出现这些，不是"你不够勇敢"，而是这个阶段需要有人带你。

> **再强调一次**：暴露是把双刃剑——用对了是最治本的技术，用错了（跳级、硬扛创伤）会受伤。轻中度、想自己热身的，可以按本页从最低级慢慢来；中重度请一定让治疗师陪你建阶梯。配合《模块7》的思维调整和放松练习，效果更好。

参考来源

- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*（含暴露疗法推荐）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- Barlow DH, Craske MG. *Mastery of Your Anxiety and Panic*（暴露与内感受暴露经典手册）.
- Craske MG, et al. 关于暴露疗法、恐惧消退与习惯化的临床综述。
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Anxiety Disorders*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- 《中国焦虑障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。
- 内感受暴露（Interoceptive Exposure）治疗惊恐障碍：相关随机对照试验文献。

5. 放松练习

> **先摆正位置：自我调节是辅助，不能替代正规治疗。** 放松练习帮你把长期紧绷的身体和神经系统松下来，但它不是"治疗焦虑的药"，也不是"必须做到脑子放空"。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行确诊。

一、先纠正一个最大的误会

【个人体验】很多人一做放松就失败，是因为以为"放松=脑子里什么都不想"。**这根本做不到**——大脑一定会走神。放松练习的真正功夫是：**注意到自己走神了，再轻轻把注意力拉回来**。这个"拉回来"的动作本身，就是在练"不被念头卷走"。所以走神不是失败，是练习的一部分。

二、渐进式肌肉放松（PMR）

是什么：先刻意把某组肌肉绷紧、再松开，通过"先紧后松"让你真切体会放松的感觉。

分步引导词（约10–15分钟，找个安静地方坐下或躺下）：

1. 先做几次深呼吸，让自己安静下来；
2. **双手**：用力握紧拳头5秒……然后松开，感受松弛的感觉停留15–20秒；
3. **手臂/小臂**：绷紧……松开；
4. **肩部**：耸肩靠近耳朵5秒……放下松开；
5. **面部**：皱眉头、咬紧牙5秒……松开；
6. **腹部**：收紧腹部5秒……松开；
7. **双腿**：绷紧大腿、小腿5秒……松开；
8. **双脚**：脚尖下压5秒……松开；
9. 最后静静躺一会儿，体会全身松弛。

- **何时用**：晚上睡前、或长期肌肉紧绷、肩颈酸痛时；
- **每次多久**：10–15分钟；
- **入门资源**：网上有大量中文 PMR 引导音频（"渐进式肌肉放松 引导语"），跟着做即可。

三、腹式呼吸 / 膈肌呼吸

是什么：让呼吸落到腹部，而不是胸口浅快地喘——这是焦虑者最缺的那种"慢而深"的呼吸。

步骤：

1. 一手放胸口、一手放肚子；
2. 用鼻子慢慢吸气，让**肚子鼓起来**（胸口那只手尽量不动）；
3. 缓缓用嘴/鼻呼气，肚子自然回落；
4. 重复几分钟，重点是**呼气比吸气更慢更长。**

- **何时用**：白天紧张时、惊恐前兆时（配合《模块7》应急方法）；
- **每次多久**：3–5分钟即可，不用太久；

- **注意**：哮喘、严重肺病、孕妇不适者，按自己舒服的节奏来，不必硬凑数字。

四、引导式想象

是什么：在脑中想象一个让你安全、平静的地方（海边、草地、小时候的房间……），调动感官细节把自己"放"进去。

怎么做：闭上眼，想象那个地方，不只看画面，还去感受——阳光的温度、微风的触感、海浪的声音、空气的味道。
- **何时用**：睡前、或情绪需要快速"换个频道"时；
- **每次多久**：5–10分钟；
- **入门资源**：大量"引导式想象 放松音频"可跟随。

五、正念身体扫描

是什么：把注意力从脚到头，一寸一寸地移过身体，不评价、只观察——哪里紧、哪里麻、哪里没感觉，都只是"看见"。

怎么做：躺下，从脚趾开始，把觉察带到那里；停留几秒，再移到脚掌、小腿、膝盖……一直到头顶。哪里不舒服也不用去"改"它，只是觉察。
- **何时用**：睡前助眠、或身体长期紧绷时；
- **每次多久**：10–20分钟（是 MBSR/MBCT 的核心练习）；
- **入门资源**：搜"身体扫描 正念 引导音频"，跟练即可。

六、正念行走 / 正念日常活动

是什么：不一定非要闭眼静坐。正念也可以是**走路时**只感受脚底和地面的接触、手臂的摆动；**吃饭时**只感受食物的味道、咀嚼；**洗碗时**只感受水的温度、碗的触感。

- **何时用**：把日常小事变成微型练习，通勤、吃饭、走路都能做；
- **每次多久**：随时随地，几分钟即可；
- **好处**：让你从"脑子里反刍担忧"回到"此刻的真实生活"。

七、一张表帮你选

练习	最适合的场景	每次多久	入门方式
渐进式肌肉放松 PMR	睡前、肌肉紧绷	10–15分钟	跟中文引导音频
腹式呼吸	白天紧张、惊恐前兆	3–5分钟	自练，手放肚子找感觉
引导式想象	睡前、情绪需换频道	5–10分钟	跟引导音频
正念身体扫描	助眠、长期紧绷	10–20分钟	MBSR/MBCT 音频
正念行走/日常正念	通勤、吃饭、随时	几分钟	把注意力拉回感官即可

【临床共识】规律的正念/放松练习对焦虑有辅助改善作用，但它的效果来自**长期、重复**，而不是"练一次就好"。把它像刷牙一样变成日常，比"等崩溃了才抱佛脚"有用得多。

八、什么时候放松练习帮不上忙

如果你发现：
- 越放松越紧张、一做练习就被念头淹没；
- 放松后反而勾起强烈的悲伤、恐惧或闪回；
- 你已经靠放松撑了很久，却越来越严重——

这说明你需要的不只是自我放松，请回到医生和治疗师那里。

> **再强调一次**：放松练习是康复的"日常保养"，不能替代药物和心理治疗。把它和《模块7》的长期管理、思维调整、暴露练习搭配起来，才是完整的自我调节体系。

参考来源

- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 正念对焦虑的辅助疗效：接受与正念干预（ACT/MBCT/MBSR）治疗 DSM-5 焦虑障碍的系统综述与 Meta 分析（PubMed 34650179）. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34650179/
- 渐进式肌肉放松（PMR）与呼吸训练对焦虑的疗效：相关临床综述。
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Anxiety Disorders*；及 NIMH 关于正念与放松的科普. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- 《中国焦虑障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。
- Kabat-Zinn J. *Full Catastrophe Living*（MBSR 正念减压经典著作）。

模块 8

危机识别与求助资源

1. 需要紧急就医的危险信号

> **如果你此刻正被强烈的痛苦抓住，或身体出现了从未有过的剧烈不适，请先看这一页最上面的求助方式——不必读完再行动。**
>
> 在中国大陆：**全国统一心理援助热线 12356**（24小时、免费）；医疗急救 **120**；报警 **110**。
> 本页只讲如何识别危险信号、如何求助、如何让自己安全。**它不描述任何伤害自己的方法**——这一页唯一的目的，是帮你或你身边的人被接住。
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

〇、先记住最重要的两句话

1. **心慌、胸闷、喘不上气，不要一律当成"焦虑发作"硬扛。** 焦虑确实会带来这些躯体感受，但首次出现、程度远超以往、或伴随放射痛/冷汗时，必须先排除心脏等躯体急症——这不是胆小，是对自己负责。
2. **求助不是给人添麻烦，是这个世界上最值得做的事。** 哪怕你觉得"我不值得被救"，这个念头本身就是疾病在说话，不要相信它。

一、躯体急症红旗：先别归给焦虑

【临床共识】焦虑障碍患者常出现心慌、胸闷、气短、手抖、出汗，这些大多在惊恐发作中反复出现、彼此熟悉。但**以下情况属于"红旗症状"**，不能一律按焦虑处理，应立即急诊或拨打 120：

红旗信号	为什么不能硬扛	该怎么做
首次出现的剧烈胸痛、胸闷、压迫感，尤其向左肩、左臂、下颌、背部放射	需排除急性冠脉综合征、主动脉夹层等	立即拨 120，静坐/半卧位等待，不要自行开车
胸痛/胸闷伴**冷汗、面色苍白、濒死感、恶心**	典型心肌缺血表现之一	同上，拨 120，告知调度员症状
突然晕厥、意识丧失，哪怕只几秒就醒	需排除心律失常、脑供血问题	立即拨 120，不要认为"醒了就没事"
突发严重呼吸困难、嘴唇发紫、无法平卧	需排除心肺急症	立即拨 120
既往有**心脏病、高血压、糖尿病、血栓**史，出现上述任一症状	风险更高	立即拨 120，并告知既往病史
服药后出现高热（≥38.5℃）+ 意识混乱 + 肌肉僵硬 + 大汗 + 心跳很快	警惕**5-羟色胺综合征**（药物严重不良反应），可能危及生命	立即停药并拨 120/急诊，带上正在吃的所有药盒
连续多日完全无法入睡、无法进食饮水、身体明显衰竭	脱水、电解质紊乱、免疫力崩溃	24 小时内就医，必要时急诊

【个人体验】很多惊恐发作的人都有过这种纠结："到底是我心脏病犯了，又是焦虑？"一个简单的原则是——**如果你以前从没有过这种感觉，或者这次明显比以往重，就当它是身体问题去急诊排查一次。** 排查完

没事，你以后对惊恐发作的信心反而更足；真有事，抢的就是时间。

> **特别提醒**：焦虑障碍患者首次出现惊恐发作时，很多人是在急诊心内科被"排查一圈没事"后才转诊到精神科的。这是正常路径，不是"白跑"。

二、心理危机红旗：焦虑加重到失控

【临床共识】焦虑本身是一种疾病，但当它出现以下"失控信号"时，已经超出了自我调节和普通复诊能处理的范围，需要紧急或尽快求助：

- **出现自伤/自杀的念头**：哪怕只是一闪而过，尤其是"活着没意思""不想撑了"反复出现，或开始想"怎么结束"。
- **惊恐发作时间远超平时**：典型惊恐发作一般数分钟到十几分钟自行缓解。若一次发作**持续数十分钟以上不缓解**，或**一天内反复发作数次、连发无法脱身。**
- **与现实脱离感失控**：强烈的人格解体/现实解体（觉得自己不真实、像在看电影、周围像布景），伴无法消退的濒死恐惧。
- **酒精或药物使用失控**：靠喝酒、安眠药、自行加药才能入睡/出门，且剂量越来越大——这本身已经是危机信号。
- **急性恐惧导致完全无法动弹、无法出门、无法上班/上学**，持续数日。
- **出现完全不合常理的坚信**（如坚信有人害自己、坚信身体已经"坏了"查不出来）——需排除伴发的精神病性症状或双相等其他问题。

> 【临床共识】焦虑障碍本身**不会"变成"精神分裂症**，但如果出现了上述现实检验丧失的表现，仍需尽快让医生评估，不要自己对着症状对号入座吓自己。

三、风险分级与对应行动

级别	典型表现	立刻要做的事
🔴 **一级：即刻危险**	已经/正在发生自伤行为；胸痛晕厥等躯体急症；有具体自伤计划且可能立刻执行	**立即拨打 120 / 110**；让身边人 24 小时不离；不要独处
🟠 **二级：24 小时内就医**	出现主动自伤念头但暂无计划；惊恐持续数十分钟不缓解连发数日；完全无法进食饮水；药物严重不良反应怀疑	**24 小时内**到精神科/心理科急诊或门诊；联系主治医生；告诉一位信任的人不要让自己独处
🟡 **三级：尽快预约门诊**	症状较前明显加重、睡眠恶化、副作用明显、出现被动的"活着没意思"想法	**本周内**预约门诊复诊；拨打 12356 先聊一聊；不要自行调药

> **任何一级，只要你心里没底，都可以直接往上一级行动。** 宁可反应过度，不要追悔莫及。

四、可以直接照抄的求助话术

很多人卡在"不知道怎么开口"。下面是现成的话，直接发出去/说出来就行。

发给家人 / 伴侣

> "我现在状态很差，身体/心里很难受，我不想一个人扛了。能不能今天陪我去一趟急诊/医院？具体情况路上我跟你说。"

发给朋友（不需要对方懂医学）

> "有件事我认真地跟你说：我这几天很难受，一个人有点撑不住。你不用会劝我，能不能现在过来陪我一会儿，或者陪我打个电话？"

打 120 / 110 时（调度员需要信息，照实说）

> "我（或我身边的人）现在 [剧烈胸痛/意识不清/出现了伤害自己的念头]，地址是 ____，请问我现在该怎么办？"
>
> 不要因为"不确定是不是小题大做"而犹豫——调度员每天处理大量电话，他们会判断。

打 12356 时

> "我现在焦虑发作很重，（出现了不想活的念头/身体很不舒服但查过没大问题），我想求助，请问我现在该怎么办？"

告诉同事（如需紧急请假）

> "我突然身体很不舒服，需要马上去一趟医院，手上的事我稍后交接，谢谢理解。"（不必把隐私全摊开）

五、急性情况下的行动清单

身体突发剧烈不适（胸痛、晕厥、呼吸困难）：
1. 立刻停下手里的事，坐下或半躺，不要硬撑、不要自己开车。
2. 拨 120，说清地址、症状、既往病史。
3. 解开领口、保持空气流通；如有医生事先开过的急救药，按既往医嘱使用，**不要临时吞别人的药。**
4. 通知一位家人/朋友尽快到你身边。

心理上撑不住了：
1. 不要独处——立刻给一位信任的人发消息/打电话。
2. 拨 **12356**（24 小时免费）先聊；如果念头已经很具体，直接拨 120 或去最近的精神卫生中心急诊。
3. 不要饮酒、不要自行加药/停药。
4. 在专业人员或信任的人协助下，**移除或远离眼前可能造成危险的物品**（具体怎么整理听专业人员的，不必自己研究方法）。

六、身边的人：该做与不该做

如果你是陪着当事人的人，下面这张表帮你稳住：

✅ 该做	❌ 不该做
平静、直接地问："你是不是有过不想活的念头？有没有计划？"	回避不谈、假装没事
胸痛晕厥时立刻帮他拨 120，而不是"先喝口水缓缓"	说"你就是焦虑，别吓唬人"
陪着他，不离开他独自待着	让他一个人"静静"
帮他联系医生、急诊、120/110/12356	承诺"我替你保密"（安全比保密重要）
认真倾听，不评判、不说教	指责："你怎么这么想不开""太自私了"
在专业人员指导下整理环境	和他争辩、强行控制、围观刺激

> 你不需要"会心理辅导"。**在场、稳定、不评判、帮他联系人、该叫救护车时立刻叫**——就已经是极大的帮助。

七、关于急诊和住院：它是保护，不是惩罚

【临床共识】在以下情况，医生可能会建议**急诊留观或住院**：

- 存在即刻的、明显的自伤/自杀危险；
- 拒食、拒饮，基本生活无法维持；
- 伴有现实检验丧失、严重迟滞、药物严重不良反应；
- 在家无法保证安全、缺乏可靠照护。
- **住院不是被关起来受惩罚**，而是在你最无力的时候，给你一个 24 小时有人看护、能稳定用药和观察的安全环境。
- **非自愿就医**：当一个人有即刻危险、又无法/拒绝自行就医时，家属和专业人员会按照当地法律程序送医——这是为了救命，不是侵犯。具体流程以当地精神卫生法规为准。

八、危机过后怎么办

- **不评判**：无论是当事人还是陪伴者，事后都不要自责"当初要是……"。
- **尽快复诊**：让医生知道这次发生了什么，评估是否需要调整治疗。
- **更新紧急联系信息**：把这次的新信号、新联系人补进手机备忘录。
- **陪伴者也需要喘息**：照顾一个正在危机中的人压力很大，记得你自己也要找支持。

> **最后，请记住：** 焦虑和抑郁会骗你，说"没有希望了""走投无路了""你和别人都是负担"。这些都是病的声音，不是事实。真正的事实是——**这种病是可以治的，此刻的痛苦不会永远持续，只要你愿意再坚持一下、打一个电话，就有人来接你。**
>
> 现在，如果你正需要：**12356（24小时）、120、110。**

参考来源

- 世界卫生组织（WHO）：*Suicide fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide
- 世界卫生组织（WHO）：*LIVE LIFE: an implementation guide for suicide prevention*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
- 国家卫生健康委员会：全国统一心理援助热线（12356）相关发布会与通知，国家心理健康和精神卫生防治中心 https://ncmhc.org.cn/
- 北京心理危机研究与干预中心（回龙观医院）：https://www.crisis.org.cn/
- NICE：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 《中国焦虑障碍防治指南》（中华医学会精神医学分会）。

2. 国内心理危机热线与求助渠道

> **不知道打给谁、不知道哪个渠道靠谱，是很多人在最难的时候卡住的原因。这一页把国内能用的求助渠道按"首选—补充—线上—医院"整理好，存进手机备忘录，希望你永远用不上，但一定要有。**
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。
>
> **核实日期：2026-10-19。热线号码可能随时间调整，拨打前以当地官方公布为准。**

一、首选：全国统一心理援助热线 12356

【临床共识】**12356 是目前国内最优先、最该存的心理援助号码。**

项目	内容
号码	**12356**
服务时间	**24 小时**
费用	**免费**（按市话/套餐计费，无额外服务费）
开通时间	**2025 年 5 月 1 日起**全国统一使用
主办	国家卫生健康委员会统一部署，各地精神卫生中心/定点机构承接
能解决什么	情绪困扰倾诉、心理危机干预、就医指导、转介建议

> 号码里没有"4"，寓意"要爱我了"，是国家层面设计的暖心号码。
>
> 【核实依据】2025 年 5 月起，全国原有的各地心理援助热线逐步统一并入 12356；国家卫健委 2025 年多次新闻发布会介绍过该热线运行情况。

什么时候打 12356：

- 你情绪很难受，想找人说说话，又不想惊动身边人；
- 你出现了"活着没意思""不想撑了"之类的念头，想先聊一聊评估风险；
- 你不知道自己的情况该挂什么科、要不要去急诊；
- 你是家属，不知道怎么回应身边人的危机。

> 你不需要"够严重"才配打这个电话。任何让你不安的状态，都值得一个电话。

二、紧急：医疗急救 120、报警 110

渠道	号码	什么时候用
医疗急救	**120**	胸痛、晕厥、呼吸困难、自伤行为发生、药物严重不良反应、意识不清
报警	**110**	现场有现实人身安全威胁、需要警力到场、当事人有伤害他人风险

打 120 时，调度员通常会问：地址、发生了什么、患者现在的状态、年龄性别、既往病史。**照实说就好，不要因为"不确定是不是小题大做"而不打。**

三、对口机构：当地精神卫生中心 / 精神专科医院急诊

心理危机最对口的线下去处，是**当地精神卫生中心（或精神专科医院）的急诊/门诊**，以及开设精神科的三甲综合医院。

怎么找：

1. 打开手机地图（高德/百度/腾讯地图），搜索"**精神卫生中心**""**精神科急诊**""**心理危机干预**"；
2. 看导航里有没有标注"24 小时急诊"；
3. 去之前先打医院公开电话确认急诊是否开放、是否需要预约。

> 【个人体验】很多城市的精神卫生中心同时就是 12356 的本地承接单位，接线员如果判断你需要线下就诊，会直接建议你去对口机构。

四、补充渠道：北京心理危机研究与干预中心热线

作为 12356 之外的补充，北京回龙观医院主办的这条热线已稳定运行二十余年：

项目	号码
手机 / IP / 分机用户拨打	**010-82951332**
固定电话（座机）拨打	**800-810-1117**
服务时间	24 小时，一年 365 天
性质	公益、免费，设在北京回龙观医院

> 这条热线面向全国，外地手机拨打 010-82951332 按长途资费；座机拨 800 开头号码免费。**它不是 12356 的替代品，而是补充**——如果 12356 占线，可以拨这条试试。

五、其他补充渠道（需注意性质）

渠道	说明	注意
希望 24 热线等民间公益热线	由民间心理机构运营，24 小时接听	**民间性质**，接线质量和排班可能变动；拨打前先在官网核实当期号码
各地"市长热线"12345	可咨询本地精神卫生资源、就医政策	非直接危机干预，适合问资源
人社咨询 12333 / 法律援助 12348	涉及病休、复工、劳动权益时咨询	非心理热线

> 【争议观点】网上还能搜到大量"心理疏导""情感挽回"类商业热线/APP。**它们不是危机干预资源**，很多以盈利为目的，甚至可能诱导付费。真遇到危机，优先打上面列的公立/公益号码。

六、线上渠道：去哪里查靠谱信息

- **国家心理健康和精神卫生防治中心**：https://ncmhc.org.cn/ （原国家精神卫生项目办）——发布全国精神卫生政策、科普、本地资源。
- **国家卫生健康委员会官网**：http://www.nhc.gov.cn/ ——查 12356 相关通知、本地精神卫生中心名录。
- **北京市心理援助热线 / 北京心理危机研究与干预中心**：https://www.crisis.org.cn/ ——科普文章质量较高。
- 你所在**省/市卫生健康委官网**、本地三甲医院精神科公众号。

怎么判断一个渠道靠不靠谱：

✅ 优先选	❌ 谨慎/避开
公立医院、政府卫生部门主办	个人自媒体、商业培训机构
有明确主办单位、地址、电话	只留微信号、"加老师咨询"
内容是科普、就医指导	内容是"七天根治焦虑""停药不复发"
不主动诱导你买课/买药	反复劝你买课、买产品、加付费群

七、打热线会发生什么：流程与保密原则

第一次打心理热线的人，常常紧张得不知道说什么。了解一下流程就不慌了：

1. **接通**：接线员自报家门，比如"您好，这里是 12356 心理援助热线"。
2. **倾听与评估**：你说，接线员听；他们会问几个简单问题——你现在在哪里、身边有没有人、有没有伤害自己的计划——用来判断风险。
3. **一起想办法**：根据你的状态，接线员会建议你：先做几次呼吸、联系家人、马上去急诊、或转介到本地精神卫生资源。
4. **结束**：你可以随时挂电话；如果是危机状态，接线员可能会多聊一会儿、确认你安全后再结束。

关于保密：
- 心理热线通常**遵守保密原则**，不会把你的话告诉单位、家人。
- **例外**：当接线员判断你（或身边人）有即刻生命危险时，他们会按规范联系紧急救援——这不是"告密"，是救命。提前知道这一点，到时候不会觉得被背叛。

你可以说什么：
- 不用组织语言，想到哪说到哪；
- 可以哭、可以沉默、可以说"我也不知道怎么说"；
- 不必报真实姓名。

八、紧急情况下的行动清单（可截图保存）

身体突发急症（胸痛/晕厥/呼吸困难）：
1. 停下手里的事，坐下或半躺；
2. 拨 **120**，说清地址和症状；

3. 通知一位家人/朋友尽快到你身边；
4. 不要自行开车、不要临时吞别人的药。

心理危机（撑不住/有自伤念头）：
1. 不要独处——立刻给信任的人发消息；
2. 拨 **12356** 先聊；念头很具体就拨 **120** 或直接去精神卫生中心急诊；
3. 不要饮酒、不要自行加药/停药；
4. 在专业人员指导下，让信任的人帮忙移除眼前危险物品。

九、家属 / 旁观者：该做与不该做

✅ 该做	❌ 不该做
平静、直接地问："你是不是有过不想活的念头？有没有计划？"	回避不谈、假装没事
胸痛晕厥时立刻帮他拨 120	说"你就是焦虑，别吓唬人"
陪着他，不离开他独自待着	让他一个人"静静"
帮他拨 12356 / 联系医生 / 去急诊	承诺"我替你保密"（安全比保密重要）
认真倾听，不评判、不说教	指责、羞辱、比较"别人比你惨"
告诉他"你的安全对我很重要，我们一起找办法"	轻视、说"这点小事至于吗"

> 你不需要"会心理辅导"。**在场、稳定、不评判、帮他联系人、该叫救护车时立刻叫**——就已经是极大的帮助。

十、紧急联系卡（可抄到手机备忘录 / 打印放钱包）

```
==============================
   精神健康紧急联系卡
==============================
本人姓名：_____________
主治医院/科室：___________
主治医生/电话：__________
正在使用药物（不要自行停）：
   _________________________

【24小时心理援助】12356
【医疗急救】          120
【公安】              110
【北京心理危机热线（手机）】010-82951332
【北京心理危机热线（座机）】800-810-1117
【人社咨询】          12333
【法律援助】          12348
```

```
信任的人：
  姓名：_______ 电话：______
  姓名：_______ 电话：______

最近的有精神科急诊的医院：
  名称：_________________
  地址：_________________
  电话：_________________

【如果出现强烈不想活、安排后事、
  突然异常平静、自伤行为——
  不要让他独处，立即拨打120/12356，
  就近送精神科急诊。】
==============================
```

> 把这张卡**同时存在本人手机、信任的人手机里**。希望你永远用不上，但一定要有。

> **最后，请记住：** 一个人扛着的时候，很容易觉得"没人能帮我"。但这个国家从 2025 年起，专门为你留了一条 24 小时不收费的电话线——**12356**。拿起手机，你不需要准备好台词。

参考来源

- 国家卫生健康委员会：2025 年全国统一心理援助热线（12356）相关发布会与通知，http://www.nhc.gov.cn/
- 新华网：《"12356"：这条"没事儿"热线能帮你什么？》，2025-05-08，http://www.news.cn/gongyi/20250508/7b1f587584384cae94f78cce1f0e6656/c.html
- 国家心理健康和精神卫生防治中心（原国家精神卫生项目办）：https://ncmhc.org.cn/
- 北京心理危机研究与干预中心（回龙观医院）：北京市心理援助热线介绍，https://www.crisis.org.cn/lists/5.html
- 世界卫生组织（WHO）：*Suicide fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide
- 《中华人民共和国精神卫生法》（国家法律法规数据库 flk.npc.gov.cn）。

3. 复诊时机与联系医生

> **很多治疗失败不是因为药不对，而是因为"该复诊的时候没去、该说的症状没说、不该停的药自己停了"。这一页帮你把复诊节奏、必须联系医生的情况、和医生高效沟通的方法讲清楚。**
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。所有用药与剂量调整，请遵你的主治医生医嘱。

一、固定复诊节奏：不同阶段不一样

【临床共识】精神科治疗的复诊频率，是跟着"稳不稳"走的——越早期、越调整期，看得越勤；越稳定，间隔越长。下面是常见节奏，**具体以你的医生安排为准**：

阶段	常见复诊间隔	这个阶段医生在看什么
治疗初期（刚开始用药/心理治疗前 1–4 周）	1–2 周一次	药物耐受、早期副作用、症状变化趋势
调药期（加减药、换方案）	2–4 周一次	疗效是否出现、副作用能否耐受、剂量是否合适
稳定期（症状明显好转、方案固定）	1–3 个月一次	维持疗效、预防复发、评估能否减量
巩固/减药期（连续稳定数月后讨论停药）	4–8 周一次，逐步拉长	撤药反应、复发迹象、社会功能恢复

> 【个人体验】很多人觉得"我好得差不多了，就不去了"。恰恰相反——**稳定期的复诊是为了不让你重新掉回去**，它比你想象的便宜、也比复发一次便宜得多。

二、必须提前/临时联系医生的情况

以下情况**不要等到预约的复诊日**，应该主动联系医生（门诊加号、电话/线上问诊、必要时急诊）：

情况	为什么不能等
出现新的明显副作用：皮疹、严重恶心呕吐、手抖影响生活、持续头晕、性功能明显受影响、明显发胖	副作用可能需要调整剂量或换药，硬扛只会让你自行停药
症状明显加重：焦虑比上周重、惊恐发作变频繁、开始睡不着	可能需要提前调整方案，而不是等复发
睡眠急剧恶化：连续多日几乎无法入睡	失眠是焦虑复发和其他问题的早期信号
出现自伤/自杀念头，哪怕一闪而过	这是最高优先级，不要等，见《需要紧急就医的危险信号》
出现"睡很少却特别精神、话多、冲动消费"	警惕转躁，需医生评估是否双相谱系

情况	为什么不能等
遇到重大生活事件：亲人离世、分手、失业、搬家、家庭冲突	应激是复发常见诱因，医生可能要预防性调整
误服/漏服大量药物、怀疑药物相互作用（新加了别的科的药）	可能需要紧急处理
打算怀孕/备孕	药物需要提前个体化评估，不要自己突然停

> 【临床共识】**任何让你"心里不踏实"的变化，都值得打一个电话问医生。** 医生宁愿你多问，也不愿你自己猜。

三、如何与医生高效沟通：带上这三样

精神科门诊通常只有 10–20 分钟。**谁准备得充分，谁就能在有限时间里拿到更准的判断。** 建议每次复诊前准备好下面三样：

1. 症状日记（手机备忘录即可）

不用写长文，按天记关键词：

```
日期：10/15
睡眠：昨晚 2 点才睡，醒 2 次
惊恐：1 次（下午开会时，约 10 分钟）
情绪：上午烦躁，下午平稳
服药：早上忘吃一次，晚上补了
副作用：白天有点犯困
```

2. 量表分数（如果医生让你做）

很多医院会用 GAD-7（焦虑 7 项）、PHQ-9（抑郁 9 项）、PSQI（睡眠）等量表。**自己在家每 1–2 周做一次，把分数变化带给医生**，比"我感觉好点了"具体得多。

> 量表只是辅助，不能单独用来诊断或调药——但它是医生判断趋势的好工具。

3. 用药反应记录

- 现在每天吃哪几种、各多少剂量、几点吃；
- 吃了多久；
- 哪个症状先好转、哪个没变化；
- 出现了哪些副作用、从第几天开始。

一张表能省掉医生大量回忆时间。

四、复诊时可以直接问医生的问题清单

不知道说什么时，照着问：

- "我现在这个症状变化，算正常波动还是需要调方案？"
- "这个药大概还要吃多久？"
- "如果我出现 XX 副作用，是该减量、换药还是忍一忍？"
- "我大概什么时候可以讨论减量？"
- "我最近遇到 XX 事，需要预防性调整吗？"
- "如果我出差/回老家，药怎么带、复诊怎么衔接？"
- "我可以做心理咨询吗？和药物怎么配合？"

> 你有权让医生把"下一步计划"说清楚。如果医生说"先这样，下次再说"，你可以追问一句："那下次复诊我主要观察什么？"

五、春节 / 出差 / 异地：用药与复诊怎么衔接

这是很多人断药、复发的高发场景。提前规划：

场景	提前要做的事
春节回老家	回老家前多开 2–4 周药量（复诊时主动跟医生说"过年要回老家"）；带上药盒/处方，不要把药分装到小药盒里就觉得没事，万一要补药有凭证
长期出差	算好天数，多备 1 周缓冲；查好出差城市有精神科的医院；保留主治医生的联系方式/线上问诊渠道
搬家/异地长期居住	带上既往病历、用药记录、出院小结；到新城市后 1–2 周内挂上当地精神科，**不要凭老处方自己一直买药吃**
断药几天了	不要自己"加倍补回来"，立刻联系医生问怎么恢复

> 【个人体验】药盒上的药名、剂量、服用时间，拍张照存在手机里；病历本拍照备份。这些小动作在异地补药时能救命。

六、停药 / 减量：必须经医生

【临床共识】这是焦虑障碍治疗中最容易踩的坑：

- **症状刚好转就自行停药** → 复发率显著升高，且下次治疗更难。
- **想减量时突然停** → 可能出现撤药反应（头晕、电击感、失眠、焦虑反弹），被误认为"病更重了"。
- **要不要停、怎么停、停多久**，必须由医生根据你的病程、稳定时间、复发风险个体化决定。

> 你可以跟医生讨论减量，但**不要自己先减量再告诉医生**。

七、医生联系不上时的替代路径

打医生电话没接、线上问诊没人回、预约号挂满了——不要就此放弃，按下面顺序找替代：

1. **医院门诊/导诊台**：说明"正在服用精神科药物，有副作用/症状变化，需要加号"，很多医院有加号通道。
2. **药师门诊 / 用药咨询窗口**：药物相互作用、漏服、副作用这类问题，药师可以先给你应急建议。
3. **同科室其他医生**：主治医生不在时，同科室值班医生也能看你的病历。
4. **12356 心理援助热线**：先聊一聊，让接线员帮你判断紧急程度、推荐本地资源。
5. **急诊**：如果出现自伤念头、严重失眠进食困难、药物严重不良反应，不要等预约号——直接去有精神科急诊的医院。

> 联系不上医生 ≠ 没人管你。医院、热线、急诊，都是你的后路。

八、给自己建一份"就诊档案"

建议在手机里建一个备忘录文件夹，长期保存：

- [ ] 确诊名称（ICD/DSM 名称，问医生要）
- [ ] 主治医院、科室、医生姓名、出诊时间、联系方式
- [ ] 正在用的药名、剂量、服药时间、开始日期
- [ ] 既往用过但停掉的药、停药原因
- [ ] 做过的检查（心电图、甲功、血常规等）日期和结果
- [ ] 量表分数趋势
- [ ] 紧急联系人、12356、120、110

> 换医院、换医生、急诊时，这一份档案能让新医生在 5 分钟内了解你半年的病程。

> **最后，请记住：** 复诊不是"证明你好了"，而是"让医生帮你一直好下去"。主动联系医生不代表你脆弱，恰恰说明你在认真管理自己的健康。

参考来源

- NICE：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 美国精神病学协会（APA）：*Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder*（复诊与维持治疗原则同样适用于焦虑障碍）。
- 《中国焦虑障碍防治指南》（中华医学会精神医学分会）。
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：https://ncmhc.org.cn/
- 《中华人民共和国精神卫生法》。
- 北京心理危机研究与干预中心：https://www.crisis.org.cn/

模块 9

生活与社会支持

1. 与家人亲友沟通

> **焦虑最伤人的副作用之一，是它会让你身边的人不知道怎么接你——而他们的"不知道"，往往被你听成"不理解"。这一页给你准备好话术、应对表和边界设置，让你不必每次都从零解释。**
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断。

一、先理解：焦虑时为什么沟通这么难

【个人体验】焦虑中的人对沟通常有几种典型心理：

- **"说了他们也不懂，还会说我想太多"**；
- **"怕说了之后被另眼相看，尤其是父母"**；
- **"我连说话的力气都没有，更别说解释病情"**；
- **怕成为家人的负担，于是硬扛，扛到崩盘才被发现。**

这些感受都很真实。但研究告诉我们：**家人和朋友的理解与支持，是焦虑康复和预防复发的重要保护因素。** 问题不是"要不要说"，而是"对谁说、说多少、怎么说"。

二、三个版本的"解释话术"

不必对所有人和盘托出。下面是按对象分的三个版本，直接照抄也行。

对父母（尤其老一辈，最容易说"你就是想太多"）

> "爸、妈，我这段时间身体老不舒服——心慌、睡不着、莫名紧张，去医院查了心脏没大问题，医生说是**焦虑障碍**，是一种大脑预警系统太敏感的病，跟高血压糖尿病一样，是需要吃药和看心理医生的，不是我'小心眼'，也不是我闲的。
> 我现在在治疗，会慢慢好起来。你们不用专门劝我'想开点'，你们只要别太担心、正常过日子，就是帮我最大的忙。"
>
> 如果父母还是半信半疑：可以让他们陪你去一次复诊，让医生当面说。**医生一句话，顶你说十句。**

对伴侣（同住、朝夕相处的人）

> "我想认真跟你说一下我的情况。我被诊断为焦虑障碍，正在吃药和做心理治疗。
> 这个病发作的时候，我可能会突然心慌、想躲起来、不想说话，**那不是对你冷淡，是病在发作。**
> 我需要你的不是建议，而是：我发作的时候，你能陪我坐一会儿，跟着我一起慢慢呼吸；别反复说'你想开点'；我状态差的时候别逼我社交。
> 我也会尽量把我的状态告诉你，不让你猜。"

对朋友（不需要深入，只要不误解）

> "跟你说个事：我这段时间在应对焦虑，在治疗中。可能有时候我回消息慢、推掉聚会、约我出门我犹豫——**不是针对你，也不是不想交你这个朋友。**你愿意的话，偶尔约我散散步、听我抱怨两句，就帮大忙了。"

三、常见家人反应与应对

家人典型反应	背后可能是	你可以怎么应对
"你就是想太多/别想了"	不了解焦虑是疾病，以为是情绪问题	不争论，微笑着说："医生说是病，在治了。"把科普文章发给他
"别整天愁眉苦脸的，出去旅旅游就好了"	好心但不懂	"旅游可能以后有帮助，现在我先把药吃稳。"
过度保护：什么都不让你做、天天盯着你吃药	担心，但方式让你窒息	"我知道你担心我，但我也需要慢慢恢复自己做事。"
"你这样让我们也很崩溃"	家人自己也累	承认他们的感受："我知道你们也辛苦。"但不把"为了你们好起来"当成你的责任
否认/拒绝接受："我们家没人得过这种病"	病耻感	不强求他们立刻接受，先治疗自己；时间和你的好转会说话
反复追问"你什么时候能好"	焦虑和不确定	"医生说需要几个月，我会定期复诊。"给一个真实区间，比拍胸脯让他安心更可信

> 【争议观点】有些家人确实长期不理解、甚至贬低你。**你没有义务把每个人都教育成合格的支持者。**把精力留给真正愿意听的人。

四、提出"具体可操作"的帮助请求

人在被安慰时最累的，是不知道"我具体该做什么"。你越具体，对方越容易帮到你：

模糊的求助	更具体、对方更好接的版本
"我好难受"	"你能陪我下楼走 20 分钟吗？不聊病也行。"
"我谁都不想见"	"今天不用长聊，你陪我坐着、各看各的手机也行。"
"帮帮我"	"今晚我可能忘吃药，你晚上八点提醒我一下好吗？"
"你能不能劝劝我"	"你不用给建议，就听我说完，告诉我'我在'就够了。"
"陪我去医院"	"周六上午陪我去复诊，帮我记一下医生说的话。"

几个特别适合家人做的小事：

- 发作时陪你做 4-7-8 呼吸（吸气 4 秒、屏 7 秒、呼 8 秒）；
- 提醒你按时服药，但不要翻包检查；

- 复诊时陪诊、帮你记医嘱；
- 一起按时吃饭、晚上一起散步 10 分钟——不催促，只同行。

五、给家人看的一段科普（可直接转发）

> "焦虑障碍不是'想太多'，而是大脑里的预警系统长期过于敏感——就像烟雾报警器太灵敏，炒个菜也响。它是一种有明确生物学基础、可治疗的疾病，和高血压、糖尿病一样需要规范治疗。
> 正在吃药的人，请不要劝他'是药三分毒别吃了'——自行停药复发的代价远大于药物副作用。
> 你能做的最好的事：不评判、不催促'想开点'、在他发作时陪着、帮他按时复诊。"

六、家人不理解时的自我保护

如果最该支持的家人反而否定、指责你：

- **不必争**："你就是矫情""出去走走就好了"——微笑着不接话，把精力留给真正支持你的人。
- **守住隐私边界**：你有权只告诉"需要知道的人"，不必对全家族公开。
- **找别的支持**：医生、心理治疗师、12356 热线、同事、朋友、正规线上康复者社群——支持网不是只能靠家人。
- **处理你自己的病耻感**：别人怎么说是别人的事，你对自己病情的态度，决定了你能不能理直气壮地治疗。

> 【个人体验】很多康复者最终的支持网，并不是一开始最亲的家人，而是"半路遇到的、懂你的人"。支持是可以重新选择和建立的。

七、伴侣 / 亲子中的边界

和伴侣：
- 焦虑发作期你可能不想亲热、不想说话、对什么都没兴趣——这是病，不是对伴侣没感情。提前说清楚。
- 不要把"你必须陪我"变成控制；也不要把伴侣的疲惫当成"他不爱我了"。
- 关系里的大事（钱、工作、要不要孩子），尽量在你状态平稳时讨论，别在发作高峰做决定。

和父母 / 成年子女：
- 如果你是患者本人：告诉父母"我在治疗，不需要你们全天候盯着"，把边界讲清楚。
- 如果你是青少年患者的家长（或家里有青少年焦虑）：不要把问题归为"青春期叛逆"，持续两周以上的厌学、躲房间、身体查不出问题的不适，要认真对待。
- 不要在孩子面前反复说"都是我们害了你"——内疚是焦虑的燃料。

八、一张表：你的支持系统地图

把你身边的人按下面四类填一填：

类别	我可以找谁	能提供什么	联系方式
能倾诉情绪的人	（朋友/家人）	听我说、不评判	

类别	我可以找谁	能提供什么	联系方式
能办实事的人	（家人/同事）	陪看病、提醒吃药、帮忙跑腿	
能一起"待着"的人	（朋友）	不用说话也舒服的陪伴	
专业支持	（医生/治疗师/热线）	诊断、治疗、危机干预	医生电话：____；12356

> 如果某几栏是空的，没关系——这正是你接下来可以慢慢搭建的。

> **最后，请记住：** 你不需要一次让所有人都理解你。先找到一个人，发出第一条消息。人是在关系里被治愈的。

参考来源

- NICE：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 世界卫生组织（WHO）：*Mental health of adults fact sheet*. https://www.who.int/
- 世界卫生组织（WHO）：*LIVE LIFE*（社会联结与保护因素）. https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
- 《中国焦虑障碍防治指南》（中华医学会精神医学分会）。
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：https://ncmhc.org.cn/
- 北京心理危机研究与干预中心：https://www.crisis.org.cn/

2. 工作学习场景应对

> **焦虑不会因为你坐在办公室/教室里就停下来——恰恰相反，开会、汇报、考试、宿舍社交，都是它高发的场景。这一页给你一套"要不要说、怎么说、发作了怎么办、怎么设边界"的实操方案。**
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断。涉及具体劳动权益与学籍政策，以你所在单位/学校和当地法规为准。

一、要不要告诉单位 / 学校

这是一个**隐私选择**，不是义务。判断原则：

告诉的好处	不告诉的理由
可以申请弹性时间、减少高压任务、考试安排调整	担心被贴标签、影响晋升/评优
发作时有人知道怎么帮你	病情尚未稳定、自己还没准备好
定期复诊需要请假，有合理理由	病情已经很稳定、不影响工作学习

常见做法是"有限披露"：告诉直接相关的一两个人（你的直属领导、一个信任的同事/辅导员），而不是全公司/全班公开。

告诉谁、怎么说

对领导 / HR（按需）：

> "我最近因为健康原因在接受治疗，需要定期去医院复诊。工作上我会尽量安排好，不影响交付。如果某些时候状态不好，我可能需要临时调整一下节奏，谢谢你的理解。"
>
> 不必说具体诊断名称；你有权只说"健康原因"。

对辅导员 / 班主任：

> "我最近在医院诊断出焦虑相关的问题，在治疗中。可能需要偶尔请假复诊，考试期间如果状态不好，希望学校能有合理的安排。"
>
> 【临床共识】**病历和就诊记录受隐私保护。**单位/学校无权要求你出示诊断证明；但如果你要申请病假、考试缓考、岗位调整，通常需要医院开具的病假建议书——这是你自愿提供的，不是被要求的。

二、合理调整请求：具体怎么提

模糊的"我状态不好"很难被批准，**具体、可操作、不影响核心工作**的请求更容易被接受：

场景	可提的具体请求
复诊	"每周三下午我固定请假 2 小时去医院，工作我提前交接。"

场景	可提的具体请求
弹性时间	"能否允许我偶尔晚到 1 小时/在家办公半天，我会保证交付。"
减少高压任务	"近期我状态不太适合带大型对外汇报，能否先做支持性工作？"
出差	"这两个月能否不安排长途出差，我在本地远程支持。"
考试	凭医生病假建议申请缓考、延长考试时间、单独考场等
宿舍	申请调宿舍、减少夜间集体活动（学生）

> 提请求时，**带上医生的建议**（病假条、就诊记录），比"我觉得"有说服力得多。

三、职场焦虑高发场景的具体应对

【临床共识】职场里的焦虑触发点非常集中。下面是高频场景和应对：

触发场景	发作时的即时应对	长期练习
开会发言 / 汇报	提前写好提纲；发言前做 3 次缓慢呼吸；手抖就拿笔；告诉自己"说错也没关系"	从短发言开始逐级暴露（先在小会说 1 分钟 → 大会 → 汇报）
绩效 / 年终评估	提前把成果列成清单，不要凭感觉；评估后给自己留一段"恢复期"	把"被评价"拆成具体反馈，而不是"我整个人被否定"
社交饭局 / 团建	提前和一个信得过的同事约好"我们坐一起"；允许自己提前离席；不必喝酒	逐步延长在场时间，从 30 分钟开始
被领导突然叫去	去之前先做一次深呼吸；路上允许自己"腿软"，腿软不代表不能走路	事后记录"我担心的最坏结果发生了吗"——大多没有
deadline 高压	把任务拆到半天粒度；每完成一小块就休息 5 分钟	识别"灾难化想法"："做不完=被开除"通常不成立

四、学生场景：课堂、考试、宿舍

场景	应对
课堂被点名发言	提前和老师说"我紧张的时候可能说不完整，请允许我坐下继续说"；紧张时允许自己慢一点
考试焦虑	考前一周规律作息、不要突击咖啡；进考场前做 4-7-8 呼吸；手抖就先写名字、先做会做的题
考试发挥失常后	焦虑会扭曲记忆——考完觉得"全砸了"，往往比真实结果差。先别做重大决定，等成绩出来
宿舍社交压力	不必强迫自己融入所有夜聊；戴耳机、去图书馆是合理的自我保护；必要时申请调宿舍
和同学冲突后	急性焦虑期不要发长消息解释、不要做"以后再也不理谁"的决定；睡一觉再说

> 【个人体验】学生时期最伤人的是"我是不是只有我这样"。其实教室里至少三分之一的人都在偷偷心慌，只是没人说。

五、惊恐发作在公司 / 学校突发怎么办

这是很多人最怕的场景。提前准备好，真发作时就不慌：

1. **识别**：心跳快、胸闷、手麻、"我要晕倒了"——你认得出这是惊恐发作，就已经赢了一半。
2. **离场**：跟身边人说一句"我去下洗手间/接个电话"，走到安静、通风的地方（楼梯间、空会议室、操场边）。
3. **呼吸**：4-7-8 呼吸（吸 4 秒、屏 7 秒、呼 8 秒）做 3–5 轮；或 5-4-3-2-1 接地法（说 5 个看到的、4 个摸到的、3 个听到的）。
4. **告诉自己**："这是惊恐发作，不会死，10 分钟内会过去。"
5. **如果半小时还没过去、或这是第一次这么重**：让信任的同事/同学陪你去校医院/附近急诊排查一次。

> 【临床共识】惊恐发作本身**不会直接致命**，但**首次出现、或伴随胸痛放射/冷汗时，必须先去急诊排除心脏问题**——这是规则，不是吓自己。

六、病休 / 复学 / 复工：节奏与权益提示

- **不要硬撑到崩溃才休**：医生会根据你的状态开病假建议；早期短期调整，往往比拖到必须长休便宜。
- **复工/复学不要一步到位**：和医生、单位/学校商量，从半天、少量任务开始，逐步恢复全职。
- **权益底线**：根据《精神卫生法》《劳动合同法》及地方规定，精神疾病患者在医疗期内享有相应保护；单位不能仅凭"你有精神疾病"就直接辞退。具体条款拿不准，可以打 **12333**（人社咨询）或 **12348**（法律援助）问。
- **不要把病历主动广而告之**：病假条只给需要审批的人，不给八卦的同事。

> 本节只做方向性提示，不展开法律细节。真正遇到纠纷，找专业法律渠道。

七、设置边界与减少刺激的实操

日常边界	怎么做
咖啡因	焦虑明显时，咖啡/浓茶/能量饮料减到每天 1 杯以内，下午 2 点后不喝
酒精	不要用喝酒缓解焦虑——它短期放松，长期加重焦虑和失眠
屏幕时间	睡前 1 小时不刷短视频/工作群；工作群设置"免打扰时段"
社交负荷	一周只安排 2–3 个社交活动，其余留给自己恢复
信息输入	少刷"焦虑测试""抑郁症清单"类内容——越对号入座越焦虑
身体底线	每天尽量同一时间睡、同一时间起；每周 3 次 30 分钟中等强度运动
拒绝权	练习说"这次我不参加了"，不必每次都给长理由

八、一张表：你的职场/校园焦虑急救卡

```
==============================
  我的焦虑急救卡
==============================
我信任的同事/同学：_____ 电话：_____
可以去的安静地方：_____________
最近的急诊/校医院：_____________
医生电话：_____  热线：12356

发作时告诉自己：
"这是惊恐发作，不会死，
 10 分钟内会过去。"
我可以做的：呼吸 4-7-8 × 5 轮。
==============================
```

> 存手机里。希望你用不上，但真发作时它能让你少慌一半。

> **最后，请记住：** 你不是在"带病混日子"，你是在一边治疗一边生活。允许自己慢一点、允许自己申请调整、允许自己在必要时离场——这不是软弱，是长期主义。

参考来源

- NICE：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 世界卫生组织（WHO）：*Mental health in the workplace*. https://www.who.int/
- 《中国焦虑障碍防治指南》（中华医学会精神医学分会）。
- 《中华人民共和国精神卫生法》《中华人民共和国劳动合同法》（国家法律法规数据库 flk.npc.gov.cn）。
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：https://ncmhc.org.cn/

3. 康复期常见困境

> **康复不是一条向上的直线，而是波浪式前进——症状好转、波动、再好转。这一页把康复路上最常见的 7 种困境列出来，每个都给你"内心独白 → 客观视角 → 可做的一小步"，让你在低谷时知道自己不是第一个、也不是唯一一个。**
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断。

一、反复发作与波动时的挫败感

【个人体验】最让人崩溃的不是症状本身，而是"我明明好了，怎么又回来了"。

- **常见内心独白**："白治了""我这辈子是不是就这样了""别人都能好，就我不行"。
- **客观视角**：【临床共识】焦虑障碍本身就有波动特点，尤其在压力大、睡眠差、季节变化时。一次波动不等于复发失败——它更像一次"数据"，告诉你最近哪里压力过载了。研究显示，规范治疗的患者多数能获得显著改善，波动是过程，不是判决。
- **可做的一小步**：拿出症状日记，写下"这次波动前发生了什么"（睡眠？工作压力？咖啡因？），而不是急着否定自己。下次复诊带给医生看。

二、病耻感与自我污名

- **常见内心独白**："我得这个病说出去，别人会怎么看我""我是不是很丢人""我不敢让同事知道"。
- **客观视角**：【临床共识】焦虑障碍是最常见的精神障碍之一，人群中终身患病率不低。它和高血压一样是疾病，不是性格缺陷。真正该被改变的是社会偏见，但你能先改变的，是**你对自己的态度**。
- **可做的一小步**：先对一个你信任的人说一次；把"我有精神病"这种自我标签，换成"我在治疗焦虑障碍"。语言会慢慢改变感受。

三、"我是不是一辈子都这样"的无望感

- **常见内心独白**："这个病会不会跟我一辈子""我再也不能像正常人一样生活了"。
- **客观视角**：【研究结论】规范治疗（药物 + CBT 心理治疗）的患者，多数能在数月到一年内获得显著改善，相当一部分人长期缓解、恢复正常工作生活。"一辈子吃药"不是必然——很多人在稳定足够久后，在医生指导下逐步减量甚至停药。但具体到你，时间是个体化的。
- **可做的一小步**：把"一辈子"这个大问题，换成"这周我能做什么让自己舒服一点"。大问题吓死人，小问题可执行。

四、家人疲惫与关系张力

- **常见内心独白**："我拖累了全家""我妈跟我说话都小心翼翼，我喘不过气""他们累了，我是不是更该自己扛"。

- **客观视角**：照顾一个慢性疾病患者确实会耗竭家人——这是真实的，不是你"想多了"。但**你硬扛着不说，反而让他们更没抓手**。给家人一些准确的科普（见《与家人亲友沟通》），他们知道"病在治、有期限、会好转"，焦虑会减轻很多。
- **可做的一小步**：跟家人说一句："我知道你们也辛苦，我在好好治疗，我们一起慢慢走。"也鼓励他们找自己的喘息空间。

五、社交退缩后的重新连接

- **常见内心独白**："我都消失这么久了，谁还会理我""我现在状态这么差，见了面也只会让人扫兴"。
- **客观视角**：【临床共识】社交退缩会让焦虑加重，形成恶性循环。但重新连接不需要一步到位——从最轻松的接触开始，逐级往上（点赞 → 发消息 → 短电话 → 散步 → 深聊）。大多数朋友会高兴你回来，而不是计较你消失了多久。
- **可做的一小步**：今天给一个老朋友发一条短消息，比如"最近怎么样？我前段时间状态不太好，现在在恢复。"不用长，不用解释太多。

六、经济压力与治疗成本

- **常见内心独白**："药费、心理咨询费、请假扣的钱，我扛不住了""是不是不该治了"。
- **客观视角**：焦虑障碍治疗费用确实是现实问题，但有不少减负路径：精神科药物多数在医保目录内；很多城市的公立医院心理咨询按医保政策报销一部分；社区卫生服务中心、公立精神卫生中心的费用通常低于商业机构；12356 热线是免费的。
- **可做的一小步**：下次复诊时直接问医生/医院社工："哪些药进了医保？有没有更经济的方案？"公立医院医生通常愿意帮你一起算这笔账。

七、"假痊愈"陷阱：症状一好就停药停练习

这是康复期最危险、也最常见的坑。

- **常见内心独白**："我都好了，吃药干嘛？""练习太麻烦了，我都这样了应该不用了吧"。
- **客观视角**：【临床共识】焦虑障碍的药物治疗通常需要在症状缓解后继续维持数月到一年以上，目的是预防复发。症状刚好转就自行停药，复发率显著升高；下次再治，往往要从头开始。"假痊愈"是指症状被药物压住了，但大脑的预警系统还没完全稳定——停药等于撤掉护栏。
- **可做的一小步**：想减量或停药时，**先跟医生约一次复诊**，把你的想法说出来。医生会根据你稳定了多久、复发风险，给你一个时间表。慢一点，是为了不重来。

八、一张表：康复期困境速查

困境	一句话提醒	第一步做什么
又波动了	波动是数据，不是失败	写日记找诱因
病耻感	焦虑是病，不是丢人的事	告诉一个信任的人
"一辈子完了"	多数人能显著改善	问"这周能做什么"

困境	一句话提醒	第一步做什么
家人累了	他们需要准确信息	转发一段科普
不敢社交	从最轻的接触开始	发一条短消息
钱不够	医保+公立+热线	问医生有没有更省的方案
想停药	停药必须经医生	约一次复诊

> **最后，请记住：** 康复路上的每一次"我又撑过来了"，都在让下一次更容易。你不是在回到过去的自己，而是在长成一个更了解自己、更会照顾自己的人。

参考来源

- NICE：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 世界卫生组织（WHO）：*Mental health of adults* 与 *LIVE LIFE*. https://www.who.int/
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Anxiety Disorders*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- 《中国焦虑障碍防治指南》（中华医学会精神医学分会）。
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：https://ncmhc.org.cn/
- 北京心理危机研究与干预中心：https://www.crisis.org.cn/

模块 10

常见Q&A

1. 高频问答QA

> **这一页收集了焦虑障碍患者最常问医生、也最常自己搜着吓自己的问题。答案尽量客观、安抚但不夸大——不说"包好"，也不说"完蛋"。所有问题都不能替代面诊，具体用药和诊断请听你的主治医生。**
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

Q1. 焦虑能不能完全治好?

【临床共识】"治好"要分两层说。**症状层面**：规范治疗（药物 + CBT 认知行为心理治疗）的患者，多数在数月到一年内获得显著改善，很多人恢复正常工作生活。**根因层面**：焦虑有一定的性格和生物学基础，不保证"一辈子不再有任何焦虑"——但你可以学会和它相处，让它不再主导你的生活。研究显示，做过 CBT 的人，停药后复发率比单纯吃药的人低一些，因为学到的应对技能是长期的。简单说：**能大幅好转、能恢复正常生活，不保证永不复发，但复发了也能再治。**

Q2. 焦虑会变成精神病 / 精神分裂症吗?

不会。 【临床共识】焦虑障碍和精神分裂症是两类不同的疾病，神经机制、症状表现、治疗都不同。焦虑不会"恶化"成精神分裂症。你之所以会担心这个，恰恰是焦虑在发作时把"最坏结果"放大了——这叫"对症状的灾难化解读"。

不过有两种情况要让医生评估：一是焦虑严重到出现**短暂的现实检验丧失**（比如坚信身体已经"坏了"查不出来、坚信有人害自己），这不是焦虑本身会变，而是可能合并了其他问题；二是某些双相谱系的患者早期也会以焦虑为主诉出现。出现这些信号，交给医生判断，不要自己对着症状吓自己。

Q3. 长期焦虑会不会把身体器官弄坏?

【临床共识】焦虑本身**不会直接把心脏、胃、脑子"弄坏"**——惊恐发作时心跳很快，但短短十几分钟不会造成心肌损伤。但长期未治的慢性焦虑确实会通过两条路影响身体：一是**持续的高皮质醇状态**，和失眠、高血压、胃肠功能紊乱、免疫力下降有相关性；二是**行为后果**——靠喝酒、不运动、不睡觉来扛焦虑，这些才是真正伤身体的。

所以答案是：焦虑不会直接毁掉器官，但长期不管它，它会通过影响你的生活方式间接拖垮身体。**治疗焦虑，也是在保护身体。**

Q4. 心理咨询一般多久见效?

【研究结论】以一线推荐的 CBT 为例：**很多人在 4–8 次咨询后开始感觉到变化**（通常每周一次），完整疗程一般 8–20 次，因人而异。前几次往往是"评估 + 建立关系 + 教你识别想法"，不是立刻见效；真正的改变通常在中段，当你开始练习暴露、调整思维之后。

但请记住：个体差异很大。有人 3 次就松了，有人要十几次才松动。**如果做了 6–8 次完全没感觉，可以和治疗师讨论，或换一个治疗师/流派**——不匹配不是你的错。药物和心理治疗常配合使用，不是二选一。

Q5. 惊恐发作会不会猝死或晕倒?

【临床共识】**典型的惊恐发作本身不会直接致死，也很少真的晕倒。** 发作时心跳快、血压升高、过度换气，但这些通常在几分钟到十几分钟内自行回落。晕倒更多是因为过度换气后血糖/体位性低血压，不是心脏停了。

但有两个例外必须认真对待：**一是第一次发作、或发作时伴胸痛放射到左肩/下颌、伴冷汗、既往有心脏病史**——必须先去急诊排除心脏问题；**二是反复在类似场景发作**，说明需要规范治疗，而不是硬扛。惊恐发作的"濒死感"是真的难受，但它的生物学结局通常是安全的。

Q6. 心慌胸闷要不要先查心脏?

要。 【临床共识】这是规则，不是吓自己。尤其满足以下任一情况：**首次出现**、**程度远超以往**、**伴放射痛/冷汗/晕厥**、**有心脏病史或家族史**——先去心内科/急诊做心电图、心肌酶等基础排查。

很多焦虑障碍患者就是这样被"排查一圈没事"后才转诊到精神科的，这是正常路径。**排查完没事，你以后对惊恐发作的信心反而更足；真有事，抢的就是时间。** 不要因为"觉得自己是焦虑"就硬扛。

Q7. 吃药会依赖吗?

【临床共识】要分两类说清楚：

- **SSRI / SNRI 类抗抑郁药**（比如各种"西汀""舍曲林""文拉法辛"）：**不成瘾。**它们不是镇静药，不会越吃越想吃、不会带来快感。但长期服用后突然停药，可能出现撤药反应（头晕、电击感、失眠、焦虑反弹）——这不是"成瘾"，而是身体需要慢慢减量，必须在医生指导下停。
- **苯二氮䓬类**（比如阿普唑仑、劳拉西泮、氯硝西泮）：**短期使用、有依赖风险。**医生通常只在急性期短期开，或按需偶尔用，不建议长期连续吃。

所以答案是：一线抗焦虑/抗抑郁药不成瘾，苯二氮䓬类短期用要谨慎。**不要因为怕"依赖"就拒绝必要的药物治疗。**

Q8. 喝酒能不能缓解焦虑?

短期能，长期是火上浇油。 【临床共识】酒精是中枢抑制剂，喝下去前半小时确实会放松，但它会破坏睡眠结构、降低明天的焦虑阈值、干扰抗焦虑药代谢，还容易越喝量越大。临床上大量患者是"靠酒入睡"，最后变成酒精依赖 + 焦虑加重。

偶尔少量红酒不是禁忌，但**不要把酒当成抗焦虑药来用。**如果你发现自己每天不喝就慌、不喝就睡不着，这本身就是要告诉医生的信号。

Q9. 咖啡 / 奶茶 / 浓茶还能不能喝?

【临床共识】咖啡因是中枢兴奋剂，和焦虑、惊恐发作有明确相关性——它会让心跳加快、手抖、紧张感放大。焦虑明显的人，建议：**每天不超过 1–2 杯**，下午 2 点后不喝（它同时破坏睡眠），惊恐发作频繁的时期先减半或停一段时间。

奶茶里的茶底咖啡因不低，还加糖，也在管控范围。**不是永远不能碰，而是先减量、观察自己的反应**——很多人减咖啡后惊恐发作明显减少。

Q10. 焦虑时能不能开车 / 上高速 / 坐飞机?

- **开车**：如果你正在惊恐发作中，**不要开**，把车停到安全地方。平时通勤，焦虑稳定后可以开，但避免在刚吃完药（可能犯困）、严重失眠后开。
- **上高速**：场所恐惧的患者可能对高速、隧道、桥有强烈恐惧。建议**先在治疗师指导下做暴露练习**，从短途、有人陪伴开始，不要独自硬闯。
- **坐飞机**：飞行恐惧很常见。短期可以和医生讨论"飞行前按需用短效药"；长期靠 CBT 暴露练习。**首次坐飞机前，不要自己喝酒压惊。**

> 原则：**正在发作时，不要做需要集中注意力和反应速度的事。**

Q11. 怀孕、备孕、哺乳期间用药怎么办?

【临床共识】这是**必须由医生个体化权衡**的事，不要自己突然停药、也不要自己继续吃。

- **备孕**：如果病情稳定，可以和医生讨论是否提前调整为妊娠相对更安全的药物；如果病情不稳定，突然停药导致复发，对孕妇和胎儿的风险可能比药物还大。
- **孕期**：多数 SSRI 在孕期不是绝对禁忌，获益风险由医生根据你的病程判断。
- **哺乳**：部分药物有少量进入乳汁，医生会选择相对更安全的品种和剂量。

一句话：发现怀孕或计划怀孕，第一时间告诉你的精神科医生，和产科医生一起商量，不要自己做决定。

Q12. 孩子 / 青少年焦虑怎么办，和大人一样吗?

【临床共识】儿童青少年焦虑很常见，表现和大人不太一样：孩子更多表现为**躯体不适**（肚子痛、头痛、不想上学）、黏人、发脾气，而不是"我很焦虑"这种抽象表达。

要认真对待的信号：**持续两周以上**厌学、躲房间、身体查不出问题的不适、睡眠恶化、提到"活着没意思"。治疗上，儿童青少年**首选心理治疗**（CBT），药物由儿童精神科医生严格评估后使用，和成人方案不完全一样。不要把它归为"青春期叛逆""就是懒"。

Q13. 社交焦虑是不是就是性格内向?

【临床共识】不是。**内向**是一种气质——你喜欢独处、独处时充电，不痛苦；**社交焦虑障碍**是一种疾病——你在社交场合被强烈的恐惧、脸红、手抖、怕被评价抓住，哪怕你理智上知道"没什么可怕的"，身体还是反应剧烈，严重时会回避一切社交，影响上学、工作、恋爱。

内向的人可以在派对上安静地待着但舒服；社交焦虑的人待在派对上像受刑。如果后者让你功能受损（不敢发言、不敢面试、不敢交新朋友），这是可以治疗的，CBT 对社交焦虑效果很好。

Q14. 反复检查、反复洗手、停不下来的念头，是不是焦虑?

可能是，但要和强迫症（OCD）区分。 【临床共识】焦虑障碍和强迫障碍都属于焦虑谱系，但表现不同：

- **广泛性焦虑**：担心的是现实生活中的事（工作、健康、家人），担心停不下来但你不觉得它"不合理"。

- **强迫症**：出现**闯入性的、自己觉得没必要但停不下来的念头**（比如"我是不是没锁门""手是不是脏了"），靠反复检查/洗手/数数来缓解，花掉大量时间，你理智上知道过分但控制不住。

如果你有后者，告诉医生——OCD 的治疗方案（尤其是药物剂量和暴露反应阻止疗法）和普通焦虑不完全一样。不要自己硬扛。

Q15. 运动到底有没有用?

【研究结论】**有用，但它是辅助，不是替代治疗。** 规律的有氧运动（快走、慢跑、游泳、骑车），每周 3–5 次、每次 30 分钟左右，对轻中度焦虑和抑郁有明确改善作用，机制和调节神经递质、改善睡眠、降低肌肉紧张有关。

但注意：**严重焦虑发作期，不要强迫自己跑 5 公里**——那会变成另一个压力源。从散步、八段锦、瑜伽开始，让身体动起来但不累。运动不能替代药物和心理治疗，它是给治疗"加分"的。

Q16. 症状好转后又复发了怎么办?

【临床共识】复发很常见，**不等于你失败了。**处理方式：

1. **不要恐慌**：先识别这次复发的诱因（睡眠？压力？自己减药了？重大事件？）。
2. **不要自行加药/停药**：联系医生，把症状日记带上。
3. **回顾你之前有效的方法**：药物、CBT 技巧、运动、呼吸练习——它们这次依然有效，而且你已经有经验了。
4. **和医生讨论维持治疗多久**：复发过的人，通常需要更长时间的维持治疗，或更长疗程的心理治疗。

每一次康复，你都比上一次更了解自己的触发点和应对方式——**第二次复发通常比第一次好处理。**

Q17. 焦虑会遗传给孩子吗?

【临床共识】焦虑有一定的遗传倾向——如果父母有焦虑障碍，孩子患焦虑的风险比一般人群高一些，但**这不是"注定"**。环境（教养方式、压力事件）和遗传共同起作用。你能做的：不在孩子面前反复灾难化、不过度保护、自己规范治疗——你的稳定，就是孩子最好的保护。

Q18. 失眠怎么办?

【临床共识】失眠常和焦虑互为因果。先做睡眠卫生：固定起床时间（比固定入睡时间更重要）、睡前 1 小时不刷手机、下午 2 点后不喝咖啡、床只用来睡觉不用来工作。如果持续 1 个月以上、白天严重受影响，告诉医生——**不要自己长期吃褪黑素/安眠药**，苯二氮䓬类长期用有依赖风险，医生会评估是处理焦虑本身，还是用短程的非苯二氮䓬类助眠药 + CBT-I（失眠的认知行为治疗）。

Q19. 正念 / 冥想没用，是不是我不适合?

【个人体验】很多人第一次做正念时觉得"脑子更乱了"——**这很正常，不是你不适合。**正念的目标不是"清空脑子"，而是"观察念头而不被它带走"。前几次觉得乱，是因为你第一次注意到自己脑子里有这么多念头。建议：从 5 分钟开始、跟着引导音频做、不要追求"没杂念"。如果试了几周还是非常烦躁，可以换身体扫描、渐进式肌肉放松这类更"身体导向"的练习。

Q20. 网上的心理咨询靠谱吗?

【争议观点】**线上咨询本身可以是靠谱的**——很多公立医院和正规心理平台都提供视频咨询，疫情后大量研究证实线上 CBT 效果和线下接近。但要甄别：

- ✅ 优先选：公立医院心理科、有正规资质的心理平台、咨询师有国家认可的受训背景和督导；
- ❌ 避开：只留微信号的"情感导师"、收费高但说不清受训背景的、劝你停药的、卖课的。
- 线上咨询适合轻中度情绪困扰和 CBT；**如果你有自伤念头、严重失眠进食困难、药物调整需求，优先线下面诊/急诊。**

Q21. 身边人发作时我该做什么?

（详见《需要紧急就医的危险信号》《国内心理危机热线与求助渠道》）

简单版：**不评判、不离开、帮他联系人、该打 120 就打 120。** 不要说"你想开点""这点事至于吗"；不要让他一个人"静静"；不要承诺替他保密（安全比保密重要）。你不需要会心理辅导——在场、稳定、帮他拨号，就已经是极大的帮助。

> **最后，请记住：** 这些问题之所以被问这么多次，是因为几乎每个焦虑的人都问过。你不是怪物，不是唯一一个。**有问题、敢问、找专业的人问，本身就是康复的开始。**

参考来源

- NICE：*Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113)*. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Anxiety Disorders*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- 世界卫生组织（WHO）：*Mental health of adults fact sheet*. https://www.who.int/
- 《中国焦虑障碍防治指南》（中华医学会精神医学分会）。
- 美国精神病学协会（APA）：*Obsessive-Compulsive Disorder* 相关指南（Q14 区分 OCD）。
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：https://ncmhc.org.cn/